

Bunga Rampai **KESEHATAN IBU, ANAK DAN REMAJA**

Pendekatan Interprofesional Untuk Indonesia Sehat 2045

Yayuk Puji Lestari • Subriah • Anggun Fajar Ramadhani
Ety Nurhayati • Dewi Sari Rochmayani • Indra Tri Astuti
Esa Rosyida Umam • Sri Musfiroh

Editor : Anita



BUNGA RAMPAI
KESEHATAN IBU, ANAK, DAN REMAJA:
PENDEKATAN INTERPROFESIONAL UNTUK
INDONESIA SEHAT 2045

Penulis:

Yayuk Puji Lestari, SST., Bdn., M.Keb.

Subriah, S.ST., M.Kes.

Anggun Fajar Ramadhani, S.Kep., Ners., M.Kep.

Ety Nurhayati, S.Kp., M.Kep., Ns., Sp.Kep.Mat.

Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes (Epid).

Ns. Indra Tri Astuti, M.Kep., Sp.Kep.An.

Ns. Esa Rosyida Umam, S.Kep., M.Kep.

Sri Musfiroh, S.Si.T., M.Kes.

Editor:

Dr. Ns. Anita, M.Kep., Sp.Mat.



BUNGA RAMPAI KESEHATAN IBU, ANAK, DAN REMAJA: PENDEKATAN INTERPROFESIONAL UNTUK INDONESIA SEHAT 2045

Penulis:

Yayuk Puji Lestari, SST., Bdn., M.Keb.
Subriah, S.ST., M.Kes.
Anggun Fajar Ramadhani, S.Kep., Ners., M.Kep.
Ety Nurhayati, S.Kp., M.Kep., Ns., Sp.Kep.Mat.
Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T., M.Kes (Epid).
Ns. Indra Tri Astuti, M.Kep., Sp.Kep.An.
Ns. Esa Rosyida Umam, S.Kep., M.Kep.
Sri Musfiroh, S.Si.T., M.Kes.

Editor: Dr. Ns. Anita, M.Kep., Sp.Mat.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7556-46-2

Cetakan Pertama : Februari, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku “Bunga Rampai Kesehatan Ibu, Anak, dan Remaja: Pendekatan Interprofesional untuk Indonesia Sehat 2045” dapat disusun dan diselesaikan. Buku ini hadir sebagai upaya kontribusi akademik dan praktis dalam memperkuat pelayanan kesehatan yang terpadu, berkesinambungan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya pada kelompok ibu, anak, dan remaja sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia.

Kesehatan ibu, anak, dan remaja merupakan fondasi penting dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Tantangan yang dihadapi saat ini tidak hanya berkaitan dengan aspek klinis, tetapi juga dipengaruhi oleh determinan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, serta akses dan mutu layanan kesehatan. Perubahan pola penyakit, isu gizi, kesehatan mental, kekerasan berbasis gender, kesehatan reproduksi remaja, hingga ketimpangan layanan di berbagai wilayah menuntut adanya langkah strategis yang melampaui pendekatan sektoral. Karena itu, pendekatan interprofesional menjadi kunci dalam menghadirkan layanan yang lebih efektif, aman, dan responsif terhadap kebutuhan individu maupun keluarga.

Buku bunga rampai ini memuat kumpulan tulisan yang menggambarkan perspektif, kajian, serta pengalaman penerapan kolaborasi lintas profesi dalam berbagai konteks pelayanan dan program kesehatan. Pembahasan mencakup upaya promotif dan preventif, penguatan pelayanan primer, peningkatan mutu asuhan maternal dan neonatal, pemantauan tumbuh kembang anak, penanganan masalah gizi, kesehatan mental dan psikososial, hingga isu-isu kesehatan remaja yang relevan dengan perkembangan zaman. Setiap bab diharapkan dapat memperkaya wawasan pembaca mengenai pentingnya komunikasi efektif, koordinasi layanan, serta pengambilan keputusan bersama yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan etika profesi.

Buku ini disusun untuk menjadi referensi bagi mahasiswa dan dosen bidang kesehatan, tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan, pengelola program, serta pemangku kebijakan yang memiliki perhatian terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu, anak, dan remaja. Besar harapan kami, buku ini dapat mendukung penguatan kompetensi kolaboratif, mendorong inovasi layanan, serta memperkuat

sinergi lintas profesi dan lintas sektor dalam rangka mencapai visi Indonesia Sehat 2045.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh penulis yang telah berkontribusi dengan pemikiran dan karya terbaiknya, serta kepada semua pihak yang turut membantu dalam proses penyusunan, penyuntingan, dan penerbitan buku ini. Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan pada masa mendatang.

Akhir kata, semoga buku ini memberikan manfaat yang luas dan menjadi salah satu pemantik penguatan kolaborasi interprofesional demi terwujudnya derajat kesehatan ibu, anak, dan remaja yang lebih baik, merata, dan berkeadilan di Indonesia.

Februari, 2026

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

CHAPTER 1 UPAYA PENINGKATAN KUALITAS ANTENATAL CARE (ANC 10 T) DAN IMPLEMENTASI EVIDENCE-BASED MIDWIFERY 1

Yayuk Puji Lestari, SST., Bdn., M.Keb.	1
A. Pendahuluan / Prolog.....	1
B. Pengertian dan Tujuan Antenatal Care (ANC).....	2
C. Standar Pelayanan ANC 10 T	4
D. Konsep <i>Evidence-Based Midwifery</i>	6
E. Implementasi Evidence-Based Midwifery pada ANC 10 T	10
F. Strategi Peningkatan Kualitas ANC Berbasis Evidence.....	12
G. Tantangan dan Peluang Implementasi di Lapangan.....	14
H. Simpulan.....	16
I. Referensi.....	17
J. Glosarium.....	19

CHAPTER 2 MANAJEMEN LAKTASI, NUTRISI IBU MENYUSUI, DAN PENCEGAHAN STUNTING 1000 HPK.....21

Subriah, S.ST., M.Kes.	21
A. Pendahuluan/Prolog	21
B. Konsep Dasar Laktasi dan Fisiologi Produksi ASI.....	22
C. Teknik Menyusui, Manajemen Masalah Laktasi, dan Pendampingan Ibu.....	27
D. Kebutuhan Gizi Ibu Menyusui dan Pengaruhnya terhadap Kualitas ASI	28
E. Stunting dan ibu Menyusui	29
F. Simpulan.....	30
G. Referensi.....	31
H. Glosarium.....	32

CHAPTER 3 FARMAKOVIGILANS OBAT DAN SUPLEMEN PADA IBU HAMIL, MENYUSUI, DAN ANAK35

Anggun Fajar Ramadhani, S.Kep., Ners., M.Kep.	35
A. Pendahuluan/Prolog	35
B. Farmakovigilans Obat dan Suplemen pada Ibu Hamil.....	36
C. Farmakovigilans Obat dan Suplemen pada Ibu Menyusui	41
D. Farmakovigilans Obat pada Anak	45

E. Simpulan.....	49
F. Referensi.....	50
G. Glosarium.....	52

CHAPTER 4 PENDEKATAN GIZI REMAJA UNTUK MENCEGAH ANEMIA

DAN KEHAMILAN RISIKO TINGGI.....55

Ety Nurhayati, S.Kp., M.Kep., Ns., Sp.Kep.Mat.55

A. Pendahuluan / Prolog.....	55
B. Gambaran Umum Kesehatan Gizi Remaja	56
C. Konsep Anemia pada Remaja.....	58
D. Hubungan Status Gizi Remaja dengan Kehamilan Risiko Tinggi.....	59
E. Pendekatan Gizi Remaja dalam Pencegahan Anemia	62
F. Pendekatan Interprofesional dalam Pencegahan Anemia Remaja	63
G. Program Nasional dan Strategi Indonesia Sehat 2045.....	65
H. Simpulan.....	67
I. Referensi.....	69
J. Glosarium.....	71

CHAPTER 5 MANAJEMEN KASUS REMAJA DENGAN PERMASALAHAN

KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (KRR)73

Dewi Sari Rochmayani, S. Si.T, M.Kes (Epid).73

A. Pendahuluan / Prolog.....	73
B. Konsep Dasar Kesehatan Reproduksi Remaja	74
C. Permasalahan kesehatan reproduksi Remaja	75
D. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja	77
E. Upaya Kesehatan Sistem Reproduksi remaja.....	77
F. Manajemen Kasus Remaja dengan Permasalahan Kesehatan Reproduksi (KRR)	79
G. Pendekatan Interprofesional dalam Penanganan KRR.....	83
H. Konseling dan Edukasi Berbasis Hak Remaja.....	85
I. Teknik komunikasi efektif.....	85
J. Prinsip dan pendekatan Pelayanan Kesehatan Remaja.....	85
K. Simpulan.....	86
L. Referensi.....	87
M.Glosarium.....	89

CHAPTER 6 PENGUATAN PERAN KELUARGA DAN KOMUNITAS

SEBAGAI MITRA TENAGA KESEHATAN.....91

Ns. Indra Tri Astuti, M.Kep., Sp.Kep.An.91

A. Pendahuluan / Prolog.....	91
------------------------------	----

B. Konsep Kemitraan dalam Pelayanan Kesehatan: Pendekatan Berbasis Kesetaraan dan Kolaborasi	92
C. Bentuk-Bentuk Penguatan Peran Keluarga sebagai Mitra Tenaga Kesehatan.....	95
D. Strategi Penguatan Peran Komunitas sebagai Mitra Tenaga Kesehatan.....	97
E. Model Implementasi Kemitraan Keluarga dan Komunitas dalam Pelayanan Kesehatan	100
F. Indikator Keberhasilan Kemitraan Keluarga dan Komunitas sebagai Mitra Tenaga Kesehatan.....	103
G. Simpulan.....	105
H. Referensi.....	107
I. Glosarium.....	109

CHAPTER 7 PENDEKATAN PSIKOSOSIAL DALAM PERAWATAN IBU

HAMIL, IBU NIFAS, DAN IBU BEKERJA.....111

Ns. Esa Rosyida Umam, S.Kep., M.Kep.111

A. Pendahuluan / Prolog.....	111
B. Konsep Dasar Pendekatan Psikososial dalam Kesehatan Ibu	112
C. Pendekatan Psikososial dalam Perawatan Ibu Hamil.....	113
D. Pendekatan Psikososial dalam Perawatan Ibu Nifas	115
E. Pendekatan Psikososial pada Ibu Bekerja	117
F. Pendekatan Interprofesional dalam Perawatan Psikososial Ibu.....	119
G. Implikasi bagi Kebijakan dan Praktik Pelayanan Kesehatan	120
H. Simpulan.....	120
I. Referensi.....	121
J. Glosarium.....	123

CHAPTER 8 STRATEGI PROMOSI KESEHATAN DIGITAL UNTUK

EDUKASI KIA DAN REMAJA.....125

Sri Musfiroh, S.Si.T., M.Kes.125

A. Pendahuluan / Prolog.....	125
B. Definisi Proposi Kesehatan	126
C. Definisi Promosi Kesehatan Digital.....	127
D. Manfaat Promosi Kesehatan Digital untuk Edukasi KIA dan Remaja	128
E. Macam-Macam Promosi Kesehatan Digital untuk Edukasi KIA dan Remaja.....	129
F. Strategi Promosi Kesehatan Digital untuk Edukasi KIA dan Remaja	131
G. Simpulan.....	132
H. Referensi.....	133
I. Glosarium.....	135

PROFIL PENULIS	137
-----------------------------	------------

CHAPTER 1

UPAYA PENINGKATAN KUALITAS ANTENATAL CARE (ANC 10 T) DAN IMPLEMENTASI EVIDENCE-BASED MIDWIFERY

Yayuk Puji Lestari, SST., Bdn., M.Keb.

A. Pendahuluan / Prolog

Antenatal Care (ANC) atau pemeriksaan kehamilan merupakan komponen penting dalam sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak karena berperan dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui deteksi dini risiko kehamilan, pemantauan kondisi ibu dan janin, edukasi kesehatan, serta perencanaan persalinan yang tepat. ANC memberikan kesempatan bagi tenaga kesehatan, khususnya bidan, untuk menilai status kesehatan ibu hamil secara komprehensif, memberikan suplementasi nutrisi, serta menangani atau merujuk kasus berisiko tinggi sebelum berkembang menjadi komplikasi yang fatal (Intan Sari et al., 2025; *INDONESIAN JOURNAL OF COMMUNITY EMPOWERMENT*) .

Penelitian sistematis juga menunjukkan bahwa intervensi yang dipimpin oleh bidan, termasuk pemeriksaan kehamilan yang berkelanjutan dan edukasi psikososial, secara signifikan dapat meningkatkan outcome obstetrik seperti menurunkan risiko preterm birth dan operasi caesar serta meningkatkan kepuasan ibu terhadap pelayanan ANC dibandingkan dengan pelayanan rutin standar (Xu et al., 2026).

Meskipun ANC telah diakui secara luas sebagai strategi penting dalam upaya menurunkan mortalitas ibu dan bayi, tantangan mutu pelayanan ANC di Indonesia tetap signifikan. Studi deskriptif menunjukkan bahwa pelayanan ANC di beberapa fasilitas kesehatan masih menghadapi hambatan seperti ketidakteraturan pelaksanaan pemeriksaan 10 T, ketersediaan sumber daya manusia yang tidak merata, serta kualitas pelayanan yang belum memenuhi standar profesional yang diharapkan (Rahmadhani & Hikmah, 2025; *Jurnal Rekam Medik dan Informasi Kesehatan*) . Selain itu, persepsi dan pengalaman ibu hamil terhadap kualitas ANC memengaruhi tingkat kunjungan berulang, sehingga berdampak pada cakupan pelayanan dan keberlanjutan pemantauan selama masa kehamilan (Suganda Putri et al., 2026; *Analisis Kualitas Pelayanan ANC*).

Perubahan paradigma dalam pelayanan kesehatan ibu telah menggeser fokus dari pelaksanaan ANC yang bersifat rutin saja, menuju pelayanan berbasis bukti (evidence-based care). Pendekatan evidence-based practice (EBP) menuntut

penggunaan bukti ilmiah terbaik yang tersedia, keahlian klinis tenaga kesehatan, serta nilai dan preferensi klien sebagai dasar pengambilan keputusan klinis. Dalam konteks kebidanan, evidence-based midwifery menekankan integrasi riset terkini dan pedoman klinis ke dalam praktik sehari-hari untuk meningkatkan mutu pelayanan dan hasil kesehatan ibu serta bayi baru lahir (Rosnidawati, 2025; Jurnal Penelitian Perawat Profesional & Simamora et al., 2024) . Pendekatan ini juga didukung oleh bukti bahwa model perawatan yang dipimpin bidan berbasis bukti dapat menurunkan intervensi medis yang tidak perlu serta memperbaiki kualitas pengalaman ibu hamil (Fikre et al., 2023).

Dengan demikian, chapter ini ditulis untuk menjelaskan urgensi peningkatan kualitas ANC melalui implementasi evidence-based midwifery, dengan mengkaji tantangan yang ada, menjelaskan dasar ilmiah yang mendukung perubahan paradigma tersebut, serta menawarkan rekomendasi praktis bagi pengembang kebijakan, pendidik kebidanan, dan praktisi lapangan. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu memperkuat pelayanan ANC di Indonesia, sehingga target penurunan AKI dan AKB dapat dicapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

B. Pengertian dan Tujuan Antenatal Care (ANC)

1. Pengertian Antenatal Care (ANC)

Antenatal Care (ANC) merujuk pada pelayanan kesehatan yang diberikan kepada wanita selama masa kehamilan dengan tujuan utama memastikan kondisi kesehatan ibu dan janin tetap optimal hingga persalinan. Menurut panduan World Health Organization (WHO), ANC diartikan sebagai perawatan yang disediakan oleh tenaga kesehatan terampil untuk ibu hamil guna menjamin kondisi terbaik bagi ibu dan bayi selama kehamilan melalui identifikasi risiko, pencegahan dan penanganan penyakit terkait kehamilan serta pemberian edukasi kesehatan (WHO, 2016). ANC tidak hanya bertujuan untuk meminimalkan kematian dan morbiditas maternal tetapi juga memberi kesempatan untuk deteksi dan penatalaksanaan dini komplikasi serta rujukan ke layanan yang lebih tinggi bila diperlukan.

Dalam konteks kebijakan nasional, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) mendefinisikan ANC sebagai pelayanan kesehatan oleh tenaga profesional bagi ibu hamil yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan antenatal yang ditetapkan, termasuk pemeriksaan klinis dan konseling kesehatan guna mendukung kehamilan yang sehat serta deteksi kondisi risiko tinggi sejak awal. Implementasi standar pelayanan tersebut mencakup pemeriksaan fisik, skrining, edukasi, pengukuran indikator kesehatan serta sistem rujukan bila ditemukan kondisi yang memerlukan penanganan di fasilitas tingkat lanjut.

Secara konseptual, ANC merupakan komponen penting dalam promosi kesehatan ibu dan anak yang bersifat preventif dan kuratif, memberikan dukungan medis dan edukatif yang proaktif selama masa kehamilan untuk mencegah komplikasi, meningkatkan kesehatan ibu dan bayi, serta mempersiapkan proses persalinan yang aman.

2. Tujuan Antenatal Care (ANC)

Pelayanan ANC memiliki beberapa tujuan utama yang saling berkaitan dengan aspek promotif, preventif, deteksi dini, dan sistem rujukan:

a. Promotif

ANC memberikan edukasi kesehatan kepada ibu hamil mengenai makanan bergizi, tanda bahaya kehamilan, serta praktik hidup sehat yang mendukung kehamilan yang aman dan sehat sampai persalinan. Edukasi ini mencakup konseling nutrisi, imunisasi, dan persiapan persalinan, yang secara kolektif bertujuan meningkatkan pengetahuan dan perilaku ibu demi hasil kehamilan optimal.

b. Preventif

Intervensi preventif melalui pemeriksaan berkala dan skrining dini memungkinkan deteksi faktor risiko atau kondisi patologis seperti anemia, hipertensi gestasional, dan infeksi yang dapat berdampak buruk pada ibu maupun janin. Penanganan dini terhadap kondisi tersebut dapat mengurangi kemungkinan berkembangnya komplikasi serius.

c. Deteksi Dini

Salah satu tujuan kunci ANC adalah melakukan skrining dan pengawasan untuk mendeteksi risiko tinggi kehamilan sejak awal. Deteksi dini memberikan peluang bagi tenaga kesehatan untuk melakukan manajemen yang tepat, baik melalui terapi langsung maupun rujukan kepada layanan yang lebih kompleks sebelum komplikasi berkembang menjadi ancaman serius bagi ibu dan janin.

d. Rujukan

Melalui kunjungan ANC yang terstandar, tenaga kesehatan mampu mengidentifikasi kasus yang memerlukan penanganan lebih lanjut di fasilitas rujukan. ASN yang efektif menjamin kelancaran mekanisme rujukan cepat dan tepat waktu, sehingga kemungkinan hasil buruk seperti kematian maternal dan neonatal dapat diminimalkan.

Dengan demikian, ANC merupakan layanan komprehensif yang tidak hanya berorientasi pada pemeriksaan medis saja, tetapi juga melibatkan pendekatan holistik yang mendukung kesehatan ibu dan bayi melalui edukasi, pencegahan, deteksi dini, serta tindakan rujukan bila diperlukan.

C. Standar Pelayanan ANC 10 T

Standar pelayanan Antenatal Care (ANC) 10 T merupakan rangkaian pemeriksaan dan intervensi minimal yang harus diberikan pada setiap kunjungan ibu hamil untuk memastikan deteksi dini risiko kehamilan, pemantauan pertumbuhan dan kesehatan ibu serta janin, pencegahan komplikasi, serta edukasi yang tepat. Sesuai pedoman pelayanan antenatal terpadu nasional, komponen 10 T ini mencakup timbang berat badan & ukur tinggi badan, pengukuran tekanan darah, tinggi fundus uteri, taksiran status gizi (LILA), imunisasi Tetanus Toxoid, pemberian tablet tambah darah, pemeriksaan laboratorium, temu wicara/konseling, tata laksana kasus, serta tindak lanjut/rujukan apabila perlu (Ministry of Health RI, 2019).

1. Timbang Berat Badan dan Ukur Tinggi Badan

Pemeriksaan berat badan merupakan indikator penting untuk memantau perubahan massa tubuh ibu selama kehamilan, yang jika abnormal dapat mengindikasikan risiko gangguan pertumbuhan janin atau preeklamsia. Pengukuran tinggi badan pada kunjungan pertama dapat membantu menilai potensi komplikasi seperti cephalopelvic disproportion (ketidaksesuaian ukuran panggul terhadap kepala janin) di kemudian hari. Standar ini menjadi dasar untuk memantau kenaikan berat badan selama kehamilan sesuai rekomendasi klinis. Namun, studi pelaksanaan di beberapa puskesmas menunjukkan bahwa pengukuran ini sering kurang konsisten dilakukan, terutama dalam kunjungan lanjutan, sehingga potensi risiko pertumbuhan janin abnormal tidak terdeteksi optimal.

2. Tekanan Darah

Pengukuran tekanan darah ibu hamil di setiap kunjungan ANC sangat penting dalam deteksi dini preeklamsia, suatu kondisi hipertensi kehamilan yang berpotensi fatal jika tidak ditangani sejak dini. Penelitian mendukung pengukuran tekanan darah berkala sebagai praktik klinis standar dalam perawatan antenatal karena berkontribusi dalam pencegahan komplikasi hipertensi gestasional (WHO, 2016). Di lapangan, meskipun indikator ini relatif sering dilakukan, laporan evaluasi menunjukkan adanya variasi kualitasnya misalnya karena keterbatasan alat atau kompetensi petugas yang memengaruhi keandalan deteksi hipertensi kehamilan.

3. Tinggi Fundus Uteri

Pengukuran tinggi fundus uteri (TFU) berfungsi untuk menilai pertumbuhan janin seiring gestasi dan mendeteksi adanya ketidaksesuaian pertumbuhan yang bisa menandakan gangguan seperti intrauterine growth restriction (IUGR). Praktik ini sesuai dengan pedoman ANC yang menempatkan TFU sebagai indikator klinis pemantauan kehamilan (Ministry of Health RI, 2019). Di beberapa fasilitas,

pencatatan TFU sudah mencapai standar tinggi, namun masih terdapat tantangan pada analisis tren longitudinal karena kurangnya dokumentasi yang konsisten pada setiap kunjungan ANC.

4. Taksiran Status Gizi (LILA)

Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) digunakan untuk menaksir status gizi ibu hamil, karena gizi buruk dikaitkan dengan risiko bayi lahir dengan berat badan rendah dan komplikasi lain. Standar ANC mensyaratkan penilaian LILA terutama pada kunjungan awal, dengan tindak lanjut berupa konseling gizi atau rujukan bila ditemukan kurang gizi (Ministry of Health RI, 2019). Namun, di beberapa layanan ANC, pengukuran status gizi sering kali kurang konsisten, sehingga identifikasi risiko KEK (Kekurangan Energi Kronis) tidak optimal.

5. Tetanus Toxoid

Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) merupakan komponen pencegahan infeksi tetanus perinatal yang wajib diberikan sesuai status imunisasi ibu hamil. Pemberian TT sangat penting untuk melindungi ibu dan bayi dari tetanus neonatal, yang merupakan komplikasi infeksi serius dengan angka mortalitas tinggi di daerah beresiko rendah layanan kesehatan. Praktiknya menunjukkan cakupan imunisasi TT masih bervariasi, bahkan di tempat dengan implementasi komponen lain yang baik sekalipun, ini menjadi komponen yang tidak selalu optimal.

6. Tablet Tambah Darah

Pemberian tablet zat besi dan asam folat merupakan intervensi penting untuk mencegah anemia defisiensi besi, yang berhubungan dengan gangguan pertumbuhan janin dan komplikasi obstetrik. Standar ANC mensyaratkan pemberian minimal 90 tablet selama masa hamil (Ministry of Health RI, 2019). Namun evaluasi layanan menunjukkan bahwa tingkat pemberian tablet besi di fasilitas kesehatan sering belum mencapai target ideal, terutama apabila distribusi suplemen tidak didukung edukasi yang efektif kepada ibu hamil.

7. Tes Laboratorium

Pemeriksaan laboratorium, seperti hemoglobin, golongan darah, protein urin, dan skrining infeksi menular (misalnya HIV dan sifilis), merupakan bagian penting dari ANC untuk deteksi dini kondisi yang memengaruhi kehamilan. Meski ini tercantum dalam standar ANC, beberapa studi melaporkan bahwa sering terdapat hambatan teknis atau sumber daya yang menyebabkan tes laboratorium tidak dilakukan secara konsisten pada semua kunjungan sesuai prosedur.

8. Temu Wicara/Konseling

Temu wicara atau konseling mencakup pemberian informasi mengenai nutrisi, tanda bahaya kehamilan, persiapan persalinan, dan perencanaan rujukan

serta pembinaan keluarga. Komponen ini krusial untuk memberdayakan ibu dalam mengambil keputusan kesehatan. Namun, di lapangan pelaksanaan konseling seringkali terabaikan karena keterbatasan waktu konsultan atau kurangnya dokumentasi kualitas interaksi konseling selama kunjungan ANC.

9. Tata Laksana Kasus

Tata laksana kasus berarti penanganan kondisi atau komplikasi kehamilan yang terdeteksi sesuai kewenangan fasilitas kesehatan atau rujukan ke layanan yang lebih lengkap. Standar ini memastikan setiap kondisi berisiko tinggi mendapat perhatian cepat dan tepat (Ministry of Health RI, 2019). Praktiknya di beberapa puskesmas menunjukkan bahwa meskipun kasus ditangani sesuai protokol, hambatan seperti kurangnya tenaga spesialis atau fasilitas rujukan seringkali menjadi tantangan dalam penyelenggaraan tata laksana yang optimal.

10. Tindak Lanjut/Rujukan

Komponen terakhir ini mencakup identifikasi kebutuhan tindak lanjut intervensi lebih lanjut, termasuk rujukan ke fasilitas rujukan tingkat lanjut bila diperlukan. Sistem rujukan yang efektif merupakan bagian penting dari mutu ANC untuk mengurangi komplikasi berat. Tantangan di praktik lapangan antara lain kurangnya koordinasi antar fasilitas dan keterbatasan transportasi untuk rujukan tepat waktu

D. Konsep *Evidence-Based Midwifery*

1. Definisi *Evidence-Based Midwifery*

Evidence-Based Midwifery adalah pendekatan praktik kebidanan yang menggunakan bukti ilmiah terbaik yang tersedia untuk mengambil keputusan klinis, dengan mengintegrasikan keahlian klinis bidan, serta mempertimbangkan nilai dan preferensi ibu sebagai pusat perawatan. Pendekatan ini menempatkan bukti ilmiah sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan klinis, namun tetap memadukannya dengan pengalaman profesional bidan dan kebutuhan unik setiap ibu hamil untuk menghasilkan outcome kesehatan yang optimal (*evidence-based practice*). Dalam konteks maternal care, EBP menuntut bidan untuk secara sadar, eksplisit, dan bijaksana menggunakan bukti dari penelitian terkini dalam merancang strategi asuhan agar efektif dan aman bagi ibu dan bayi (*evidence-based practice in midwifery care*).

Dalam midwifery, pendekatan berbasis bukti bukan sekadar mencari bukti terbaik, tetapi juga merupakan proses *problem-solving* yang sistematis dalam praktik klinik yang melibatkan identifikasi masalah, pencarian dan penilaian bukti, serta penerapan bukti dalam konteks riil bersama ibu sebagai mitra keputusan (*evidence-based practice*).

2. Evidence-Based Midwifery

Pelaksanaan evidence-based midwifery memiliki tiga komponen utama yang saling terkait dalam pengambilan keputusan klinis efektif:

a. Bukti Ilmiah Terbaik

Komponen pertama dari EBP adalah penggunaan bukti ilmiah terbaik yang tersedia melalui penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bukti ini biasanya berasal dari penelitian primer seperti uji klinis acak (randomized controlled trials), meta-analisis, serta tinjauan sistematis yang memberikan data kuantitatif dan kualitatif tentang efektivitas intervensi kebidanan. Pencarian bukti ilmiah yang sistematis membantu bidan memastikan bahwa praktik kliniknya didasari oleh informasi yang paling mutakhir dan relevan, bukan hanya berdasarkan kebiasaan atau tradisi layanan sebelumnya.

Dalam konteks pelayanan antenatal care, bukti ilmiah terbaik memandu bidan mengadopsi intervensi yang terbukti memperbaiki outcome kesehatan ibu dan bayi misalnya, pendidikan prenatal yang terstruktur dan praktik dukungan psikososial yang dibuktikan menurunkan kecemasan ibu dan risiko kelahiran prematur (midwifery-led care).

b. Keahlian Klinis Bidan

Komponen kedua adalah keahlian klinis bidan yang diperoleh melalui pendidikan profesional, pengalaman praktik, dan keterampilan dalam menilai bukti ilmiah secara kritis. Keahlian ini memungkinkan bidan untuk menginterpretasikan bukti dalam konteks pasien spesifik, menerapkannya secara tepat, serta menyesuaikan intervensi bila perlu berdasarkan tanggapan klinis dan kondisi pasien. Keahlian klinis juga mencakup kemampuan dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam situasi yang berubah-ubah di lapangan, termasuk situasi komplikasi kehamilan yang membutuhkan evaluasi klinis berkesinambungan.

Kompetensi ini penting karena bukti ilmiah saja tidak menjamin hasil klinis yang baik jika tidak diikuti oleh keterampilan implementasi yang tepat sehingga integrasi antara bukti dan praktik klinis menjadi kunci utama dalam EBP.

c. Nilai dan Preferensi Ibu

Komponen ketiga yang tak kalah penting adalah nilai, kebutuhan, serta preferensi ibu hamil yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan klinis. Setiap ibu memiliki latar belakang budaya, pengetahuan, keyakinan, dan harapan yang berbeda terhadap proses kehamilan dan persalinan. Pendekatan evidence-based midwifery menempatkan ibu sebagai

mitra dalam keputusan perawatan dengan cara memperhatikan bagaimana bukti ilmiah dapat diintegrasikan dengan pilihan personal ibu, sehingga intervensi yang dipilih tidak hanya efisien secara klinis tetapi juga person-centered dan sesuai dengan keinginan serta situasi kehidupan ibu tersebut. Mengabaikan preferensi ibu berisiko menciptakan praktik yang tampak efektif secara ilmiah tetapi tidak sesuai kebutuhan klien, misalnya mengabaikan pertimbangan budaya atau kekhawatiran ibu terhadap intervensi tertentu yang sebenarnya tidak diperlukan secara klinis.

3. Sumber Evidence dalam Praktik Kebidanan

Dalam praktik kebidanan yang berbasis bukti (Evidence-Based Midwifery), bidan mengandalkan berbagai sumber evidence untuk memastikan pengambilan keputusan klinis yang akurat, up-to-date, dan relevan dengan kebutuhan ibu hamil. Sumber-sumber evidence ini meliputi pedoman nasional, clinical guideline WHO, hasil penelitian terbaru, serta audit klinik dan data layanan sebagai dasar implementasi praktik kebidanan yang berkualitas.

a. Pedoman Nasional

Pedoman nasional merupakan dokumen resmi yang disusun oleh otoritas kesehatan di suatu negara sebagai acuan praktik klinis di layanan kesehatan termasuk kebidanan. Pedoman ini biasanya mengintegrasikan bukti ilmiah global dengan konteks lokal, sumber daya yang tersedia, serta masalah kesehatan masyarakat yang spesifik. Di Indonesia, misalnya, Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan RI memberikan standar komprehensif bagi pelaksanaan pemeriksaan antenatal termasuk pemantauan kesehatan ibu dan janin, imunisasi, serta edukasi kesehatan ibu hamil (Kemenkes RI, 2020). Pedoman semacam ini membantu bidan memastikan bahwa praktik klinisnya konsisten dengan standar nasional dan kebutuhan kesehatan masyarakat, serta menjadi dasar evaluasi mutu layanan. Di banyak negara lain, pedoman nasional ANC juga dirancang dengan mempertimbangkan bukti terbaik yang ada untuk mencapai hasil kesehatan ibu dan bayi yang optimal (Kemenkes RI, 2020).

b. Clinical Guideline WHO

World Health Organization (WHO) menerbitkan clinical guideline internasional yang berisi rekomendasi berbasis bukti untuk praktik pelayanan antenatal yang berkualitas. Salah satu pedoman penting adalah WHO Recommendations on Antenatal Care for a Positive Pregnancy Experience, yang memberikan rangkaian rekomendasi berbasis bukti untuk meningkatkan pengalaman kehamilan, mengoptimalkan skrining, serta mencegah dan mengelola komplikasi sejak dini. Pedoman WHO ini dikembangkan melalui tinjauan

sistematis terhadap bukti ilmiah terbaru dan menekankan aspek person-centred care, yang berarti rekomendasi tidak hanya berdasar data klinis tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan harapan perempuan hamil (WHO, 2016; pembaruan terbaru 2022). Pedoman-pedoman WHO membantu negara dan praktisi kesehatan dalam merancang protokol pelayanan ANC yang sesuai dengan bukti ilmiah terkini serta kondisi setempat.

c. Hasil Penelitian Terkini (5 Tahun Terakhir)

Sumber evidence utama lainnya dalam praktik kebidanan adalah hasil penelitian ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional. Penelitian kuantitatif maupun kualitatif yang dilakukan di berbagai setting pelayanan kesehatan memberi informasi tentang efektivitas intervensi klinis, determinan hasil kesehatan, serta hambatan implementasi praktik terbaik. Misalnya, penelitian sistematis dan meta-analisis terbaru menunjukkan bahwa model pelayanan yang dipimpin bidan (midwifery-led care) secara konsisten terkait dengan hasil maternitas yang lebih baik termasuk penurunan intervensi bedah yang tidak perlu dan peningkatan kelahiran spontan dibandingkan model perawatan konvensional (Hossain et al., 2023; BMC Pregnancy and Childbirth). Bukti semacam ini kemudian menjadi dasar rekomendasi klinis, modifikasi pedoman, serta program pelatihan atau kebijakan lokal yang berfokus pada peningkatan mutu layanan ANC.

4) Audit Klinik dan Data Layanan

Selain pedoman dan literatur ilmiah, audit klinik dan analisis data layanan merupakan sumber evidence yang penting untuk praktik kebidanan berbasis bukti. Audit klinik adalah proses evaluasi sistematis terhadap praktik klinis yang dilakukan di fasilitas kesehatan untuk menilai kesesuaian dengan standar atau pedoman yang berlaku. Sebagai contoh, proyek implementasi bukti dengan model JBI (Joanna Briggs Institute) menggunakan audit awal (baseline audit) untuk menilai sejauh mana praktik antenatal sesuai dengan rekomendasi terbaik, kemudian melakukan audit tindak lanjut setelah intervensi untuk melihat perubahan perilaku pelayanan (JBI PACES/GRiP). Metode audit seperti ini membantu mengidentifikasi kesenjangan antara praktik aktual dan standar, serta merancang strategi perbaikan berbasis data nyata di lapangan, sehingga menjadi evidence-to-practice feedback loop yang efektif untuk meningkatkan kualitas layanan kebidanan (Ayres et al., 2021) .

Audit klinik dan routine health outcomes measurement juga memberikan practice-based evidence, yaitu bukti yang dikumpulkan dari data real-world di fasilitas kesehatan yang dapat melengkapi bukti dari penelitian formal dan

membantu dalam penyesuaian protokol pelayanan sesuai konteks lokal (Routine health outcomes measurement)

E. Implementasi Evidence-Based Midwifery pada ANC 10 T

Penerapan evidence-based midwifery dalam setiap komponen Antenatal Care (ANC) 10 T bertujuan meningkatkan deteksi dini risiko kehamilan, pengambilan keputusan klinis yang cepat dan tepat, serta peningkatan hasil kesehatan ibu dan bayi. Beberapa contoh implementasi bukti ilmiah dalam praktik ANC ditunjukkan pada pemeriksaan tekanan darah, suplementasi tablet tambah darah, konseling gizi dan tanda bahaya, serta penggunaan clinical pathway dalam pengambilan keputusan berbasis bukti.

1. Evidence pada Pemeriksaan Tekanan Darah untuk Pencegahan Preeklamsia

Pemeriksaan tekanan darah secara rutin merupakan komponen vital ANC karena preeklamsia gangguan hipertensi yang muncul setelah usia kehamilan ≥ 20 minggu masih menjadi salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas ibu serta bayi di seluruh dunia (pre-eclampsia fact sheet, WHO). Deteksi dini hipertensi gestasional melalui pengukuran tekanan darah dan pemeriksaan protein urin memberikan peluang untuk intervensi tepat waktu, termasuk pemantauan yang ditingkatkan, pemberian terapi antihipertensi jika diperlukan, serta rujukan ke layanan lanjutan bila kondisi memburuk (pre-eclampsia fact sheet, WHO).

Meskipun bukti langsung mengenai dampak pemeriksaan tekanan darah terhadap outcome klinis masih terbatas, praktik ini tetap direkomendasikan secara global sebagai alat skrining utama yang sederhana, aman, dan murah untuk mengidentifikasi wanita berisiko tinggi (pre-eclampsia fact sheet, WHO). Implementasi pemeriksaan tekanan darah berbasis bukti memungkinkan bidan maupun tenaga kesehatan lainnya untuk mengidentifikasi, menilai risiko, dan membedakan antara kehamilan normal dan kehamilan yang berisiko tinggi terhadap preeklamsia sejak dini.

2. Evidence Pemberian Tablet Tambah Darah

Anemia defisiensi besi merupakan masalah nutrisi tersering selama kehamilan yang berdampak negatif terhadap kesehatan ibu dan janin, termasuk risiko persalinan prematur dan berat lahir rendah. Bukti menunjukkan bahwa pemberian suplementasi zat besi secara teratur misalnya melalui tablet tambah darah (TTD) iron-folate efektif dalam menurunkan kejadian anemia dan meningkatkan kadar hemoglobin ibu selama kehamilan. Studi di beberapa fasilitas kesehatan menemukan bahwa kombinasi pemberian TTD dan konseling

nutrisi yang tepat meningkatkan pengetahuan ibu, kepatuhan konsumsi, serta menurunkan prevalensi anemia berat di akhir kehamilan.

Dalam praktik ANC berbasis bukti, bidan tidak hanya menyalurkan TTD, tetapi juga menyampaikan edukasi yang didukung bukti mengenai pentingnya kepatuhan minum TTD dan konsumsi sumber iron dari makanan yang terbukti memperkuat efektivitas suplementasi gizi serta meminimalkan komplikasi anemia.

3. Evidence Konseling Gizi, Tanda Bahaya, dan Kesiapan Persalinan

Konseling selama ANC tentang gizi sehat, tanda bahaya kehamilan, dan kesiapan persalinan memiliki bukti yang kuat dalam meningkatkan keterlibatan ibu dalam perawatan kesehatan dan pencegahan komplikasi. WHO ANC recommendations menyoroti bahwa konseling tentang pola makan sehat dan aktivitas fisik memberikan efek positif pada pengalaman kehamilan secara umum, termasuk pencegahan penambahan berat badan berlebih dan optimalisasi kesehatan maternal.

Lebih dari itu, konseling juga membantu ibu memahami tanda bahaya yang memerlukan rujukan segera (misalnya perdarahan, nyeri kepala hebat, berkurangnya gerakan janin), sehingga meningkatkan tindak lanjut cepat yang dapat menyelamatkan nyawa. Keterlibatan ibu dalam pendampingan kesiapan persalinan meliputi rencana persalinan, dukungan keluarga, dan rujukan jika diperlukan juga dikaitkan dengan pengalaman positif dan outcome yang lebih baik secara keseluruhan.

4. Penggunaan Clinical Pathway dan Decision Making Berbasis Bukti

Clinical pathway atau care pathway adalah alat bantu manajemen klinis yang merangkum proses perawatan berdasarkan bukti ilmiah terkini dan standar praktik terbaik. Clinical pathway dirancang untuk standardisasi, koordinasi, dan optimalisasi tindak klinis di seluruh langkah perawatan, termasuk ANC, sehingga menghasilkan keputusan klinis yang konsisten dan terukur (clinical pathway, Wikipedia).

Dalam konteks ANC, clinical pathway membantu bidan menentukan langkah pemeriksaan, intervensi, serta tindak lanjut yang sesuai dengan profil risiko ibu hamil secara individual misalnya peta keputusan untuk kasus risiko tinggi vs risiko rendah. Bukti dari studi kohort menunjukkan bahwa penerapan jalur perawatan terintegrasi dalam layanan kehamilan dapat mengurangi frekuensi konsultasi sekunder yang tidak perlu, meningkatkan persalinan terencana di fasilitas primer, dan menjaga outcome neonatal tetap aman.

Selain itu, penggunaan decision support berbasis bukti (misalnya pedoman, algoritma klinis yang terintegrasi dalam sistem rekam medis elektronik)

memperkuat kemampuan bidan untuk membuat keputusan cepat dan akurat sesuai bukti terkini, serta beradaptasi dengan perubahan klinis ibu secara real time.

F. Strategi Peningkatan Kualitas ANC Berbasis Evidence

Peningkatan kualitas pelayanan antenatal care (ANC) yang efektif dan berkelanjutan menuntut pendekatan evidence-based yang komprehensif. Pendekatan ini tidak hanya mengandalkan standar klinis tertulis, tetapi juga pengembangan kapasitas sumber daya manusia, penggunaan pedoman berbasis riset, pelaksanaan audit mutu, kolaborasi antarprofesi, serta pemanfaatan teknologi informasi kesehatan. Beberapa strategi utama tersebut diuraikan berikut ini.

1. Peningkatan Kompetensi Bidan

Kompetensi bidan menjadi pondasi utama dalam penyelenggaraan ANC berkualitas. Continuing professional development (CPD) dan pelatihan berbasis bukti dapat menutup kesenjangan antara pengetahuan teoretis dan keterampilan klinis yang dibutuhkan di layanan ANC. Integrasi evidence-based practice dalam kurikulum pendidikan kebidanan, termasuk pelatihan klinis yang sistematis dan pembimbingan mentor yang berpengalaman, terbukti meningkatkan kompetensi profesional bidan dalam memberikan asuhan berbasis bukti (Evidence-Based Education Programs to Improve Maternal ..., 2025). Selain itu, pelatihan khusus yang dirancang untuk kebutuhan pelayanan lokal membantu bidan menerjemahkan bukti ilmiah ke dalam praktik klinik sehari-hari.

Perbaikan kompetensi tersebut tidak hanya berfokus pada aspek klinis, tetapi juga pengembangan soft skills seperti komunikasi interpersonal dan pengambilan keputusan bersama klien kemampuan yang mendukung pemberian ANC yang berkualitas dan menghormati nilai serta preferensi ibu (Improving midwifery curriculum in Indonesia through evidence-based practice integration: Scoping review, 2025).

2. Pemanfaatan Pedoman Berbasis Riset

Pedoman klinis dan standar praktik yang berbasis bukti merupakan referensi penting bagi bidan untuk memastikan bahwa setiap intervensi sesuai dengan hasil penelitian terbaru. Pemanfaatan pedoman ini membantu meminimalkan variasi praktik yang tidak beralasan dan meningkatkan keseragaman mutu pelayanan ANC.

Strategi implementasi pedoman berbasis riset mencakup pelatihan penggunaan pedoman, adaptasi pedoman ke konteks lokal, serta penguatan sistem supervisi yang memantau kepatuhan terhadap rekomendasi tersebut. Riset juga menunjukkan bahwa penggunaan pedoman dapat dibarengi dengan

paket pelatihan pemberdayaan sehingga tenaga kesehatan memahami dasar-dasar teori dan cara menerapkannya dalam diagnosis dan manajemen risiko kehamilan (misalnya melalui pendekatan audit yang sistematis) sehingga memaksimalkan penemuan dan tindak lanjut yang tepat waktu.

3. Audit Mutu dan Refleksi Praktik

Audit mutu merupakan salah satu strategi utama untuk menilai dan memperbaiki praktik klinis secara berkelanjutan. Audit klinik melibatkan evaluasi praktik saat ini terhadap standar rekomendasi terbaik (best practice), identifikasi kesenjangan, serta perencanaan strategi perbaikan. Metode seperti JBI PACES dan umpan balik terstruktur telah digunakan untuk meningkatkan kepatuhan bidan terhadap rekomendasi klinis dan menetapkan siklus perbaikan berkelanjutan (JBI Evidence Implementation, 2023).

Audit tidak hanya mengukur apakah komponen ANC dilaksanakan, tetapi juga menilai aspek kualitas seperti ketepatan diagnosis risiko kehamilan, konsistensi dokumentasi, dan kepuasan ibu. Refleksi praktik berbasis audit mendorong keterlibatan tim klinik untuk memahami hambatan dalam praktik dan merancang solusi bersama, termasuk pembaruan SOP atau mentoring internal yang lebih intensif.

4. Kolaborasi Interprofesional

Kolaborasi antarprofesi antara bidan, dokter, perawat, ahli gizi, psikolog, dan profesional kesehatan lainnya sangat penting untuk layanan ANC yang komprehensif. Kolaborasi ini memfasilitasi pertukaran ilmu, perencanaan perawatan terkoordinasi, serta komunikasi yang lebih baik dalam menangani kasus risiko tinggi.

Penelitian menunjukkan bahwa interprofessional education (IPE) dan pengalaman belajar terpadu antara bidan dan dokter spesialis dapat meningkatkan kompetensi kolaboratif dan persepsi tim terhadap kerja sama, yang kemudian berdampak positif pada kualitas pelayanan klinis secara keseluruhan (Improved Self-Assessed Collaboration Through Interprofessional Education, 2022). Pendekatan kolaboratif ini selaras dengan konsep perawatan yang terintegrasi dan woman-centered, di mana setiap disiplin berkontribusi pada pengambilan keputusan berdasarkan bukti serta kebutuhan klien.

5. Pemanfaatan Teknologi (Rekam Medis dan Aplikasi ANC)

Pemanfaatan teknologi digital menjadi strategi penting dalam meningkatkan mutu pelayanan ANC. Sistem rekam medis elektronik (Electronic Health Records/EHR) dan aplikasi ANC yang terintegrasi dapat membantu bidan mencatat, memantau, dan menganalisis data klinis secara real-time, serta memfasilitasi tata laksana berbasis bukti.

Contohnya, penerapan aplikasi Electronic Integrated Antenatal Care (e-iANC) telah meningkatkan kelengkapan data pencatatan ANC dan mempercepat pelaporan sehingga risiko kehamilan dapat ter-screening lebih cepat, meningkatkan efisiensi layanan dan meminimalisir kesalahan administrasi (PKM Peningkatan Kualitas Pelayanan Antenatal dengan Electronic Integrated Antenatal Care, 2020). Teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk pengingat kunjungan, pengukuran indikator kesehatan, serta dukungan telekonsultasi yang memperluas akses layanan terutama di daerah terpencil.

Selain sistem data, teknologi lain seperti platform pendidikan online dan decision support systems berbasis AI mulai dieksplorasi untuk membantu bidan dalam interpretasi data klinis, meningkatkan akurasi pengambilan keputusan dan konsistensi pelayanan berdasarkan bukti.

G. Tantangan dan Peluang Implementasi di Lapangan

Pelaksanaan evidence-based midwifery dan kualitas Antenatal Care (ANC) di lapangan sering menghadapi berbagai tantangan struktural, sumber daya, dan sosial-budaya yang mempengaruhi akses, kualitas, serta keberlanjutan pelayanan. Di sisi lain, terdapat peluang signifikan untuk memperkuat peran bidan dan meningkatkan hasil kesehatan ibu dan bayi melalui pendekatan berbasis bukti yang adaptif terhadap konteks lokal.

1. Keterbatasan SDM dan Sarana

Salah satu tantangan utama dalam implementasi layanan ANC berkualitas adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana klinik. Dalam banyak konteks, bidan dan tenaga kesehatan lainnya bekerja dalam kondisi beban kerja yang tinggi dengan jumlah staf yang tidak mencukupi, sehingga waktu yang tersedia untuk membaca penelitian terbaru atau menerapkan praktik berbasis bukti menjadi terbatas (Implementation of evidence-based practice: The experience of nurses and midwives, 2021). Selain itu, fasilitas kesehatan di beberapa daerah masih kekurangan sarana penting seperti alat pemeriksaan yang memadai dan dukungan klinis yang lengkap, yang berdampak pada kemampuan bidan untuk menerapkan standar ANC secara konsisten dalam praktik harian (Implementation of evidence-based practice: The experience of nurses and midwives, 2021). Keterbatasan sarana ini juga ditemukan dalam evaluasi layanan ANC terpadu, di mana fasilitas seperti USG atau checklist terintegrasi belum tersedia secara optimal di beberapa puskesmas (Implementasi antenatal care terpadu, 2023).

2. Variasi Kepatuhan terhadap Standar

Variasi kepatuhan terhadap standar pelayanan ANC masih menjadi tantangan signifikan. Meski standar seperti 10 T telah ditetapkan secara nasional, pelaksanaannya di lapangan sering kali tidak konsisten. Hal ini berkaitan dengan perbedaan kemampuan tenaga kesehatan dalam menerjemahkan pedoman ke dalam praktik sehari-hari, serta variasi dalam pengawasan dan supervisi klinis. Penelitian menunjukkan bahwa kendala organisasi, termasuk kurangnya dukungan manajerial dan pemantauan implementasi, dapat menyebabkan rendahnya penerapan praktik berbasis bukti yang optimal (Midwives' perceptions of barriers to implementing evidence-based practice, 2026). Faktor tersebut memperlemah keseragaman kualitas layanan ANC dan meningkatkan variasi hasil pelayanan antar wilayah ataupun fasilitas kesehatan.

3. Budaya dan Literasi Kesehatan Ibu

Budaya dan literasi kesehatan ibu memainkan peran penting dalam tantangan implementasi ANC. Literasi kesehatan yang rendah dapat menghambat kemampuan ibu hamil untuk memahami pentingnya kunjungan ANC dan mengikuti rekomendasi klinis secara tertib. Studi kesehatan menyatakan bahwa tingkat literasi kesehatan yang rendah berkaitan dengan lebih rendahnya pemahaman ibu terhadap informasi kesehatan, yang pada gilirannya memengaruhi perilaku mencari layanan kesehatan dan kepatuhan terhadap kunjungan ANC yang direkomendasikan (Maternal health literacy and antenatal care program, 2025). Kesenjangan ini diperparah oleh faktor budaya di mana beberapa perempuan mungkin masih mengandalkan praktik tradisional atau mempertimbangkan kehamilan sebagai proses alami yang tidak memerlukan kunjungan kesehatan rutin. Oleh karena itu, tantangan literasi dan budaya perlu diatasi melalui program edukasi yang sensitif budaya dan mudah diakses.

4. Peluang Penguatan Peran Bidan sebagai Evidence-Based Practitioner

Meskipun tantangan di atas nyata, terdapat peluang besar untuk memperkuat peran bidan sebagai praktisi evidence-based. Pertama, upaya peningkatan kompetensi dan pendidikan berkelanjutan bidan, termasuk integrasi praktik berbasis bukti dalam kurikulum kebidanan, dapat memperkuat kemampuan bidan dalam menerapkan standar klinis terbaru dan menyesuaikannya dengan konteks lokal (Improving midwifery curriculum in Indonesia through EBP integration, 2025). Kedua, praktik kolaboratif dengan tenaga kesehatan lain dan dukungan manajerial yang kuat dapat membantu mengatasi hambatan organisasi dan memperluas pengaruh bidan dalam tim perawatan kesehatan. Ketiga, adaptasi teknologi digital (misalnya sistem rekam medis elektronik dan aplikasi ANC) juga memberikan peluang untuk

meningkatkan akurasi pencatatan klinis, mengurangi kesalahan, serta menyediakan akses cepat ke pedoman dan alat bantu klinis berbasis bukti. Teknologi ini memperkuat kapasitas bidan dalam membuat keputusan klinis yang cepat dan tepat berdasarkan bukti yang mutakhir.

Melalui penguatan pendidikan berkelanjutan, pendampingan klinis, kolaborasi multidisipliner, dan pemanfaatan inovasi teknologi, bidan dapat secara efektif mengatasi beberapa hambatan implementasi dan meningkatkan mutu pelayanan ANC berbasis bukti secara berkelanjutan.

H. Simpulan

Pelayanan Antenatal Care (ANC) yang berkualitas merupakan fondasi utama dalam upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu serta bayi. Materi dalam bab ini menegaskan bahwa penerapan *Evidence-Based Midwifery* (EBM) dalam pelayanan ANC, khususnya melalui pendekatan ANC 10 T, menuntut integrasi yang harmonis antara bukti ilmiah terbaik, keahlian klinis bidan, serta nilai dan preferensi ibu. Implementasi EBM di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan sarana, variasi kepatuhan terhadap standar pelayanan, serta pengaruh budaya dan tingkat literasi kesehatan ibu. Namun demikian, tantangan tersebut sekaligus membuka peluang strategis untuk memperkuat peran bidan sebagai praktisi profesional yang adaptif, reflektif, dan berbasis bukti.

Upaya peningkatan kualitas ANC berbasis evidence dapat dilakukan melalui penguatan kompetensi bidan secara berkelanjutan, pemanfaatan pedoman dan hasil riset terkini, pelaksanaan audit mutu dan refleksi praktik, penguatan kolaborasi interprofesional, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan kebidanan. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap standar, tetapi juga pada peningkatan mutu asuhan yang berpusat pada ibu (*woman-centered care*).

1. Implikasi bagi Praktik Kebidanan

Bagi praktik kebidanan, penerapan EBM mendorong bidan untuk mengambil keputusan klinis yang lebih rasional, aman, dan efektif berdasarkan bukti ilmiah terkini. Bidan dituntut untuk terus memperbarui pengetahuan, melakukan refleksi praktik, serta mengintegrasikan preferensi dan kondisi sosial budaya ibu dalam setiap asuhan ANC. Dengan demikian, kualitas pelayanan menjadi lebih konsisten dan berorientasi pada hasil kesehatan ibu dan janin.

2. Implikasi bagi Pendidikan Kebidanan

Dalam konteks pendidikan, integrasi *Evidence-Based Midwifery* perlu diperkuat dalam kurikulum kebidanan, baik pada tahap akademik maupun

profesi. Pembelajaran harus menekankan keterampilan pencarian, penilaian kritis, dan penerapan bukti ilmiah dalam situasi klinis nyata. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan lulusan bidan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis dan komitmen terhadap praktik berbasis bukti.

3. Implikasi bagi Kebijakan Kebidanan

Dari sisi kebijakan, diperlukan dukungan regulasi dan sistem kesehatan yang kondusif untuk implementasi EBM dalam pelayanan ANC. Hal ini mencakup penyediaan sarana prasarana yang memadai, penguatan sistem supervisi dan audit mutu, serta kebijakan pengembangan profesional berkelanjutan bagi bidan. Kebijakan yang responsif terhadap bukti ilmiah dan konteks lokal akan memperkuat peran bidan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ibu secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penerapan *Evidence-Based Midwifery* dalam pelayanan ANC merupakan investasi strategis bagi peningkatan kualitas pelayanan kebidanan. Sinergi antara praktik, pendidikan, dan kebijakan yang berbasis bukti menjadi kunci utama dalam mewujudkan pelayanan ANC yang bermutu, berkeadilan, dan berorientasi pada keselamatan ibu dan bayi.

I. Referensi

- Astri Nurdiana & Nurlailasari, E. (2025). Antenatal care quality measurement conducted by midwives in Karawang, Indonesia. *Journal of Health Technology Assessment in Midwifery*.
- Ayres, J., [et al.]. (2021). Antenatal and intrapartum care evidence implementation project guided by JBI methodology: audit and feedback in practice. *Journal of Evidence Implementation*.
- Evaluasi Pelayanan ANC 10T di Puskesmas (2024). *Journal of Public Health and Nutrition*.
- Evidence based practice in midwifery care. (2022). *International Journal of Obstetrics and Gynaecological Nursing*.
- Evidence-Based Education Programs to Improve Maternal ... (2025). *Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing*.
<https://www.jognn.org/article/S0884-2175%2824%2900297-1/fulltext>
- Fikre, R., et al. (2023). Effectiveness of midwifery-led care on pregnancy outcomes in low- and middle-income countries. *BMC Pregnancy and Childbirth*.

- Implementasi antenatal care terpadu sebagai upaya deteksi dini anemia pada ibu hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Buaran. (2023). *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal*, 14(01), 127–132. <https://doi.org/10.34305/jikbh.v14i01.683>
- Implementation of evidence-based practice: The experience of nurses and midwives. (2021). PubMed. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34449782/>
- Improved Self-Assessed Collaboration Through Interprofessional Education: Midwifery Students and Obstetrics and Gynecology Residents Learning Together. (2022). *Journal of Interprofessional Care*. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35841336/>
- Improving midwifery curriculum in Indonesia through evidence-based practice integration: Scoping review. (2025). *Curricula: Journal of Curriculum Development*. <https://ejournal.upi.edu/index.php/CURRICULA/article/view/82550>
- Improving midwifery curriculum in Indonesia through evidence-based practice integration: Scoping review. (2025). *Curricula: Journal of Curriculum Development*. <https://ejournal.upi.edu/index.php/CURRICULA/article/view/82550/0>
- Intan Sari, A., Anggrayani, M., & Fradela, F. A. (2025). Pentingnya Antenatal Care Ibu Hamil sebagai upaya pencegahan komplikasi kehamilan dan kejadian stunting pada bayi. *Indonesian Journal of Community Empowerment (IJCE)*, 7(1), 50–54. <https://doi.org/10.35473/ijce.v7i1.3941>
- JB I Evidence Implementation: Antenatal and Intrapartum Care for Women with GD. (2023). *International Journal of Evidence-Based Healthcare*. https://journals.lww.com/ijebh/Abstract/9900/Establishing_midwife_led_continuity_of_care.17.aspx
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2015). *Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu*. Kemenkes RI.
- Maternal health literacy and antenatal care program in ... (2025). *Journal of Health Services & Policy*. <https://stikbar.org/ycabpublisher/index.php/jhsp/article/download/1220/506>
- Midwives' perceptions of barriers to implementing evidence-based practice in Northern Jordan. (2026). *SAGE Open Nursing*. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12816508/>
- Rahmadhani, I., & Hikmah, F. (2025). Analisis pelaksanaan pelayanan antenatal care (ANC) pada ibu hamil di Puskesmas Candipuro Kabupaten Lumajang. *J-REMI*:

Jurnal Rekam Medik dan Informasi Kesehatan. <https://doi.org/10.25047/j-remi.v1i4.2089>

Rosnidawati, R. (2025). Pengaruh edukasi tentang antenatal care terhadap kejadian komplikasi kehamilan pada ibu selama kehamilan. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*. <https://doi.org/10.37287/jppp.v7i5.531>

Simamora, D. N., Peluw, Z., Nurseha, N., Nurhikmah, N., & Astutik, H. (2024). Optimizing maternal health outcomes: The role of midwifery in providing holistic and evidence-based care for pregnant women. *Global International Journal of Innovative Research*, 2(11), 2676–2689.

Suganda Putri, I. A., Munawaroh, M., Khaer, D. M., & Hernawati, H. (2026). Analisis kualitas pelayanan antenatal care (ANC) terhadap tingkat kepuasan ibu hamil. *JUMIN: Jurnal Media Informatika*. <https://doi.org/10.55338/jumin.v6i2.5697>

World Health Organization. (2016). WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241549912>

World Health Organization. (2018). Antenatal care (ANC) definition and overview. National Center for Biotechnology Information. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK409110/>

Xu, Y., et al. (2026). Effect of antenatal education and midwifery-led care on maternal psychological and obstetric outcomes: A systematic review. *Journal of Perinatal Care* (in press).

J. Glosarium

AKI = Angka Kematian Ibu

AKB = Angka Kematian Bayi

ANC = Antenatal Care

EBP = evidence-based practice

IUGR = intrauterine growth restriction

e-iANC = Electronic Integrated Antenatal Care

LILA = Lingkar Lengan Atas

KEK = Kekurangan Energi Kronis

SOP = Standar Operasional Prosedur

TT = Tetanus Toxoid

WHO = World Health Organization

CHAPTER 2

MANAJEMEN LAKTASI, NUTRISI IBU MENYUSUI, DAN PENCEGAHAN STUNTING 1000 HPK

Subriah, S.ST., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Saat ini Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menghadapi situasi gizi kompleks, dimana prevalensi masalah kekurangan gizi termasuk stunting dan kekurangan zat gizi mikro, kelebihan gizi (overweight dan obesitas) serta penyakit tidak menular akibat gizi terjadi dalam waktu yang bersamaan. Kekurangan gizi pada awal kehidupan atau usia dini akan berdampak serius terhadap kualitas SDM di masa depan. Anak dapat mengalami kegagalan pertumbuhan sehingga mengakibatkan berat badan lahir rendah, pendek, kurus, serta daya tahan tubuh yang rendah. Selain itu anak dengan kurang gizi akan berisiko mengalami hambatan perkembangan otak/kognitif. Dalam mengatasi masalah ini maka diperlukan kebijakan serta strategi yang tepat sehingga dapat menunjang percepatan perbaikan gizi masyarakat terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK).

Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan salah satu komitmen global (Resolusi WHA 65.6. tahun 2012) terhadap perbaikan masalah gizi, yaitu meningkatkan cakupan ASI eksklusif pada 6 bulan pertama sampai 50% di tahun 2024, sudah cukup kuat, terbukti dengan dikeluarkannya berbagai macam peraturan dalam mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022)

Manajemen laktasi, nutrisi ibu menyusui, dan pencegahan stunting pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) merupakan komponen penting dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak. Periode 1000 HPK, yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun, adalah masa emas yang sangat menentukan pertumbuhan, perkembangan, serta kesehatan jangka panjang anak. Keberhasilan pemberian ASI yang optimal melalui manajemen laktasi yang baik, didukung oleh status gizi ibu menyusui yang adekuat, berperan besar dalam pemenuhan kebutuhan gizi bayi secara optimal.

Dasar pembentukan manusia berkualitas dimulai sejak bayi di dalam kandungan yang disertai pemberian ASI. Pola pemberian makan yang baik untuk bayi sejak lahir sampai anak berusia dua tahun meliputi: 1) pemberian ASI kepada bayi dengan segera dalam waktu satu jam setelah lahir (inisiasi menyusui dini/IMD);

dan 2) pemberian hanya ASI saja sejak bayi lahir sampai usia enam bulan sebagai makanan utama bayi (ASI eksklusif) yang dilanjutkan hingga usia dua tahun bersamaan dengan pemberian MPASI. Pemberian asupan gizi dan stimulasi yang cukup sejak lahir dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan bayi. Tidak terlaksananya IMD dan gagalnya pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya stunting. (Lucy Widasari, 2023a)

Selain itu, nutrisi ibu menyusui yang seimbang dan berkualitas tidak hanya berpengaruh terhadap produksi dan kualitas ASI, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam pencegahan stunting. Stunting merupakan masalah gizi kronis yang berdampak pada terhambatnya pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai manajemen laktasi, pemenuhan nutrisi ibu menyusui, serta strategi pencegahan stunting sejak 1000 HPK sangat diperlukan sebagai langkah preventif untuk mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas.

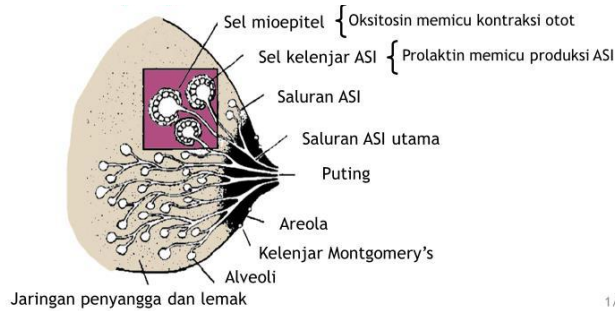
B. Konsep Dasar Laktasi dan Fisiologi Produksi ASI

Air susu ibu (ASI) adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu. ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi karena mengandung zat gizi yang seimbang dan sempurna untuk tumbuh kembang bayi. Pemberian ASI hingga usia enam bulan memberikan pemenuhan gizi yang optimal untuk bayi. ASI juga merupakan sumber energi dan zat gizi yang penting bagi anak usia 6-23 bulan. ASI dapat memberikan setengah atau lebih dari kebutuhan energi anak antara usia enam dan dua belas bulan, dan sepertiga dari kebutuhan energi antara 12 dan 24 bulan. Selain kaya akan zat gizi, higienitas ASI juga terjamin karena suhunya sesuai serta tidak membutuhkan persiapan dan dapat langsung dikonsumsi bayi, sehingga tidak terpengaruh dengan kondisi lingkungan dengan sanitasi yang buruk maupun ketersediaan air minum yang tidak aman. (Lucy Widasari, 2023a)

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa menyusui membantu proses perkembangan intelektual anak. Terdapat perbedaan Intelligence Quotient (IQ) secara signifikan pada bayi yang diberi ASI dengan bayi yang diberi susu formula. Bayi yang diberi ASI lebih cerdas dan tidak mudah sakit. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022)

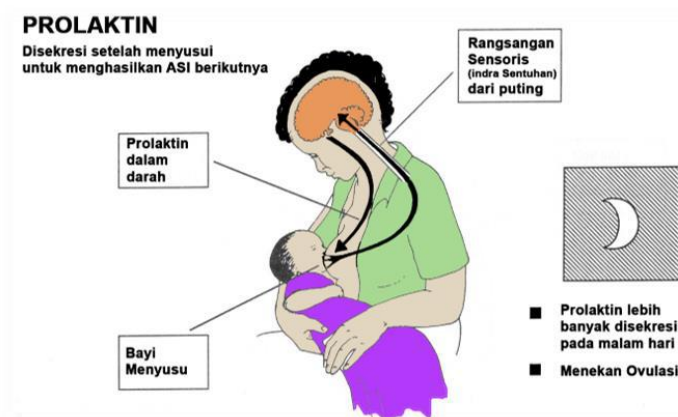
Pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana cara kerja menyusui akan memungkinkan Anda membantu ibu/pengasuh. Dalam materi ini, kita meninjau anatomi payudara, fisiologi menyusui dan pelekatan saat menyusui. Kita akan membahas produksi ASI dan transfer ASI dari ibu ke bayi. Tujuan Anda sebagai tenaga kesehatan adalah membantu ibu/pengasuh memutuskan apa yang terbaik

untuk situasi mereka. Jika Anda memahami cara kerja menyusui, Anda akan memiliki pemahaman yang lebih dalam dan memberikan dukungan yang lebih spesifik.



Gambar 2.1 Antomi Payudara
Sumber: Lucy Widasari dkk, 2023.

Tahap pertama produksi ASI berada di bawah kendali hormon. Selama kehamilan, hormon membantu payudara berkembang dan bertambah besar. Payudara juga mulai membuat kolostrum, yang datang saat bayi lahir. Setelah lahir, hormon kehamilan menurun. Dua hormon, yaitu prolaktin dan oksitosin, menjadi penting. Prolaktin membantu produksi susu dan oksitosin mengalirkan ASI.



Gambar 2.2 Prolaktin dan produksi

Kadar prolaktin menjadi tinggi pada masa kehamilan. Namun, hormon ini tidak dapat membuat sel mengeluarkan ASI karena dihalangi oleh hormon progesteron dan estrogen. Setelah melahirkan, jumlah progesteron menurun dan prolaktin dapat mulai bekerja. Hormon ini membuat produksi ASI meningkat segera setelah melahirkan. Jumlah prolaktin meningkat ketika ibu dan bayi saling bersentuhan.

Setelah dua hingga tiga hari pasca persalinan, ibu akan memperhatikan bahwa payudaranya terasa penuh. Tenaga kesehatan mungkin menyebutnya sebagai "ASI keluar", tetapi akan lebih membantu jika ibu diajari tentang ASI yang mulai berubah (dari kolostrum menjadi ASI transisi). Ini adalah saat pasokan ASI meningkat dan berubah dari kolostrum. Ingat bahwa payudara awalnya menghasilkan ASI yang

disebut kolostrum. Jumlahnya kecil, tapi hanya itu yang dibutuhkan oleh bayi setelah lahir.

Saat bayi menyusui di payudara, impuls sensorik berpindah dari puting susu ke otak. Sebagai tanggapannya, kelenjar pituitari di otak mengeluarkan prolaktin. Prolaktin berpindah dari darah ke payudara dan membuat sel-sel penghasil susu memproduksi ASI. Sebagian besar prolaktin masuk ke dalam darah sekitar 45 menit setelah menyusui. Ini membantu payudara untuk terus memproduksi ASI setelah menyusui agar siap menyusui lagi. Saat sedang menyusui, bayi mengambil ASI yang sudah ada di payudara. ASI disimpan di alveoli dan saluran yang lebih kecil.

Poin penting tentang prolaktin. Prolaktin lebih banyak diproduksi pada malam hari, saat ibu sedang rileks. Menyusui di malam hari bermanfaat untuk meningkatkan pasokan ASI. Prolaktin membuat ibu merasa rileks, dan terkadang mengantuk. Ibu biasanya bisa beristirahat dengan baik meskipun menyusui di malam hari.



Gambar 2.3 Oksitosin

Saat bayi menyusui, impuls sensorik berpindah dari puting ke otak. Sebagai tanggapannya, kelenjar pituitari di dasar otak mengeluarkan oksitosin. Hormon oksitosin mengalir dari darah ke payudara dan membuat sel-sel otot di sekitar alveoli berkontraksi. ASI yang terkumpul di alveoli mengalir di sepanjang saluran ke saluran yang lebih besar di bawah areola. Ini adalah refleks oksitosin, refleks pengeluaran ASI atau refleks "let-down". Saat refleks bekerja, saluran di bawah areola terisi dengan ASI dan ukurannya membesar. Terkadang ASI merembes ke luar. Oksitosin memungkinkan bayi mendapatkan ASI.

Oksitosin diproduksi lebih cepat daripada prolaktin. Hormon ini membuat ASI mengalir untuk menyusui. Oksitosin dapat mulai bekerja sebelum bayi menyusui, ketika seorang ibu akan menyusui. Oksitosin membuat rahim ibu berkontraksi setelah melahirkan dan membantu mengurangi pendarahan. Terkadang kontraksi menyebabkan nyeri rahim dan aliran darah saat menyusui selama beberapa hari pertama. Rasa sakitnya bisa sangat kuat, terkadang disebut "afterpain". Ini adalah

kesempatan untuk menginformasikan kepada ibu/pengasuh tentang proses ini, jadi mereka tidak khawatir.

Membantu dan menghambat refleks oksitosin



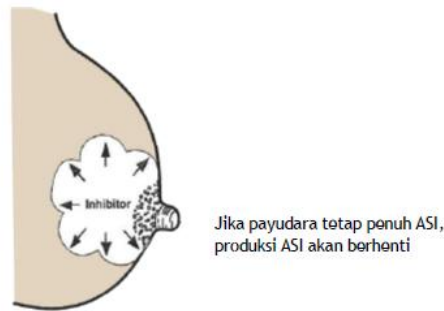
Gambar 2.4 Membantu dan menghambat refleks Oksitosin

Oksitosin kadang-kadang disebut "hormon cinta" karena perannya dalam membantu ibu menjalin ikatan dan mencintai bayinya. Karena kadar oksitosin yang lebih rendah, ibu yang memberi susu botol pada bayinya mungkin tidak memiliki perasaan yang sama.

Bagaimana refleks oksitosin dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan ibu. Perasaan positif seperti perasaan bahagia tentang bayi atau rasa percaya diri dapat membantu kerja refleks oksitosin. Perasaan lain seperti sakit, khawatir, dan ragu dapat menghalangi refleks. Selain itu, seorang ibu mungkin mengalami nyeri akibat puting sakit atau persalinan, atau ia mungkin ragu memiliki cukup banyak ASI. Ini bisa menghambat aliran ASI.

Stres dan trauma akut juga bisa menghalangi refleks. Ibu mungkin mengira payudaranya berhenti memproduksi ASI. Payudara menghasilkan ASI, tapi tidak mengalir keluar. Oleh karena itu, bayi sulit mendapatkan ASI dari payudara. Untungnya, efek ini biasanya bersifat sementara dan dapat diatasi. Seorang ibu harus selalu dekat dengan bayinya agar bisa melihat, menyentuh, dan menanggapi bayinya. Ini membantu tubuhnya untuk bersiap menyusui, dan agar ASI-nya mengalir. Jika seorang ibu dipisahkan dari bayinya di antara waktu menyusui, refleks oksitosinnya mungkin tidak bekerja dengan baik

Anda mungkin memperhatikan beberapa dari tanda-tanda ini saat Anda mengamati ibu dan bayi. Tanyakan kepada ibu apakah dia memperhatikannya juga. Jika ada satu atau lebih tanda atau sensasi, dapat dipastikan bahwa refleks oksitosinnya sedang aktif. Ini berarti ASI seharusnya mengalir. Namun meski refleksnya aktif, ibu mungkin tidak merasakan sensasi atau tanda-tandanya tidak terlihat jelas.



Zat 2.5 Zat penghambat ASI (FIL)

Produksi ASI juga dikontrol di dalam payudara itu sendiri. Dalam beberapa kasus, salah satu payudara berhenti menghasilkan ASI, sedangkan payudara satunya terus memproduksi ASI. Oksitosin dan prolaktin bekerja di kedua payudara. Slide ini membantu kita memahami alasannya.

ASI mengandung berbagai faktor untuk mengontrol atau menghambat produksi susu. Salah satu faktor utama disebut Feedback Inhibitor Lactation (FIL). Jika ASI tidak dikeluarkan dan payudara penuh, inhibitor ini menurunkan produksi ASI. Jika ASI dikeluarkan dari payudara, maka tingkat inhibitor turun dan produksi ASI meningkat. Jadi, jumlah ASI yang diproduksi tergantung pada seberapa banyak ASI yang dikeluarkan

Poin-poin penting

1. Jika bayi berhenti menyusu dari satu payudara, payudara itu akan berhenti menghasilkan ASI.
2. Jika bayi menyusu lebih banyak dari satu payudara, payudara itu akan menghasilkan lebih banyak ASI dan menjadi lebih besar dari payudara satunya.
3. Agar payudara terus menghasilkan ASI, ASI harus dikeluarkan.
4. Jika bayi tidak dapat menyusu dari salah satu atau kedua payudara, ASI harus dikeluarkan dengan cara diperah agar produksi dapat terus berlanjut.
5. Pengendalian autokrin melalui isapan bayi terhadap produksi ASI ini sangat penting setelah beberapa minggu pertama, ketika tingkat prolaktin menurun.
6. Produksi ASI adalah proses supply and demand: Tubuh ibu menghasilkan ASI sebanyak yang diminum oleh bayi. Agar ibu dapat menghasilkan cukup banyak ASI, bayi harus sering menyusu. Payudaranya akan merespons dan menghasilkan ASI sebanyak yang diminum oleh bayi. Untuk mengeluarkan dan mentransfer ASI secara efisien, bayi perlu menyusu dengan efektif.

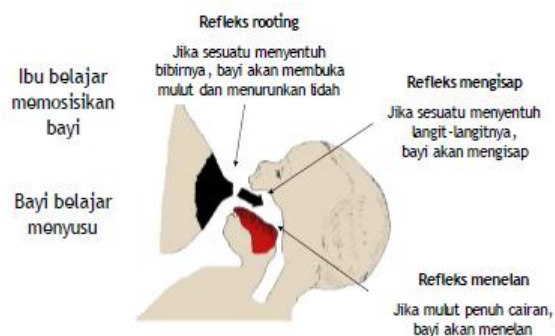
C. Teknik Menyusui, Manajemen Masalah Laktasi, dan Pendampingan Ibu

Air susu ibu (ASI) mengandung semua gizi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh kembang sehat serta menjaga daya tahan tubuhnya. Oleh karena itu, penting bagi Ibu untuk memberikan hanya ASI saja kepada bayi hingga usia 6 bulan, kemudian dilanjutkan hingga usia 2 tahun. (Kemenkes, 2024)

	
Posisi yang baik yaitu Kepala dan badan bayi membentuk garis lurus, Wajah bayi menghadap payudara, hidung berhadapan dengan puting susu, badan bayi dekat ke tubuh ibu dan Ibu menggendong/mendekap badan bayi secara utuh	Pelekatan yang baik yaitu bayi dekat dengan payudara dengan mulut terbuka lebar. • Dagu bayi menyentuh payudara. Bagian areola di atas lebih banyak terlihat dibanding di bawah mulut bayi. Bibir bawah bayi memutar keluar (dower).

Gambar 2.6 Posisi dan pelekatan yang baik (Kemenkes, 2024)

Ketika bayi melekat dengan baik, ASI akan dengan mudah dikeluarkan dan dipindahkan, ini disebut menyusui dengan efektif. Anda dapat melihat dan mendengar bayi menelan ASI saat menyusui dengan efektif.



Gambar 2.7 Refleks menyusui pada bayi

Refleks terjadi secara otomatis sebagai respons terhadap rangsangan tertentu. Ada tiga refleks utama yang berhubungan dengan menyusui:

Refleks rooting	Refleks mengisap	Refleks menelan
Ketika sesuatu menyentuh bibir atau pipi bayi, ia akan berpaling kepadanya. Bayi kemudian membuka mulutnya, terutama jika bibir atasnya disentuh. Ini adalah refleks "rooting". Biasanya puting atau payudara bayi yang dicari oleh bayi.	Ketika sesuatu menyentuh langit-langit, bayi mulai mengisapnya. Ini adalah refleks mengisap. Saat ibu mendekatkan bayi dengan mulut terbuka ke payudara sehingga puting menyentuh langit-langit lunak, hal ini merangsang refleks mengisap bayi.	Saat mulut bayi terisi ASI, ia akan menelan. Ini adalah refleks menelan

Refleks rooting, mengisap dan menelan terjadi secara otomatis pada bayi cukup bulan yang sehat. Namun, bayi tidak sepenuhnya otomatis memasukkan payudara cukup jauh ke dalam mulutnya. Seorang bayi harus dipeluk dekat payudara dan mendekati payudara dari bawah puting.

Sebagian besar bayi cukup bulan yang sehat dapat melekat pada payudara secara naluriah dalam satu jam pertama setelah lahir. Ibu dan bayi harus selalu bersama dalam lingkungan yang nyaman dan suportif yang membantu refleks. Ibu perlu belajar bagaimana menghindari posisi tidak nyaman dan cara menggendong bayi yang menghambat refleksnya. Tenaga kesehatan tidak perlu ikut campur jika semuanya berjalan dengan baik. Namun, mereka harus waspada terhadap ibu yang memang membutuhkan bantuan. Beberapa bayi membutuhkan lebih banyak bantuan daripada yang lain untuk belajar melekat dan menyusui secara efektif. (Lucy Widasari, 2023a)

D. Kebutuhan Gizi Ibu Menyusui dan Pengaruhnya terhadap Kualitas ASI

Gizi seimbang pada ibu menyusui dapat diartikan bahwa asupan gizi ibu harus memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan untuk pertumbuhan serta perkembangan bayinya. Asupan gizi ibu sangat penting karena berkaitan dengan status gizi ibu dan produksi air susu ibu, serta tumbuh kembang bayi. Asupan gizi ibu harus memenuhi

kaidah gizi seimbang sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang ditetapkan. Ibu perlu mengonsumsi makanan yang beragam dan kaya akan zat gizi dari berbagai sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Porsi dan frekuensi makan juga harus diatur dengan baik agar kebutuhan gizi terpenuhi. (Lucy Widasari, 2023a)

Secara teori, kebutuhan energi ibu meningkat sekitar 330 kkal pada enam bulan pertama menyusui dan 400 kkal pada enam bulan berikutnya. Penambahan kalori diperlukan untuk cadangan lemak, pertumbuhan payudara, pertumbuhan bayi yang disusui, dan peningkatan angka metabolisme basal (Basal Metabolic Rate/BMR). Menyusui membutuhkan kalori ekstra, sehingga apabila ibu masih memiliki kelebihan berat badan dari kehamilan, kalori ekstra ini secara alami akan digunakan untuk produksi ASI.

Ibu menyusui perlu banyak mengonsumsi aneka ragam makanan untuk memenuhi kebutuhan energi, zat gizi makro (protein, lemak, dan karbohidrat). Ibu juga memerlukan zat gizi mikro (vitamin dan mineral). Semua ini untuk memelihara kesehatan ibu dan produksi ASI.

Tambahan protein diperlukan untuk mendukung pertumbuhan payudara dan sintesis hormon untuk produksi ASI. Kebutuhan protein selama 1 tahun pertama menyusui bertambah 15 sampai 20 gram per hari dari kebutuhan wanita dewasa, sehingga asupan protein yang dibutuhkan menjadi sekitar 67 sampai 70 gram protein per hari. Ibu sangat dianjurkan untuk mengonsumsi makanan sumber protein hewani seperti ikan, susu, dan telur. (Lucy Widasari, 2023a)

E. Stunting dan ibu Menyusui

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah -2 standar deviasi (-2 SD) dari standar WHO untuk pertumbuhan anak. Stunting memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang, tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi masyarakat hingga negara karena berdampak pada kualitas sumber daya manusia (Lucy Widasari, 2023b)

Kebutuhan gizi pada masa kehidupan pertama bayi (enam bulan pertama) dipenuhi oleh ibunya melalui air susu ibu (ASI). Ibu menyusui harus memiliki gizi yang seimbang, karena sangat erat kaitannya dengan produksi ASI. Pemenuhan gizi yang baik akan berpengaruh terhadap status gizi ibu menyusui dan tumbuh kembang bayinya. Ibu menyusui harus memperhatikan setiap makanannya karena akan memengaruhi kualitas dan kuantitas ASI.

Periode menyusui juga merupakan masa yang sangat penting bagi bayi dan ibu. Pada periode ini, hubungan emosional antara bayi dan ibu akan terbentuk dengan baik dalam perkembangan mental dan psikis bayi. Selain itu, pada masa ini,

bayi dapat merasakan besarnya kasih sayang dan kehangatan yang diberikan oleh ibu kepadanya.

Jika dibandingkan dengan air susu lainnya, ASI memiliki proporsi zat gizi yang lebih tinggi dan keanekaragaman asam lemak yang mendukung pertumbuhan otak manusia. ASI tidak hanya mengandung zat gizi, tetapi juga hormon, unsur kekebalan, anti alergi, dan anti peradangan. Pemberian ASI secara eksklusif dapat dimulai secepatnya setelah bayi dilahirkan atau disebut inisiasi menyusui dini (IMD). Menyusui perlu dilanjutkan hingga anak berusia dua tahun, dengan pemberian makanan pendamping ASI (MPASI) yang adekuat pada usia enam bulan

Keberhasilan ibu dalam melakukan IMD dan pemberian ASI eksklusif secara optimal dapat meningkatkan kecerdasan anak. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh dukungan keluarga, terutama dukungan dari suami.

Suami bukan sekadar pengambil keputusan atau pencari nafkah, tetapi juga ikut berperan dalam mendukung, memotivasi, dan mendampingi ibu agar sukses menyusui secara eksklusif. Dukungan yang dapat diberikan (Lucy Widasari, 2023b)

F. Simpulan

Indonesia menghadapi tantangan gizi ganda yang kompleks karena masalah kekurangan gizi (termasuk stunting dan defisiensi zat gizi mikro) berjalan bersamaan dengan kelebihan gizi dan penyakit tidak menular terkait gizi. Kondisi ini menegaskan bahwa intervensi perbaikan gizi harus dilakukan secara strategis, terutama pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) yang menjadi masa emas penentu pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, dan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Dalam konteks tersebut, manajemen laktasi, pemenuhan gizi ibu menyusui, serta pencegahan stunting merupakan komponen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.

ASI terbukti menjadi makanan terbaik bagi bayi karena kandungan gizinya seimbang, higienis, dan memberikan perlindungan imunologis yang kuat. Pemberian ASI sejak dini melalui inisiasi menyusui dini (IMD) dan keberhasilan ASI eksklusif selama 6 bulan menjadi fondasi utama pemenuhan gizi bayi, yang kemudian dilanjutkan dengan MPASI yang adekuat hingga usia 2 tahun. Secara fisiologis, produksi dan pengeluaran ASI dikendalikan oleh mekanisme hormon prolaktin dan oksitosin serta pengendalian lokal melalui FIL (Feedback Inhibitor of Lactation), sehingga prinsip "supply and demand" menjadi kunci: semakin sering dan efektif bayi menyusui, semakin baik produksi ASI. Karena itu, teknik menyusui yang benar terutama posisi dan pelekatan yang efektif serta pendampingan ibu untuk mengatasi masalah laktasi sangat menentukan keberhasilan menyusui.

Di sisi lain, kualitas dan kuantitas ASI sangat dipengaruhi oleh kondisi gizi ibu. Ibu menyusui membutuhkan asupan energi dan zat gizi makro-mikro yang memadai untuk menjaga kesehatan dirinya dan mendukung produksi ASI, termasuk tambahan energi dan protein selama masa laktasi. Pemenuhan gizi ibu yang baik sekaligus menjadi strategi penting pencegahan stunting, karena stunting bukan hanya persoalan tinggi badan, tetapi berdampak pada kesehatan jangka panjang, kemampuan belajar, dan produktivitas generasi mendatang. Selain aspek biologis, keberhasilan menyusui juga dipengaruhi faktor psikososial, termasuk dukungan keluarga terutama suami yang berperan besar dalam menjaga motivasi ibu dan keberlanjutan pemberian ASI.

Dengan demikian, upaya menurunkan stunting dan memperbaiki kualitas gizi pada 1000 HPK harus dilakukan secara terintegrasi melalui kebijakan yang kuat, layanan kesehatan yang konsisten, edukasi yang tepat, pendampingan manajemen laktasi, pemenuhan gizi ibu, serta dukungan keluarga dan lingkungan. Keberhasilan langkah-langkah ini menjadi investasi utama untuk mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas.

G. Referensi

- Kemenkes. (2024). Buku KIA Kesehatan Ibu dan Anak Panduan lengkap untuk mewujudkan ibu dan anak sehat. Kemenkes.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Pelatihan, Modul Konseling, Pelatih Ri, Kemenkes.
- Lucy Widasari, F. E. dkk. (2023a). Stunting-Pedia Apa yang Perlu Diketahui tentang Stunting Jilid 1 Konsep Stunting dan Daur Kehidupan (F. J. Abdul Razak Thaha (ed.)). KPG (Kepustakaan Popular Gramedia) dan Tanoto Foundation.
- Lucy Widasari, F. E. dkk. (2023b). Stunting-Pedia Apa yang Perlu Diketahui Tentang Stunting Jilid 2 Penanganan Stunting (2nd ed.). Tanoto Foundation.

H. Glosarium

ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu. ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi karena mengandung zat gizi yang seimbang dan sempurna untuk tumbuh kembang bayi.

ASI Eksklusif adalah Air susu ibu (ASI) adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu. ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi karena mengandung zat gizi yang seimbang dan sempurna untuk tumbuh kembang bayi. Pemberian ASI hingga usia enam bulan

AKG adalah Angka Kecukupan Gizi, yaitu nilai rata-rata kebutuhan zat gizi harian yang dianjurkan bagi hampir seluruh orang sehat menurut kelompok umur, jenis kelamin, dan kondisi fisiologis (seperti hamil dan menyusui).

Basal Metabolic Rate/BMR adalah jumlah energi minimal yang dibutuhkan tubuh untuk mempertahankan fungsi dasar kehidupan saat tubuh dalam kondisi istirahat total, seperti bernapas, sirkulasi darah, fungsi otak, dan pengaturan suhu tubuh

Gizi Mikro adalah zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil, namun memiliki peran sangat penting dalam menjaga fungsi metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan daya tahan tubuh

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) adalah proses meletakkan bayi yang baru lahir di dada atau perut ibu segera setelah lahir (dalam 1 jam pertama kehidupan) untuk memungkinkan bayi mencari dan menyusui sendiri pada payudara ibu.

Intelligence Quotient (IQ) adalah ukuran kemampuan intelektual seseorang, yang mencerminkan kemampuan berpikir, bernalar, memecahkan masalah, memahami konsep, serta belajar dan menyesuaikan diri dengan lingkungan.

Kolostrum adalah ASI pertama yang keluar pada hari-hari awal setelah persalinan ($\pm$ hari ke-1 sampai ke-3), berwarna kekuningan, kental, dan diproduksi dalam jumlah sedikit namun sangat kaya akan zat gizi dan antibodi.

MPASI adalah Makanan Pendamping Air Susu Ibu, yaitu makanan atau minuman yang diberikan kepada bayi mulai usia 6 bulan, ketika ASI saja sudah tidak lagi mencukupi kebutuhan gizi bayi.

Obesitas adalah kondisi kelebihan lemak tubuh yang berlebihan sehingga dapat mengganggu kesehatan, yang umumnya ditentukan berdasarkan Indeks Massa Tubuh (IMT) $\geq 30 \text{ kg/m}^2$ pada orang dewasa.

Overweight adalah kondisi berat badan seseorang yang melebihi berat badan normal, namun belum termasuk kategori obesitas, yang ditentukan berdasarkan Indeks Massa Tubuh (IMT) $25,0\text{--}29,9 \text{ kg/m}^2$ pada orang dewasa.

Oksitosin adalah hormon yang berperan dalam pengeluaran ASI (let-down reflex) serta membantu kontraksi rahim setelah persalinan, yang diproduksi oleh hipotalamus dan dilepaskan melalui kelenjar hipofisis posterior.

Prolaktin adalah hormon yang berperan utama dalam produksi ASI, yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis anterior (pituitari) di otak.

Rooting adalah refleks alami pada bayi baru lahir yang ditandai dengan gerakan menolehkan kepala dan membuka mulut ke arah rangsangan sentuhan di pipi atau sekitar mulut, sebagai tanda kesiapan untuk menyusu.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah -2 standar deviasi (-2 SD) dari standar WHO untuk pertumbuhan anak

CHAPTER 3

FARMAKOVIGILANS OBAT DAN SUPLEMEN PADA IBU HAMIL, MENYUSUI, DAN ANAK

Anggun Fajar Ramadhani, S.Kep., Ners., M.Kep.

A. Pendahuluan/Prolog

Farmakovigilans didefinisikan oleh *World Health Organisation* (WHO, 2020 dalam Aurich *et al.*, 2022) sebagai “ilmu dan aktivitas yang berkaitan dengan deteksi, penilaian, pemahaman, dan pencegahan efek samping atau masalah terkait obat lainnya”. Farmakovigilans dilakukan sepanjang siklus hidup produk obat, dimulai dengan pemberian pertama pada manusia dan biasanya berakhir ketika produk tersebut tidak lagi dipasarkan di banyak negara. Farmakovigilans dilakukan pada data keamanan yang berasal dari berbagai sumber dan negara mencakup evaluasi berkelanjutan dari semua data global yang tersedia (yaitu, data non-klinis dan klinis, termasuk laporan yang diminta dan spontan). Selain itu, data untuk populasi pasien khusus dievaluasi (misalnya, pasien dengan gangguan hati atau ginjal, wanita hamil, anak-anak, dan lansia). Farmakovigilans memantau data tingkat kasus dan tingkat populasi untuk mendeteksi dan menganalisis risiko terkait pengobatan. Istilah risiko mencakup setiap masalah keamanan terkait pengobatan seperti reaksi obat yang merugikan (ADR (*adverse drug reactions*)), interaksi, kesalahan pengobatan, kurangnya kemanjuran, reaksi terhadap eksipien, kurangnya kepatuhan, masalah perangkat jika relevan atau kekhawatiran lain yang terkait dengan penggunaan obat-obatan (Aurich *et al.*, 2022). Farmakovigilans bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang risiko yang diketahui (yaitu, yang telah diidentifikasi) dan risiko potensial, serta mengumpulkan data keamanan yang hilang atau tidak lengkap (misalnya, faktor risiko untuk risiko yang telah diidentifikasi; data keamanan lebih lanjut tentang risiko potensial).

WHO bekerjasama dengan *Centre for International Drug Monitoring* di Uppsala, Swedia membentuk program internasional untuk mengawasi penggunaan obat sebagai respon atas terjadinya tragedi Thalidomide. Sampai dengan akhir tahun 2010 sudah 134 negara tergabung dalam program Farmakovigilans WHO tersebut. Tujuan program ini adalah untuk memberikan informasi yang seimbang dan terpercaya dalam penilaian profil risiko manfaat dari suatu obat (Ren *et al.*, 2021). Termasuk dalam kegiatan Farmakovigilans adalah pengumpulan laporan dugaan efek yang tidak diinginkan (*suspected adverse reaction*). *Adverse reaction*

adalah respons terhadap produk pengobatan (medical products) yang berbahaya dan tidak diinginkan, termasuk yang ditimbulkan pada kondisi penggunaan sesuai izin edar yang disetujui, penggunaan di luar izin yang disetujui termasuk penggunaan dalam dosis berlebih, penggunaan di luar indikasi (off-label use), penggunaan yang tidak tepat (misuse), penyalahgunaan (abuse) dan kesalahan pengobatan (medication error), serta paparan akibat pekerjaan (occupational exposure). Secara khusus Farmakovigilans diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kesehatan masyarakat terhadap risiko akibat penggunaan obat (Burnham, & Darsey, 2022).

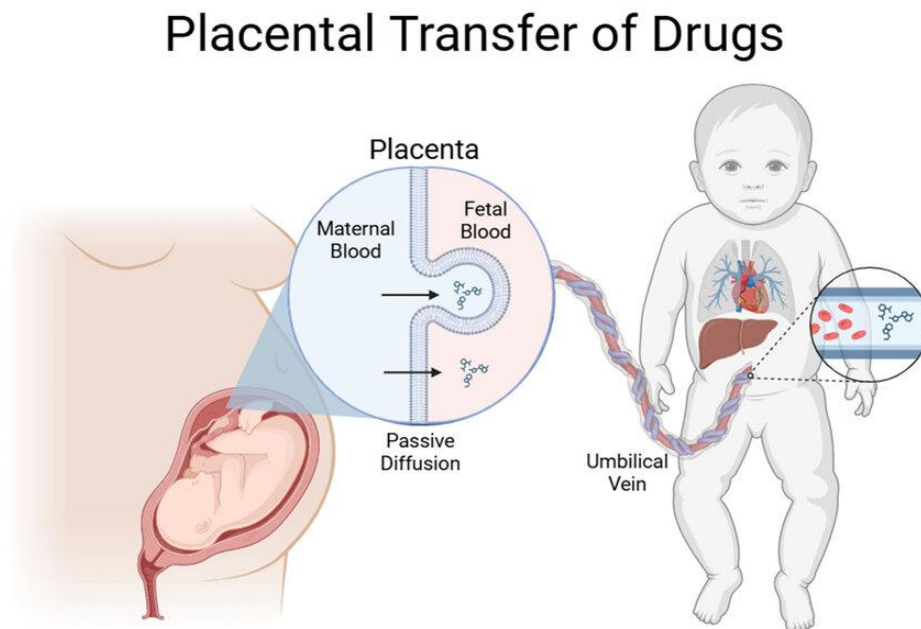
B. Farmakovigilans Obat dan Suplemen pada Ibu Hamil

1. Perubahan fisiologis selama kehamilan yang mempengaruhi disposisi obat

Kehamilan adalah proses kompleks di mana tubuh wanita mengalami perubahan mendalam untuk mendukung perkembangan janin. Selama kehamilan, tubuh seorang wanita mengalami perubahan signifikan, yaitu perubahan anatomi dan fisiologis, yang berdampak besar pada farmakokinetik (PK) obat-obatan. Sejumlah besar literatur penelitian menunjukkan bahwa perubahan fisiologis yang disebabkan oleh kehamilan dapat memengaruhi proses farmakokinetik (PK) penyerapan, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat (ADME). Misalnya, pengosongan lambung yang tertunda dan penurunan motilitas gastrointestinal yang terjadi selama kehamilan menyebabkan penyerapan obat yang tertunda. Peningkatan berat badan ibu dan volume ekstraseluler serta penurunan konsentrasi albumin plasma yang terjadi selama kehamilan dapat mengubah volume distribusi obat (Burnham, & Darsey, 2022). Peningkatan aliran darah ginjal dan laju filtrasi glomerulus yang terjadi selama kehamilan menyebabkan peningkatan klirens ginjal, yang dapat secara substansial meningkatkan laju eliminasi obat yang dibersihkan ginjal, sehingga menyebabkan waktu paruh yang lebih pendek. Perubahan disposisi obat dimulai pada trimester pertama, berlanjut sepanjang kehamilan dan hingga periode pasca persalinan, bervariasi dengan usia kehamilan, dan dapat menyebabkan potensi kekurangan dosis atau kelebihan dosis obat ketika menggunakan dosis dewasa standar selama kehamilan. Perubahan fisiologis yang disebabkan kehamilan mungkin memerlukan penyesuaian dosis obat untuk meminimalkan efek samping dan memaksimalkan efek terapeutik yang diinginkan (Ren *et al.*, 2021).

Meskipun ada banyak perubahan umum yang terjadi selama kehamilan yang diperkirakan akan memengaruhi farmakokinetik banyak obat (misalnya, peningkatan klirens ginjal, peningkatan volume distribusi, dll.), ada banyak faktor

yang dapat memengaruhi respons individu terhadap obat. Misalnya, variasi aktivitas



Gambar 3.1 Proses transporter obat melalui plasenta
(Sumber: Fernandez *et. al.*, 2025)

transporter obat spesifik dan enzim metabolisme selama kehamilan dapat memengaruhi metabolisme, transportasi, dan ekskresi obat. Selain itu, variasi individu pada pasien dengan proses penyakit yang mendasarinya dapat mengubah respons terhadap pengobatan obat. Memahami sifat farmakokinetik dan farmakodinamik spesifik obat serta variasi spesifik usia kehamilan juga penting untuk meningkatkan efektivitas pengobatan dan mengurangi dampak buruk pada ibu dan janin (Ren *et al.*, 2021).

2. Pengaruh paparan obat-obatan selama kehamilan

Sebagian besar ibu hamil menggunakan obat dan suplemen pada periode organogenesis sedang berlangsung sehingga risiko terjadi cacat janin lebih besar. Mengingat beberapa jenis obat dapat melintasi plasenta, maka penggunaan obat pada wanita hamil perlu hati-hati. Selama trimester pertama, obat dapat menyebabkan cacat lahir (teratogenesis), dan risiko terbesar adalah kehamilan 3-8 minggu (Shafi *et al.*, 2024). Trimester pertama kehamilan adalah periode yang paling berbahaya untuk paparan teratogenik karena pada saat

itulah organogenesis terjadi, meskipun beberapa teratogen mungkin memiliki efek pada tahap kehamilan selanjutnya dan bahkan dapat menyebabkan keguguran (Mosha *et al.*, 2014). Selama trimester kedua dan ketiga, obat dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan secara fungsional pada janin atau dapat meracuni plasenta. Obat-obatan bebas dan resep sering digunakan selama kehamilan. Akibat kurangnya informasi klinis, keamanan, atau dosis, penyedia layanan kesehatan terpaksa menggunakan obat-obatan di luar label pada wanita hamil. Oleh karena itu, wanita hamil dan janin berisiko mengalami penurunan keamanan dan efektivitas obat (Shafi *et al.*, 2024).

Telah terjadi peningkatan prevalensi kondisi yang sudah ada sebelumnya dan kronis (misalnya, asma, diabetes, hipertensi, penyakit jantung, dan gangguan penggunaan zat) di kalangan wanita usia subur dalam beberapa tahun terakhir yang mengharuskan mereka untuk terus mengonsumsi obat-obatan selama kehamilan, periode pascapersalinan, dan menyusui (Ren *et al.*, 2021). Obat-obatan umum seperti tetrasiklin, metronidazol, albendazol, mebendazol, efavirenz (EFV), sulfadoksin-pirimetamin (SP), dan terapi kombinasi berbasis artemisinin (ACT) adalah beberapa obat terapeutik yang tidak dianjurkan selama trimester pertama karena kekhawatiran akan toksisitas embrio. Semua obat teratogenik yang dilaporkan ini dan banyak obat lain yang diketahui atau belum dikonfirmasi memiliki efek berbahaya pada janin masih digunakan oleh wanita usia subur dan wanita hamil untuk mengobati berbagai penyakit. Dengan demikian, studi keamanan pada kehamilan masih kurang pada sebagian besar obat yang digunakan untuk pengobatan penyakit tropis (Mosha *et al.*, 2014).

Praktisi kesehatan sering meresepkan obat-obatan lama kepada pasien yang sedang hamil karena pengalaman sebelumnya dalam meresepkan obat tersebut kepada pasien mereka, atau karena informasi tentang keamanan dan efek samping yang diketahui tersedia. Meresepkan obat selama kehamilan merupakan tantangan besar bagi dokter, yang harus menyeimbangkan potensi manfaat bagi ibu dengan potensi bahaya bagi janin. Dilema ini semakin besar karena, untuk banyak obat, tidak ada data yang relevan dan benar-benar pasti tentang kemungkinan efek berbahaya selama kehamilan. Penelitian yang tersedia menunjukkan bahwa sebagian besar wanita mengonsumsi obat selama kehamilan; 60% mengonsumsi obat resep, 90% mengonsumsi obat bebas, dan 45% wanita hamil mengonsumsi berbagai ramuan herbal (Erdeljić Turk dan Vitezić, 2017 dalam Al Khalaf *et al.*, 2019). Telah diamati juga bahwa persepsi risiko mengonsumsi obat selama kehamilan tinggi di kalangan profesional kesehatan dan wanita hamil, bahkan untuk obat-obatan yang efek sampingnya belum terbukti (Pole *et al.*, 2000; Briggs *et al.*, 2015 ; *Food and Drug Administration*, 2019

; *European Medicines Agency Guideline on Good Pharmacovigilance Practices*, 2024) dalam Sastranegara *et al.*, 2025).

Sebagian besar wanita dengan epilepsi harus melanjutkan penggunaan AED (*Antiepileptic Drugs*) mereka sebelum, selama, dan setelah kehamilan. Metabolisme AED dapat berubah secara drastis selama kehamilan. Perubahan ini harus ditangani oleh dokter. Kadar obat harus dipantau secara konsisten selama kehamilan. Risiko terhadap janin harus dijelaskan dalam hal efek samping dari obat-obatan tertentu serta risiko dari gangguan kejang itu sendiri. Banyak AED memiliki efek teratogenik yang sudah dikenal, dan ini harus dijelaskan kepada ibu. Terdapat risiko (teoretis dan berdasarkan bukti) untuk komplikasi obstetri, hasil neonatal yang buruk, malformasi kongenital dan bahkan efek kognitif pada anak di kemudian hari. Rekomendasi tidak terbatas pada konseling pra-konsepsi, mengonsumsi folat sebelum dan sesudah konsepsi, meresepkan AED yang paling efektif sambil meminimalkan risiko, dan menghindari politerapi dan valproat jika memungkinkan (Gedzelman and Meador, 2012). Gašparović *et al.*, (2020) daam Fernández *et al.*, (2025) menemukan bahwa paparan AED dalam kandungan dikaitkan dengan peningkatan risiko malformasi kongenital janin mayor meskipun suplementasi asam folat dengan dosis 5 mg diresepkan untuk semua pasien. Kecemasan dan stres ibu, fluktuasi kadar hormon, perubahan farmakokinetik AED yang rumit selama kehamilan, dan kepatuhan yang buruk dapat menyebabkan kontrol epilepsi yang buruk. Kejang yang tidak terkontrol dengan baik dapat menyebabkan hasil kehamilan yang merugikan yang memicu cedera ibu dan hipoksia intrauterin.

Ibu hamil pada umumnya mengalami perubahan fisiologis dan anatomi yang signifikan. Perubahan ini biasanya dikaitkan dengan masalah kesehatan ringan dan komplikasi. Wanita hamil lebih cenderung menggunakan obat herbal karena sebagian besar masalah kesehatan ringan selama kehamilan tidak memerlukan pengobatan farmasi. Selain itu, berbagai komunitas memiliki praktik kesehatan, pengetahuan, dan kepercayaan yang berbeda tentang obat-obatan untuk melindungi kehamilan dan meningkatkan kesehatan ibu dan janin. Menurut penelitian, penggunaan obat herbal selama kehamilan dapat memiliki konsekuensi serius bagi janin dan ibu karena profil keamanan dan dosis yang tepat dari sebagian besar obat herbal belum ditetapkan dengan baik. Obat herbal, di sisi lain, telah dikaitkan dengan peredaan gejala terkait kehamilan yang efektif, risiko lebih rendah dari persalinan prematur spontan dan penurunan tekanan darah yang signifikan pada pasien hipertensi (Ren *et al.*, 2021).

3. Ruang Lingkup Farmakovigilans pada ibu hamil

a. Kategori tingkat keamanan penggunaan obat pada ibu hamil dan menyusun dari FDA (*Food Drug Administration*) Brown & Wright (2020)):

1) Kategori A

Aman untuk janin seperti vitamin C asam folat, vit B6, parasetamol, zinc, dan sebagainya.

2) Kategori B

Cukup aman untuk janin seperti amoksisilin, ampisilin, azitromisin, bisakodil, cefadroksil, cefepim, cefixim, cefotaxim, ceftriaxon, cetirizin, klopidogetrel, eritromisin, ibuprofen, insulin lansoprazol, loratadin, mepenem, metformin, metildopa, metronidazol, dan sebagainya.

3) Kategori C

Dapat beresiko, digunakan jika perlu. Obat dianjurkan hanya jika manfaat yang diperoleh oleh ibu atau janin melebihi resiko yang mungkin timbul pada janin. Contohnya albendazol, allopurinol, aspirin, amitriptilin, kalsitriol, kalsium laktat, kloramfenikol, ciprofloksasin, klonidin, kotrimoksazol, kodein + parasetamol dekstrometorfan, digoksin, enalapril, efedrin, flukonazol dan sebagainya.

4) Kategori D

Ada bukti positif dari resiko, digunakan jika darurat. Penggunaan obat diperlukan untuk mengatasi situasi yang mengancam jiwa atau penyakit serius dimana obat yang lebih aman tidak efektif atau tidak dapat diberikan. Contohnya alprazolam, amikasin, amiodaron, carbamazepin, klordiazepoksid, diazepam, kanamisin, fenitoin, asam valproat, dan sebagainya.

5) Kategori X

Kontraindikasi dan sangat berbahaya bagi janin, contohnya (amlodipin atorvastatin), atorvastatin, (kafein dan ergotamin), (desogestrel dan etinil estradiol), ergometrin, estradol, misoprostol, oksitosin, simvastatin, warfarin.

b. Suplemen yang relatif aman dan yang perlu dihindari

Status nutrisi janin sebagian besar bergantung pada asupan ibu, dan telah diketahui selama bertahun-tahun bahwa kekurangan nutrisi penting dapat menyebabkan malformasi dan hasil kesehatan yang buruk bagi ibu dan keturunan. Karena alasan inilah, seringkali kehamilan menjadi waktu di mana calon ibu akan fokus pada kesehatan dan asupan nutrisi mereka. Penggunaan suplemen sangat umum selama kehamilan. Brown dan Wright (2020) menyampaikan hasil dari beberapa peneliti menunjukkan bahwa penggunaan multivitamin pada ibu hamil (tidak termasuk asam folat saja) berkisar antara 78% hingga 98% di berbagai kelompok di Amerika Serikat, Kanada, dan

Australia. Namun, pengetahuan tentang keamanan atau efektivitas suplemen tidak tersebar luas. Banyak produsen suplemen lebih memilih berhati-hati dan menggunakan label peringatan untuk menghindari penggunaan selama kehamilan. Mengingat insiden kekurangan nutrisi yang relatif tinggi, kepadatan nutrisi makanan yang rendah, dan asupan makanan olahan yang kurang bergizi, penggunaan suplemen selama kehamilan mungkin bermanfaat dalam beberapa kasus dan mengurangi risiko hasil negatif (Ren *et al.*, 2021). Penggunaan suplemen selama kehamilan adalah hal yang umum, terutama untuk mencegah kekurangan nutrisi yang dapat menyebabkan dampak buruk seperti preeklampsia, diabetes gestasional, atau keterlambatan pertumbuhan intrauterin (Brown & Wright, 2020). Namun, tidak semua suplemen aman. Vitamin A, misalnya, masih kontroversial karena potensi teratogeniknya jika dikonsumsi berlebihan selama organogenesis awal (Zhang *et al.*, 2019; Bastos Maia *et al.*, 2019). Meskipun vitamin A penting untuk perkembangan janin dan fungsi kekebalan tubuh, konsumsi berlebihan selama 60 hari pertama kehamilan dapat meningkatkan risiko cacat lahir. Oleh karena itu, beberapa negara merekomendasikan untuk menghindari suplementasi vitamin A secara rutin selama kehamilan, dan menyarankan agar kebutuhan tersebut dipenuhi melalui sumber makanan (Maia *et al.*, 2019 dalam Burnham & Darsey *et al.*, 2022). Ibu hamil harus diberi konseling untuk fokus pada diet seimbang dan sumber penting nutrisi tertentu. Suplementasi dapat bermanfaat bagi individu tertentu yang menghindari kelompok makanan tertentu seperti daging atau produk hewani, atau yang berisiko lebih tinggi mengalami kekurangan nutrisi. Selain itu, kejadian hasil negatif pada ibu dan janin dapat dikurangi pada kehamilan berisiko tinggi. Mengingat tingginya beban komplikasi kehamilan, suplementasi nutrisi adalah cara yang aman dan hemat biaya untuk mengurangi risiko hasil seperti preeklampsia, GDM, dan SGA, di antara lainnya (Brown & Wright, 2020).

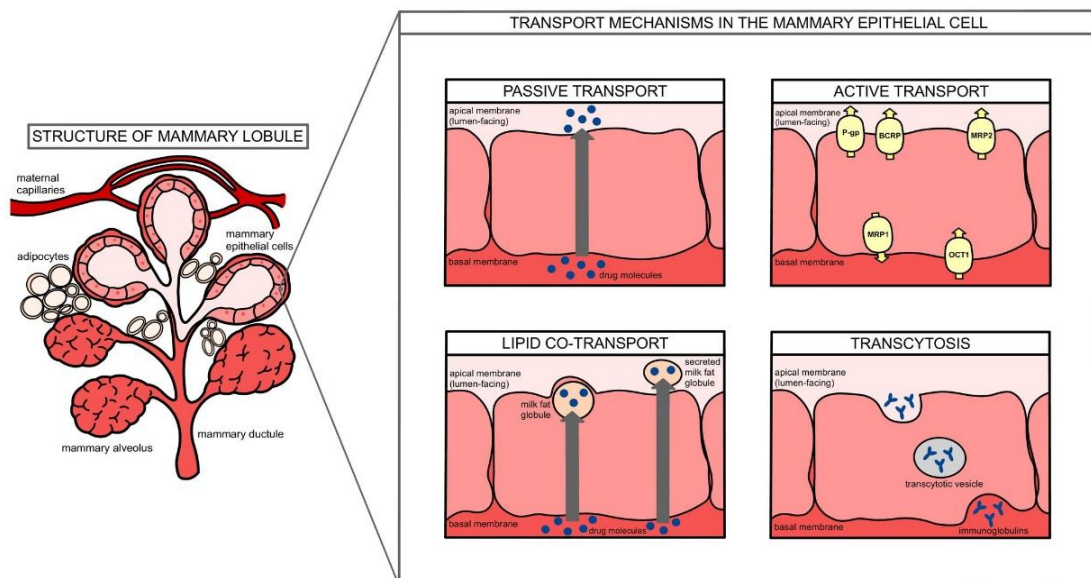
C. Farmakovigilans Obat dan Suplemen pada Ibu Menyusui

1. Mekanisme ekskresi obat ke dalam ASI (Air Susu Ibu)

Meskipun ASI memiliki banyak manfaat, ibu menyusui yang mengonsumsi obat resep mungkin menghentikan pemberian ASI karena kekhawatiran terkait paparan obat pada bayi melalui ASI. Mengkonsolidasikan pengetahuan terkini tentang transportasi obat ke ASI dapat memberikan pemahaman tentang keamanan penggunaan obat selama menyusui. Sebagian besar zat yang dikonsumsi oleh ibu yang sedang menyusui akan masuk ke dalam ASI dengan berbagai tingkat dan jumlah transfer serta potensi efek samping pada bayi

bergantung pada kombinasi karakteristik orang tua, bayi, dan obat. Penting untuk diketahui bahwa mekanisme transfer obat ke dalam ASI sangat berbeda dari jalur transplasenta selama masa kehamilan dan tahap janin serta neonatal (umumnya jauh lebih tinggi dengan jalur transplasenta) dicapai dengan agen yang sama melalui kedua jalur ini (Berwick *et al.*, 2025). Obat dan senyawa lain diserap, dimetabolisme, didistribusikan ke berbagai kompartemen (plasma, intraseluler, ekstraseluler, cairan transeluler, dan cairan interstisial) pada individu yang menyusui, dan dieliminasi. Jalur masuk obat ke dalam ASI yang paling penting saat ini dianggap sebagai difusi pasif, meskipun mekanisme aktif, yang dimediasi oleh pembawa, dan ko-transport juga telah dijelaskan tetapi jarang terjadi (Berwick *et al.*, 2025).

Payudara manusia terdiri dari unit penghasil susu yang disebut alveoli payudara, yang membentuk gugusan seperti anggur yang terhubung ke puting melalui duktus payudara (Gambar 2). Sel epitel payudara penghasil susu melapisi alveoli dan membentuk lapisan semipermeabel untuk memisahkan plasma ibu dari ASI. Molekul harus melewati beberapa penghalang untuk masuk ke dalam ASI dari plasma ibu, meliputi membran vaskular kapiler sistemik, membran basal yang memisahkan pembuluh darah dari epitel payudara, membran basal sel epitel payudara yang menghadap plasma, dan membran apikal sel epitel payudara yang menghadap lumen (Berwick *et al.*, 2025).



Gambar 3.2 Struktur lobulus payudara dan empat mekanisme transportasi obat yang terjadi di sel epitel payudara (sumber: Gong et al., 2024)

Zat endogen dan eksogen dipindahkan dari plasma ibu ke ASI melalui lima mekanisme umum: eksositosis, sekresi lipid apokrin, transportasi yang dimediasi pembawa, transitis, dan transportasi paraseluler (Nakijoba *et al.*, 2025). Zat terlarut, protein, dan Lipid yang disintesis secara endogen oleh sel epitel payudara masuk ke dalam ASI melalui eksositosis atau sekresi lipid apokrin dari sel payudara. Transporter obat, yang merupakan protein membran yang memfasilitasi masuk atau keluar molekul dari sel, berpartisipasi dalam transpor transeluler yang dimediasi oleh pembawa untuk mensekresikan dan mencegah masuknya substrat obat ke dalam ASI. Molekul besar, seperti imunoglobulin, diangkut melalui transitis dari plasma ibu, melintasi sel epitel payudara, dan ke dalam ASI. Terakhir, transpor paraseluler adalah pergerakan zat ekstraseluler melalui ruang di antara sel-sel epitel payudara. Transport paraseluler merupakan mekanisme transport yang umum terjadi selama beberapa hari pertama laktasi, yaitu fase kolostrum, ketika ruang di antara sel-sel epitel masih terbuka. Namun, transport transeluler menjadi lebih dominan mulai sekitar 7 hari pasca persalinan, ketika sambungan ketat terbentuk di antara sel-sel epitel dan tidak lagi memungkinkan transport paraseluler yang efisien dari plasma ibu ke ASI. Secara keseluruhan, transport zat ke dalam dan keluar dari sel-sel epitel payudara berkontribusi pada kualitas ASI, yang dapat berdampak pada bayi saat menyusui (Berwick *et al.*, 2025).

2. Pengaruh paparan obat-obatan dan herbal selama menyusui

Menyusui adalah salah satu praktik paling efektif untuk meningkatkan kesehatan dan kelangsungan hidup anak. *World Health Organization* (WHO, 2017) dan *United Nations Children's Fund* (UNICEF, 2017) menyarankan untuk memulai menyusui dalam satu jam pertama setelah kelahiran, diikuti dengan menyusui eksklusif selama enam bulan pertama sementara menyusui berkelanjutan dengan makanan pendamping direkomendasikan hingga dua tahun dan seterusnya (Nakijoba *et al.*, 2025). Namun, karena ibu menyusui sering mengalami masalah kesehatan yang mungkin memerlukan pengobatan, seperti nyeri pascapersalinan, infeksi, dan kondisi kronis, mereka harus membuat keputusan yang tepat tentang penggunaan obat yang aman untuk menghindari potensi efek samping pada bayi mereka. Berbagai faktor, termasuk akses perawatan kesehatan, pendidikan, kepercayaan budaya, dan status kesehatan individu, dapat memengaruhi pilihan pengobatan ibu.

Penggunaan obat dapat secara substansial memengaruhi pola dan durasi menyusui, karena obat-obatan tertentu dapat mengganggu produksi, komposisi, atau aliran ASI. Secara khusus, obat-obatan seperti difenhidramin, pseudoefedrin, haloperidol, dan furosemid telah terbukti memengaruhi sintesis dan sekresi ASI,

yang berpotensi menyebabkan penurunan efektivitas menyusui atau, dalam beberapa kasus, penghentian menyusui. Selain itu, terdapat kesenjangan yang substansial dalam literatur mengenai keamanan obat-obatan yang digunakan selama menyusui. Meskipun beberapa obat dianggap kompatibel dengan menyusui, bukti yang tersedia terbatas untuk menilai risiko yang terkait dengan banyak obat yang umum digunakan (Nakijoba *et al.*, 2025). Lebih dari separuh wanita mengonsumsi obat-obatan selama menyusui, sehingga membuat bayi mereka rentan terhadap paparan obat melalui ASI. Akibatnya, reaksi obat yang merugikan dapat muncul pada bayi, meskipun jarang dilaporkan.

Meskipun penggunaan produk herbal lazim di kalangan wanita menyusui, penelitian Amer *et al.*, (2015) menemukan bukti keamanan yang tidak meyakinkan pada populasi ini karena ibu menyusui mungkin beralih ke suplemen tanpa mengetahui bahwa produk-produk tersebut dapat menimbulkan ancaman bagi diri mereka sendiri dan bayi mereka. Sepanjang sejarah, wanita telah menggunakan ramuan atau makanan tertentu untuk meningkatkan produksi ASI mereka. Sebagian besar zat ini belum dievaluasi secara ilmiah, tetapi penggunaan tradisional menunjukkan keamanan dan beberapa khasiat. Alasan penggunaan di kalangan wanita menyusui termasuk peningkatan produksi ASI, pembengkakan payudara, mastitis, dan indikasi yang tidak terkait dengan laktasi (misalnya, sembelit, pilek, depresi). Meskipun herbal sering dipromosikan sebagai produk alami dan karenanya tidak berbahaya, herbal tidak bebas dari efek samping. Tidak ada pedoman peraturan yang menetapkan penilaian risiko standar untuk menentukan keamanan dan khasiat produk ini pada wanita menyusui.

3. Suplemen yang relatif aman dan perlu dikonsumsi

Menyusui penting untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi baru lahir yang sehat, dan komposisi nutrisi ASI dapat dipengaruhi oleh nutrisi dan suplementasi ibu (Al Essa, 2019). Suplementasi yodium direkomendasikan oleh negara Jerman untuk semua ibu menyusui, dan suplementasi asam dokosaheksaenoat (DHA) direkomendasikan untuk ibu dengan asupan ikan yang tidak memadai atau tidak ada sama sekali. Suplementasi vitamin B12 diperlukan untuk vegan ketat selama menyusui, dan suplementasi nutrisi lainnya mungkin diperlukan tergantung pada status nutrisi individu (Delgas, 2024). Konsekuensi dari kekurangan vitamin B12 selama menyusui, terutama bagi bayi, telah dibuktikan oleh beberapa studi kasus, di mana gejala neurologis yang serius terjadi. Gejala kekurangan biasanya muncul antara usia 4–6 bulan, meskipun kerusakan permanen seringkali dapat dihindari dengan diagnosis dini dan pengobatan segera dengan suplemen vitamin]. Terdapat juga risiko bagi ibu, termasuk efek hematologis dan neurologis, mulai dari kelelahan dan neuropati

perifer hingga konsekuensi serius seperti degenerasi sumsum tulang belakang. Untuk memastikan kesejahteraan ibu dan bayi, ibu menyusui yang sepenuhnya vegan harus mengonsumsi suplemen vitamin B12 (Amer, 2015).

Data terbaru juga menunjukkan bahwa ibu yang menjalani diet vegetarian mungkin menghadapi peningkatan risiko kekurangan B12 tanpa suplemen [38]. Selain B12, nutrisi penting lainnya pada ibu menyusui yang mengikuti diet vegetarian atau vegan ketat mungkin adalah protein, riboflavin, vitamin D, kalsium, zat besi, seng, selenium, DHA/EPA dan yodium. Suplementasi untuk ibu menyusui di Norwegia merekomendasikan vitamin D atau minyak hati ikan kod (Direktorat Kesehatan Norwegia, 2019a), sedangkan di Swedia, ibu menyusui disarankan untuk memilih makanan yang kaya vitamin D, lemak omega-3, dan asam folat (Badan Pangan Swedia, 2019).

D. Farmakovigilans Obat pada Anak

1. Perbedaan reaksi obat yang merugikan antara anak-anak dan orang dewasa

Tujuan farmakovigilans obat pada anak adalah untuk mengurangi bahaya, mengoptimalkan farmakoterapi pada anak, dan memberikan deskripsi yang akurat kepada orang tua dan dokter tentang keseimbangan manfaat-risiko dari pilihan pengobatan yang tersedia, termasuk potensi efek jangka panjang (Aurich *et al.*, 2022). Anak-anak seringkali merespons terapi secara berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Terdapat perbedaan farmakokinetik dan farmakodinamik antara kelompok usia anak, baik dalam efikasi maupun keamanan. Farmakovigilans anak membutuhkan pemahaman tentang aspek unik anak-anak terkait, misalnya, respons obat, pertumbuhan dan perkembangan, presentasi klinis reaksi obat yang merugikan (ADR= *adverse drug reactions*), bagaimana reaksi tersebut dapat dideteksi, dan faktor spesifik populasi (misalnya, penggunaan obat offlabel/tidak berlisensi yang lebih sering) (Toni *et al.*, (2024).

Farmakovigilans pada anak merupakan proses berkelanjutan yang dimulai ketika suatu obat diberikan kepada anak pertama untuk pertama kalinya. Hal ini dapat terjadi dalam konteks uji klinis atau dalam praktik klinis dan mencakup penggunaan di luar label dan penggunaan tanpa izin. Farmakovigilans ini membandingkan pemahaman terkini tentang risiko terkait pengobatan pada anak-anak (yaitu, spesifikasi keamanan pediatrik terkini) dengan informasi baru dari uji klinis, laporan spontan, studi keamanan non-klinis, dan studi observasional Toni *et al.*, (2024). Selain itu, spesifikasi ini mengevaluasi potensi risiko dan mengisi kesenjangan pengetahuan untuk informasi keselamatan yang hilang (misalnya, faktor risiko atau hasil). Hal ini dilengkapi dengan topik farmakovigilans pediatrik rutin seperti efek jangka panjang, kesalahan

pengobatan, kurangnya kepatuhan karena formulasi yang tidak sesuai usia, kurangnya kemanjuran karena dosis yang kurang, efek samping dari eksipien, interaksi (obat-obat, obat-makanan, dan interaksi antara eksipien yang berbeda dari pengobatan bersama) dan, jika berlaku, masalah dengan alat medis yang tidak cukup disesuaikan untuk anak-anak. Selain itu, topik farmakovigilans standar seperti kejadian medis yang ditentukan, farmakogenetika, dan, jika sesuai, populasi khusus (misalnya, gangguan ginjal atau hati) disertakan (Aurich *et al.*, 2022).

Respons anak terhadap pengobatan berbeda tidak hanya dibandingkan dengan orang dewasa, tetapi juga antara kelompok usia anak yang berbeda (misalnya, neonatus dan remaja). Misalnya, neonatus prematur tidak mampu memetabolisme dan mengeluarkan kloramfenikol secara efektif, yang menyebabkan kadar plasma toksik dan gambaran klinis yang digambarkan sebagai "*grey-baby syndrome*" (Aurich *et al.*, 2020). Faktor spesifik anak, termasuk seringnya penggunaan obat bersamaan di luar label/tanpa izin, data farmakokinetik (PK) dan/atau farmakodinamik (PD) yang terbatas, perbedaan perkembangan dalam PK dan PD, variasi yang cukup besar dalam dosis dan frekuensi pemberian karena kurangnya data PK pediatrik dan peningkatan risiko kesalahan pengobatan, dapat memodifikasi risiko efek samping obat (ADR). Pemodelan dan simulasi dapat digunakan untuk mendukung pemilihan dosis untuk studi pediatrik dan menyertakan data keamanan yang ada. Kesalahan pengobatan pada anak dapat atau tidak dapat menyebabkan reaksi obat yang merugikan, tergantung pada jenis kesalahannya (Fernández *et al.*, 2025). Alasan-alasan untuk hal ini seringkali bersifat multifaktorial, termasuk kurangnya formulasi yang ramah anak dan pelatihan yang tidak memadai bagi para profesional perawatan kesehatan. Selain itu, respons anak terhadap eksipien mungkin berbeda dari orang dewasa dan bervariasi tergantung pada kelompok usia anak (misalnya, alkohol harus dihindari dalam formulasi obat neonatal).

Faktor risiko farmakogenetik dapat muncul pada waktu yang berbeda sepanjang masa kanak-kanak dan perubahan perkembangan yang tumpang tindih dapat menyebabkan gambaran klinis yang serupa pada anak-anak dengan genotipe yang berbeda. Infeksi virus lebih umum terjadi pada anak-anak (misalnya, saluran pernapasan atas). Virus dapat mengganggu metabolisme obat atau memodifikasi respons sistem kekebalan tubuh terhadap obat-obatan tertentu dan dengan demikian menyebabkan efek samping obat (ADR). Etiologi dan pengobatan penyakit anak berbeda dibandingkan dengan orang dewasa dan dapat bervariasi antar kelompok usia anak (misalnya, hipertensi, epilepsi) dan

beberapa penyakit hanya menyerang anak-anak (misalnya, retinopati prematuritas, displasia bronkopulmoner) (Aurich *et al.*, 2020).

Perbedaan ini memengaruhi faktor risiko dan faktor pengganggu untuk ADR pada anak. Pada neonatus dan bayi, PK dan/atau PD dapat berubah dengan cepat selama beberapa bulan pertama kehidupan karena pematangan organ dan perubahan disposisi lemak serta aktivitas enzim yang terlibat dalam metabolisme obat. Misalnya, bayi dan anak kecil mungkin memiliki risiko lebih tinggi terkena hepatotoksitas yang diinduksi valproat. Selama pubertas, perubahan hormonal dapat mengubah metabolisme dan respons obat. Kepatuhan yang buruk dan penggunaan obat-obatan rekreasional secara bersamaan dapat menjadi faktor risiko efek samping obat pada remaja. Risiko yang terkait dengan interaksi dengan obat-obatan lain mungkin berbeda karena anak-anak mungkin diobati dengan berbagai jenis obat-obatan lain. Efek jangka panjang, misalnya pada prestasi akademik, kesuburan, dan pertumbuhan, merupakan perhatian khusus pada anak-anak. Sulit untuk membedakan efek yang terkait dengan obat dari efek yang disebabkan oleh penyakit yang mendasarinya (misalnya, epilepsi). Terakhir, risiko yang berkaitan dengan kehamilan (penyakit ibu dan paparan obat dalam kandungan) dan efek antar generasi perlu dipertimbangkan, khususnya pada periode neonatal awal dan masa bayi (Herzig *et al.*, 2022).

Identifikasi ADR pediatrik memerlukan kesadaran dari para profesional perawatan kesehatan, orang tua, dan ahli farmakovigilans. Tantangan dalam deteksi ADR pediatrik meliputi kebutuhan untuk mengelompokkan data berdasarkan kelompok usia yang menyebabkan jumlah yang kecil dalam subkelompok. Kurangnya nilai referensi biokimia dan hematologi yang terharmonisasi serta perbedaan kriteria diagnostik dan protokol pengobatan antara profesional perawatan kesehatan, rumah sakit, dan negara yang berbeda membuat analisis data keamanan pediatrik multi-pusat dan/atau multinasional menjadi sulit. Selain itu, pemeriksaan fisik dan pengujian tidak dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti pada orang dewasa (Aurich *et al.*, 2020).

2. Penggunaan obat dan suplemen pada bayi, anak-anak, dan remaja

Anak-anak dan remaja terpapar obat-obatan dan suplemen, tetapi hanya sedikit penelitian yang mengevaluasi asupan aktual dalam perawatan rutin. Penggunaan obat pada anak selalu menjadi isu kontroversial karena berbagai alasan, seperti fisiologi mereka yang rapuh dan sedang tumbuh, serta perbedaan penyerapan, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat dibandingkan dengan orang dewasa Toni *et al.*, (2024). Memang, sebagai kelompok yang rentan, anak-anak memiliki risiko lebih tinggi terhadap efek samping terkait obat, dan dosis serta formulasi obat harus dipertimbangkan pada saat pemberian. Sebagai

populasi yang rentan, anak-anak mengalami dampak negatif dari pengobatan. Dampak ini biasanya meliputi reaksi obat yang merugikan (ADR), kejadian yang merugikan dan efek samping. ADR meliputi reaksi yang tidak diinginkan dan merugikan terhadap obat ketika diberikan pada dosis standar untuk tujuan profilaksis, diagnostik, atau terapeutik (Aurich *et al.*, 2020).

ADR mencakup reaksi yang tidak diinginkan dan merugikan terhadap obat ketika diberikan pada dosis standar untuk tujuan pencegahan, diagnostik, atau terapeutik. Reaksi-reaksi ini mencakup spektrum dari ringan hingga berat, termasuk hasil yang fatal. Istilah yang lebih luas, mencakup konsekuensi yang tidak disengaja yang terkait dengan intervensi medis, kesalahan pengobatan, malfungsi perangkat, dan infeksi yang didapat di rumah sakit (Aurich *et al.*, 2020).. Sebaliknya, efek samping mewakili hasil yang tidak disengaja namun umumnya dapat diprediksi dari penggunaan obat. Biasanya, efek samping terkait obat mengacu pada hasil yang tidak diinginkan dari penggunaan terapeutik yang biasanya tidak mengharuskan penghentian pengobatan, sedangkan efek toksik mencakup ADR. Yang terakhir terjadi karena peningkatan konsentrasi obat, baik disengaja maupun tidak disengaja (Herzig *et al.*, 2022).

Toni *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa faktor risiko demografis (usia muda dan jenis kelamin laki-laki), faktor risiko terkait kesehatan (BMI rendah, komorbiditas kronis, polifarmasi), faktor risiko terkait rumah sakit (lama rawat inap), dan faktor risiko terkait obat (jenis obat, dosis, riwayat efek samping obat) adalah faktor risiko paling umum yang terkait dengan efek samping obat pada anak-anak. Memang, usia anak yang lebih muda di unit rawat inap dan rawat jalan dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya efek samping obat. Sementara Kunac *et al.*, dalam Toni *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa usia anak yang lebih tua yang dirawat di rumah sakit mendukung terjadinya efek samping obat, Silva *et al.*, dalam Toni *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa anak-anak berusia <48 bulan dan dirawat di ICU memiliki risiko efek samping obat yang lebih tinggi. Secara umum, beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak-anak memiliki risiko efek samping terkait obat yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dewasa dan lansia. Jenis kelamin merupakan faktor potensial lain yang memengaruhi terjadinya efek samping terkait obat. Jung-Poppe *et al.*, dalam Aurich *et al.*, (2020) menemukan bahwa perempuan lebih mungkin berisiko mengalami efek samping terkait obat pada ditemukan bahwa perempuan lebih mungkin berisiko mengalami efek samping terkait obat di unit rawat inap, rawat jalan, dan unit gawat darurat. faktor-faktor yang berkaitan dengan status kesehatan anak, seperti penggunaan berbagai obat untuk mengobati penyakit dapat secara signifikan meningkatkan kemungkinan efek samping terkait obat. Hasil penelitian

lain juga menunjukkan bahwa komorbiditas dapat meningkatkan frekuensi efek samping terkait obat pada orang dewasa. Penyakit neurologis dan kesehatan mental, penyakit kardiovaskular, dan diabetes tipe 2 dilaporkan lebih rentan terhadap efek samping terkait obat, tetapi hasil penelitian saat ini menunjukkan bahwa anak-anak dengan kanker lebih terpengaruh oleh efek samping terkait obat. Sebagian besar faktor risiko yang terkait dengan efek samping obat mungkin sama pada orang dewasa dan anak-anak namun, dampaknya mungkin berbeda pada kedua kelompok ini. Secara keseluruhan, penelitian tentang dampak faktor-faktor ini, khususnya pada anak-anak, dapat mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang keselamatan pasien Herzig *et al.*, (2022).

E. Simpulan

Farmakovigilans merupakan komponen penting dalam sistem kesehatan untuk menjamin keamanan penggunaan obat sepanjang siklus hidup produk—mulai dari pemberian pertama pada manusia hingga obat tidak lagi dipasarkan. Farmakovigilans tidak hanya berfokus pada reaksi obat merugikan (ADR), tetapi juga mencakup berbagai masalah terkait obat seperti interaksi, kesalahan pengobatan, kurangnya kemanjuran, reaksi terhadap eksipien, ketidakpatuhan, hingga isu perangkat medis bila relevan. Pembentukan program pemantauan obat global WHO pasca tragedi thalidomide menegaskan bahwa pemantauan keamanan obat harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, menggunakan data dari berbagai sumber (uji klinis, laporan spontan, serta data populasi) untuk menilai keseimbangan manfaat–risiko secara objektif dan melindungi kesehatan masyarakat.

Pada ibu hamil, farmakovigilans menjadi sangat krusial karena perubahan fisiologis kehamilan memengaruhi farmakokinetik obat (ADME), sehingga dosis standar dewasa dapat menyebabkan underdosing atau overdosing. Selain itu, paparan obat pada trimester pertama terutama masa organogenesis—memiliki risiko teratogenesis paling tinggi, sementara paparan pada trimester berikutnya dapat memengaruhi pertumbuhan dan fungsi janin atau toksisitas plasenta. Keterbatasan data keamanan, tingginya penggunaan obat bebas, resep, maupun herbal, serta praktik off-label pada kehamilan memperbesar urgensi pemantauan keamanan. Pengelolaan kondisi kronis seperti epilepsi memperlihatkan dilema klinis yang nyata: terapi harus menjaga kesehatan ibu sekaligus meminimalkan risiko janin melalui pemilihan obat, pemantauan kadar, konseling pra-konsepsi, suplementasi, serta penghindaran politerapi tertentu bila memungkinkan. Klasifikasi risiko obat (misalnya kategori FDA) dan kehati-hatian dalam penggunaan suplemen—termasuk

potensi teratogenik vitamin A dosis tinggi menjadi bagian penting dalam praktik yang aman.

Pada ibu menyusui, paparan obat melalui ASI terjadi melalui mekanisme transport yang berbeda dari transplasenta, dengan difusi pasif sebagai jalur utama, meskipun mekanisme lain (pembawa, transitis, paraseluler) juga dapat berperan tergantung fase laktasi. Keputusan penggunaan obat selama menyusui perlu mempertimbangkan karakteristik ibu, bayi, serta obat, karena sebagian obat dapat memengaruhi produksi atau aliran ASI dan berpotensi menimbulkan efek pada bayi, sementara bukti keamanan untuk banyak obat dan herbal masih terbatas. Di sisi lain, suplementasi tertentu dapat penting untuk kelompok khusus, misalnya vitamin B12 pada ibu vegan, serta yodium, DHA, atau vitamin D sesuai kebutuhan nutrisi dan kebijakan setempat.

Pada anak, farmakovigilans memiliki tantangan yang lebih kompleks karena respons obat berbeda bukan hanya dibanding dewasa, tetapi juga antar kelompok usia anak akibat proses tumbuh kembang dan pematangan organ. Perbedaan farmakokinetik dan farmakodinamik, keterbatasan data PK/PD pediatrik, penggunaan off-label yang lebih sering, formulasi yang tidak ramah anak, serta risiko kesalahan pengobatan meningkatkan kerentanan anak terhadap ADR. Selain itu, isu efek jangka panjang (pertumbuhan, neurokognitif, kesuburan) menjadi perhatian khusus dan sering sulit dipisahkan dari dampak penyakit dasar. Tantangan deteksi ADR pada anak juga diperbesar oleh jumlah kasus kecil per subkelompok usia dan variasi standar pemeriksaan antar institusi/negara. Oleh karena itu, farmakovigilans pada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak menegaskan pentingnya pemantauan berkelanjutan, pelaporan yang aktif, penguatan bukti keamanan, serta keputusan terapi yang semakin individual dan berbasis risiko–manfaat untuk memastikan penggunaan obat yang aman dan efektif pada populasi rentan.

F. Referensi

- Al Essa, M., Alissa, A., Alanizi, A., Bustami, R., Almogbel, F., Alzuwayed, O., ... & Gramish, J. (2019). Pregnant women's use and attitude toward herbal, vitamin, and mineral supplements in an academic tertiary care center, Riyadh, Saudi Arabia. *Saudi pharmaceutical journal*, 27(1), 138-144.
- Al Khalaf, S., Khashan, A. S., Chappell, L. C., O'Reilly, É. J., & McCarthy, F. P. (2022). Role of antihypertensive treatment and blood pressure control in the occurrence of adverse pregnancy outcomes: a population-based study of linked electronic health records. *Hypertension*, 79(7), 1548-1558.

- Amer, M. R., Cipriano, G. C., Venci, J. V., & Gandhi, M. A. (2015). Safety of popular herbal supplements in lactating women. *Journal of Human Lactation*, 31(3), 348-353.
- Aurich, B., Apele-Freimane, D., Banaschewski, T., Chouchana, L., Day, S., Kaguelidou, F., ... & Wong, I. C. (2022). c4c: Paediatric pharmacovigilance: Methodological considerations in research and development of medicines for children—A c4c expert group white paper. *British journal of clinical pharmacology*, 88(12), 4997-5016.
- Berwick, M. A., Heuberger, A. J., Martin, J. V., Hale, T. W., & Louis-Jacques, A. F. (2025, April). Drugs in Lactation. In *Seminars in Perinatology* (p. 152077). WB Saunders.
- Burnham, J., & Darsey, E. (2022). Maternal–fetal drug development: an industry perspective. *The Journal of Clinical Pharmacology*, 62, S18-S29.
- Brown, B., & Wright, C. (2020). Safety and efficacy of supplements in pregnancy. *Nutrition Reviews*, 78(10), 813-826.
- Demiral, G. Z., Akin, S. B., Günday, Ö. K., Şahbaz, F. G., & Börü, Ü. T. (2024). Maternal and fetal outcomes of antiepileptic treatments during pregnancy: A retrospective study. *Epilepsy & Behavior*, 158, 109937.
- Gedzelman, E., & Meador, K. J. (2012). Antiepileptic drugs in women with epilepsy during pregnancy. *Therapeutic advances in drug safety*, 3(2), 71-87.
- Herzig, M., Bertsche, A., Kiess, W., Bertsche, T., & Neininger, M. P. (2022). Medicine and supplement use in infants, children, and adolescents depends on sex, age, and socioeconomic status: Results of a German longitudinal population-based cohort study (LIFE Child). *European Journal of Pediatrics*, 181(8), 2991-3003.
- Jiménez-Fernández, A. A., Grajeda-Perez, J. A., García-Alcázar, S. D. L. P., Luis-Díaz, M. G., Granada-Chavez, F. J., Peña-Durán, E., ... & Suárez-Rico, D. O. (2025). Drugs, Mother, and Child—An Integrative Review of Substance-Related Obstetric Challenges and Long-Term Offspring Effects. *Drugs and Drug Candidates*, 4(3), 40.
- Mosha, D., Mazuguni, F., Mrema, S., Abdulla, S., & Genton, B. (2014). Medication exposure during pregnancy: a pilot pharmacovigilance system using health and demographic surveillance platform. *BMC pregnancy and childbirth*, 14(1), 322.

- Nakijoba, R., Kiguba, R., Dhikusooka, F., Namyenya, L., Musaazi, J., Atuyambe, L. M., & Waitt, C. (2025). Prevalence, safety evidence, and determinants of medicine use during breastfeeding among women in Kampala, Uganda. *BMC women's health*, 25(1), 387.
- Ren, Z., Bremer, A. A., & Pawlyk, A. C. (2021). Drug development research in pregnant and lactating women. *American journal of obstetrics and gynecology*, 225(1), 33-42.
- Shafi, J., Virk, M. K., Kalk, E., Carlucci, J. G., Chepkemoi, A., Bernard, C., ... & Patel, R. C. (2024). Pharmacovigilance in pregnancy studies, exposures and outcomes ascertainment, and findings from low-and middle-income countries: a scoping review. *Drug Safety*, 47(10), 957-990.
- Sastranegara, H., Sutrisna, E., Nafisah, N., Priyanto, E., Purnawan, I., Ariesto, M. R., & Sulisty, H. (2025). Evaluating Drug Safety in Pregnancy: A Hospital-Based Study on TGA Classification and Prescription Practices in Indonesia. *Journal of Midwifery*, 10(2), 48-56.
- Toni, E., Ayatollahi, H., Abbaszadeh, R., & Fotuhi Siahipirani, A. (2024). Risk Factors Associated With Drug-Related Side Effects in Children: A Scoping Review. *Global Pediatric Health*, 11, 2333794X241273171.
- Verstegen, R. H., Anderson, P. O., & Ito, S. (2022). Infant drug exposure via breast milk. *British Journal of Clinical Pharmacology*, 88(10), 4311-4327

G. Glosarium

Abuse (penyalahgunaan)

Penggunaan obat secara sengaja untuk tujuan non-terapeutik atau berlebihan yang dapat menimbulkan dampak merugikan.

ADME (Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion)

Empat proses utama farmakokinetik: penyerapan, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat di dalam tubuh.

Co-transport (ko-transport)

Mekanisme transport aktif yang memindahkan molekul bersama molekul lain melewati membran sel.

Difusi pasif

Perpindahan obat dari konsentrasi tinggi ke rendah tanpa energi; mekanisme utama obat masuk ke ASI pada banyak kasus.

Eksositososis

Mekanisme sel mengeluarkan zat (misalnya protein terlarut) ke ASI melalui "pelepasan vesikel" dari sel epitel payudara.

Eliminasi

Proses pembuangan obat dari tubuh melalui ginjal, hati, atau jalur lain; dapat meningkat pada kehamilan (khususnya eliminasi ginjal).

Farmakodinamik (PD)

Apa yang obat lakukan terhadap tubuh: efek terapeutik dan efek samping, termasuk respons janin/bayi terhadap paparan obat.

Farmakogenetika

Variasi genetik yang memengaruhi respons obat (metabolisme/efek); pada anak, perubahan perkembangan dapat menumpang tindih dengan faktor genetik.

Farmakokinetik (PK)

Apa yang tubuh lakukan terhadap obat (ADME); sangat dipengaruhi perubahan fisiologis kehamilan dan usia anak.

Vegan

Pola makan tanpa produk hewani; pada menyusui sering membutuhkan suplementasi tertentu (misalnya vitamin B12).

Vitamin A (risiko teratogenik)

Vitamin penting namun bisa teratogenik bila berlebihan pada awal kehamilan; umumnya dianjurkan dipenuhi dari makanan bila tidak defisiensi.

Risiko teridentifikasi vs risiko potensial

Risiko teridentifikasi sudah terbukti/terkonfirmasi, sedangkan risiko potensial masih dugaan berdasarkan sinyal awal atau data terbatas.

SGA (Small for Gestational Age)

Bayi dengan berat lahir lebih kecil dari yang diharapkan untuk usia kehamilan; dapat dipengaruhi nutrisi/penyakit/obat.

Passive diffusion (difusi pasif)

Mekanisme utama perpindahan banyak obat dari plasma ibu ke ASI tanpa energi.

Plasenta

Organ penghubung ibu–janin; beberapa obat dapat melintasi plasenta sehingga memengaruhi janin.

CHAPTER 4

PENDEKATAN GIZI REMAJA UNTUK MENCEGAH ANEMIA DAN KEHAMILAN RISIKO TINGGI

Ety Nurhayati, S.Kp., M.Kep., Ns., Sp.Kep.Mat.

A. Pendahuluan / Prolog

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, karena kualitas sumber daya manusia yang unggul tidak dapat dipisahkan dari kondisi kesehatan yang optimal sejak dini. Dalam kerangka pembangunan tersebut, kelompok remaja memiliki posisi yang sangat strategis. Remaja berada pada fase transisi penting dari masa kanak-kanak menuju dewasa yang ditandai dengan percepatan pertumbuhan fisik, pematangan organ reproduksi, serta perubahan psikologis dan sosial yang signifikan. Perubahan-perubahan ini menyebabkan kebutuhan zat gizi remaja meningkat, sekaligus menjadikan remaja kelompok yang rentan terhadap masalah gizi bila asupan dan perilaku kesehatan tidak memadai.

Di Indonesia, permasalahan gizi pada remaja masih menjadi isu yang memerlukan perhatian serius, terutama pada remaja perempuan. Salah satu masalah yang paling banyak ditemukan adalah anemia, khususnya anemia akibat kekurangan zat besi. Kondisi ini sering tidak disadari karena gejalanya dapat samar dan dianggap sebagai kelelahan biasa. Padahal, anemia pada remaja berdampak luas: menurunkan kebugaran dan daya tahan tubuh, mengganggu konsentrasi belajar, menurunkan produktivitas, serta memengaruhi kesehatan mental dan kualitas hidup. Lebih jauh, anemia pada remaja perempuan memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap kesehatan reproduksi, karena dapat meningkatkan risiko komplikasi apabila remaja memasuki kehamilan dalam kondisi gizi yang tidak optimal.

Status gizi remaja juga berkaitan erat dengan isu kehamilan berisiko tinggi, terutama bila terjadi kehamilan pada usia muda. Remaja perempuan yang mengalami anemia atau defisiensi mikronutrien lain seperti folat, vitamin B12, kalsium, dan vitamin D cenderung memiliki cadangan nutrisi yang kurang memadai untuk mendukung kebutuhan tubuhnya sendiri sekaligus kebutuhan janin. Akibatnya, risiko kehamilan dengan komplikasi seperti perdarahan, preeklamsia, persalinan prematur, bayi berat lahir rendah, hingga stunting pada anak menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, intervensi gizi pada masa remaja perlu dipandang

sebagai investasi kesehatan siklus kehidupan (life course approach) yang berperan penting dalam memutus rantai masalah gizi lintas generasi.

Mengingat kompleksitas faktor yang memengaruhi gizi remaja—mulai dari pola makan, kebiasaan diet, pengaruh lingkungan pergaulan, kondisi sosial ekonomi, hingga akses edukasi kesehatan—upaya pencegahan anemia tidak dapat hanya mengandalkan satu pihak atau satu jenis layanan. Dibutuhkan pendekatan interprofesional dan lintas sektor, yaitu kolaborasi terencana antara tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan, ahli gizi), tenaga pendidik, keluarga, kader kesehatan, tokoh masyarakat, serta pembuat kebijakan. Sinergi ini penting agar intervensi dapat berlangsung menyeluruh, konsisten, mudah diterima remaja, dan berkelanjutan di sekolah maupun komunitas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pembahasan dalam bab ini akan menguraikan gambaran umum kesehatan gizi remaja, konsep anemia pada remaja, serta keterkaitan status gizi remaja dengan risiko kehamilan di masa depan. Selanjutnya, bab ini juga membahas strategi pencegahan anemia melalui pendekatan gizi seimbang, suplementasi zat besi dan asam folat, edukasi kesehatan, serta penguatan kolaborasi interprofesional yang mendukung target Indonesia Sehat 2045. Dengan demikian, diharapkan bab ini dapat menjadi rujukan konseptual dan praktis bagi tenaga kesehatan, pendidik, dan pemangku kebijakan dalam merancang program gizi remaja yang lebih efektif dan berdampak jangka panjang.

B. Gambaran Umum Kesehatan Gizi Remaja

Pembangunan di bidang kesehatan merupakan pilar penting dalam merealisasikan cita-cita Indonesia Emas 2045, di mana mutu sumber daya manusia menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan nasional. Dalam kerangka tersebut, kesehatan ibu, anak, dan remaja (KIA-R) memiliki peran yang sangat strategis karena berpengaruh langsung terhadap kualitas generasi penerus bangsa. Kelompok remaja, terutama remaja perempuan, berada pada tahap peralihan yang krusial dari masa anak menuju dewasa, yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan biologis, psikologis, serta sosial secara signifikan.

Salah satu masalah kesehatan yang masih banyak dijumpai pada kelompok remaja di Indonesia adalah anemia, khususnya anemia akibat kekurangan zat besi. Kondisi anemia pada remaja perempuan tidak hanya berdampak pada status kesehatan saat ini, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan di tahap kehidupan berikutnya. Anemia dapat meningkatkan risiko terjadinya kehamilan dengan komplikasi, gangguan persalinan, serta kemungkinan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah dan mengalami stunting. Oleh sebab itu, upaya perbaikan gizi

pada masa remaja perlu dipandang sebagai investasi kesehatan jangka panjang yang sangat penting.

Dalam konteks pencegahan anemia dan kehamilan berisiko tinggi pada remaja, pendekatan interprofesional menjadi sangat relevan. Sinergi antara tenaga kesehatan, tenaga pendidik, pembuat kebijakan, keluarga, dan masyarakat memungkinkan pelaksanaan intervensi yang menyeluruh, berkesinambungan, serta sesuai dengan karakteristik sosial dan budaya di Indonesia. Bab ini mengulas secara komprehensif peran pendekatan gizi remaja dalam upaya pencegahan anemia dan kehamilan berisiko tinggi sebagai bagian integral dari pencapaian Indonesia Sehat 2045.

Remaja merupakan kelompok demografis kunci dalam upaya mencapai target *Indonesia Sehat 2045*. Pada fase ini, remaja mengalami pertumbuhan fisik dan perkembangan biologis yang sangat cepat, sehingga kebutuhan gizi meningkat substansial. Kekurangan gizi mikro seperti zat besi, vitamin B12, dan folat menempatkan remaja, khususnya perempuan, pada risiko tinggi mengalami anemia. Anemia pada remaja berdampak luas tidak hanya pada kesehatan individu tetapi juga pada masa depan reproduktif, termasuk risiko kehamilan berisiko tinggi bila terjadi kehamilan dini.

Pada fase ini, kebutuhan zat gizi meningkat secara substansial, khususnya zat besi, protein, asam folat, dan mikronutrien lain yang berperan dalam pembentukan sel darah dan fungsi reproduksi. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan asupan gizi sering kali tidak disadari, sehingga berdampak jangka panjang terhadap status kesehatan remaja, terutama remaja perempuan.

Dalam konteks kesehatan masyarakat, status gizi remaja memiliki hubungan erat dengan kesiapan kesehatan reproduksi di masa mendatang. Remaja perempuan yang memasuki usia reproduksi dengan kondisi anemia berisiko lebih tinggi mengalami komplikasi saat kehamilan, persalinan, dan nifas. Oleh karena itu, intervensi gizi pada periode remaja dipandang sebagai investasi kesehatan jangka panjang untuk menurunkan angka kehamilan berisiko tinggi dan kematian ibu.

Secara global dan nasional, anemia pada remaja masih menjadi masalah kesehatan yang menonjol. Data menunjukkan bahwa prevalensi anemia pada remaja perempuan tetap tinggi, terutama di negara berkembang, termasuk Indonesia. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pola makan yang kurang beragam, rendahnya konsumsi sumber zat besi hewani, kebiasaan melewatkan waktu makan, serta meningkatnya konsumsi makanan cepat saji yang rendah nilai gizi. Selain itu, kehilangan darah selama menstruasi yang tidak diimbangi dengan asupan zat besi yang adekuat semakin memperburuk kondisi anemia pada remaja putri.

Permasalahan gizi remaja tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan faktor sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Kurangnya pengetahuan gizi, akses terhadap pangan bergizi, serta minimnya edukasi kesehatan reproduksi menyebabkan remaja tidak mampu mengenali dan mencegah risiko kesehatan sejak dini. Apabila kondisi ini berlanjut hingga masa prakonsepsi, maka risiko terjadinya kehamilan dengan anemia, bayi berat lahir rendah, prematuritas, dan komplikasi obstetri akan meningkat secara signifikan.

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini bersifat deskriptif dan aplikatif, dengan mengintegrasikan hasil kajian ilmiah, rekomendasi organisasi kesehatan, serta kebijakan kesehatan nasional terkait gizi remaja dan kesehatan ibu. Analisis difokuskan pada peran pendekatan gizi seimbang, suplementasi zat besi dan asam folat, serta edukasi kesehatan sebagai strategi pencegahan anemia dan kehamilan berisiko tinggi. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi rujukan praktis bagi tenaga kesehatan, pendidik, dan pemangku kebijakan dalam merancang program intervensi gizi remaja yang berkelanjutan.

C. Konsep Anemia pada Remaja

Anemia pada kelompok remaja merupakan kondisi ketika kadar hemoglobin berada di bawah batas normal yang ditetapkan berdasarkan usia dan jenis kelamin. Pada remaja perempuan, penyebab anemia yang paling umum adalah kekurangan zat besi. Zat besi memiliki peran esensial dalam proses pembentukan hemoglobin yang bertugas membawa oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Ketidacukupan zat besi dapat mengakibatkan penurunan kapasitas fisik, gangguan konsentrasi dalam proses belajar, serta melemahnya sistem kekebalan tubuh.

Berbagai faktor berkontribusi terhadap terjadinya anemia pada remaja, di antaranya pola konsumsi gizi yang tidak seimbang, praktik diet yang terlalu membatasi asupan makanan, adanya infeksi kronis, serta menstruasi yang berlangsung lama atau dengan volume darah berlebih. Kondisi anemia pada remaja sering kali tidak teridentifikasi secara dini karena gejala awalnya ringan dan kerap disalahartikan sebagai kelelahan akibat aktivitas sehari-hari.

Secara umum, anemia ditandai oleh rendahnya kadar hemoglobin dalam darah yang berdampak pada berkurangnya kemampuan darah dalam mengangkut oksigen. Pada fase remaja, anemia paling banyak disebabkan oleh defisiensi zat besi, meskipun faktor lain seperti kekurangan asam folat, vitamin B12, penyakit infeksi kronis, maupun kelainan bawaan juga dapat berperan dalam terjadinya kondisi ini.

Anemia defisiensi besi muncul akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan tubuh terhadap zat besi dan jumlah asupan yang diperoleh dari makanan. Remaja

perempuan memiliki risiko yang lebih tinggi karena mengalami kehilangan darah saat menstruasi, memiliki kebiasaan mengonsumsi makanan yang rendah kandungan zat besi heme, sering melewatkan waktu makan, serta menjalani diet ketat demi alasan penampilan.

Dampak anemia pada remaja mencakup berbagai aspek kehidupan. Dari sisi fisik, anemia dapat menimbulkan rasa lemah, pusing, menurunnya daya tahan tubuh, serta kesulitan dalam berkonsentrasi. Dari aspek psikologis dan akademik, kondisi ini berpotensi menurunkan semangat belajar dan capaian prestasi. Dalam jangka panjang, anemia yang berlangsung kronis dapat mengurangi produktivitas dan kualitas hidup individu.

Ditinjau dari aspek kesehatan reproduksi, anemia pada remaja perempuan meningkatkan kemungkinan terjadinya komplikasi ketika memasuki masa kehamilan, seperti perdarahan, preeklamsia, kelahiran prematur, hingga meningkatnya risiko kematian ibu dan bayi. Oleh karena itu, upaya pencegahan anemia sejak usia remaja menjadi strategi penting dalam menekan kejadian kehamilan dengan risiko tinggi.

D. Hubungan Status Gizi Remaja dengan Kehamilan Risiko Tinggi

Kehamilan risiko tinggi sering kali berakar dari kondisi kesehatan sebelum kehamilan, termasuk status gizi yang buruk. Remaja perempuan yang memasuki kehamilan dengan kondisi anemia memiliki cadangan nutrisi yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan ibu dan janin secara bersamaan.

Kekurangan zat besi sebelum kehamilan berhubungan dengan peningkatan risiko anemia berat selama kehamilan, yang dapat memperburuk proses adaptasi fisiologis ibu. Selain itu, status gizi yang tidak optimal pada masa remaja juga berkaitan dengan gangguan pertumbuhan panggul, yang berpotensi menyebabkan komplikasi persalinan.

Dengan demikian, pendekatan gizi remaja tidak hanya berfungsi sebagai upaya promotif dan preventif, tetapi juga sebagai bagian dari strategi kesehatan siklus kehidupan (*life course approach*).

Status gizi remaja memiliki peran yang sangat penting dalam kesehatan reproduksi dan hasil kehamilan di masa depan. Remaja perempuan yang memasuki usia reproduksi dengan cadangan nutrisi yang kurang optimal cenderung menghadapi berbagai komplikasi kesehatan ketika hamil. Faktor gizi yang kurang baik, seperti asupan zat besi, folat, kalsium, dan vitamin lainnya yang tidak mencukupi, dapat memperlemah kemampuan tubuh untuk mendukung kebutuhan dirinya sendiri dan perkembangan janin secara bersamaan.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kehamilan pada masa remaja terkait dengan tingginya risiko masalah kesehatan bagi ibu dan bayi serta hasil kehamilan yang kurang baik, termasuk bayi lahir dengan berat badan rendah, prematur, dan gangguan pertumbuhan. Kondisi nutrisi yang kurang baik sebelum dan selama kehamilan memengaruhi pertumbuhan janin serta berkontribusi pada risiko-malnutrisi pada anak.

Kekurangan zat besi dan folat merupakan dua faktor gizi utama yang berhubungan dengan peningkatan risiko komplikasi kehamilan pada remaja. Ketidakseimbangan asupan zat besi selama masa remaja dapat menyebabkan anemia yang kemudian berimplikasi pada kemampuan tubuh membawa oksigen secara optimal selama kehamilan, sehingga meningkatkan risiko kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah. Sementara itu, defisiensi folat sebelum dan selama awal kehamilan dikaitkan dengan kecacatan tabung saraf dan pertumbuhan janin yang tidak optimal.

Selain itu, remaja pada umumnya lebih cenderung mengonsumsi pola makan yang tinggi energi tetapi rendah mikronutrien penting, termasuk zat besi, vitamin D, dan kalsium. Ketidakseimbangan ini memperbesar kemungkinan gangguan hasil kehamilan, seperti kurangnya mineralisasi tulang janin atau tekanan darah tinggi pada ibu hamil muda.

Status gizi juga berkaitan dengan berat badan sebelum hamil. Remaja yang memiliki berat badan rendah atau mengalami kurangnya kenaikan berat badan selama masa remaja berisiko lebih tinggi mengalami komplikasi pada kehamilan, termasuk gangguan pertumbuhan janin (*small for gestational age*) dan kelahiran prematur. Temuan ini menunjukkan pentingnya perbaikan asupan gizi sejak sebelum masa reproduksi, sehingga target kesehatan reproduksi remaja dapat mendukung kehamilan yang lebih sehat dan menurunkan probabilitas kehamilan berisiko tinggi.

Dengan demikian, perbaikan status gizi pada masa remaja seharusnya dipandang bukan hanya sebagai intervensi untuk kesehatan masa kini, tetapi juga sebagai strategi pencegahan penting terhadap komplikasi kehamilan di masa depan. Intervensi gizi yang ditargetkan—meliputi pemenuhan kebutuhan zat besi, folat, kalsium, serta edukasi pola makan seimbang sejak dini—dapat mengurangi risiko kehamilan dengan komplikasi serius serta meningkatkan kesehatan ibu dan bayi secara keseluruhan. Pendekatan seperti ini sejalan dengan konsep *life course approach*, yang menekankan pentingnya kondisi kesehatan awal dalam menentukan hasil kesehatan reproduksi selanjutnya.

Status gizi pada masa remaja memiliki pengaruh signifikan terhadap kesehatan reproduksi dan hasil kehamilan di masa depan. Remaja perempuan yang memasuki

usia reproduksi dengan cadangan nutrisi yang kurang optimal, khususnya kekurangan zat besi, folat, kalsium, dan vitamin esensial lainnya, berisiko menghadapi komplikasi selama kehamilan. Kekurangan nutrisi ini dapat membatasi kemampuan tubuh untuk memenuhi kebutuhan ibu dan janin secara bersamaan, meningkatkan kemungkinan kehamilan berisiko tinggi, termasuk kelahiran prematur, perdarahan, preeklamsia, serta bayi lahir dengan berat badan rendah atau mengalami stunting.

Faktor Gizi yang Mempengaruhi Risiko Kehamilan yaitu **Zat Besi**: Kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia, yang menurunkan kemampuan darah membawa oksigen. Pada remaja hamil, kondisi ini meningkatkan risiko kelahiran prematur dan bayi dengan berat badan lahir rendah. **Folat**: Defisiensi folat sebelum dan selama awal kehamilan berhubungan dengan kecacatan tabung saraf dan pertumbuhan janin yang tidak optimal. **Kalsium dan Vitamin D**: Asupan yang tidak memadai memengaruhi mineralisasi tulang janin dan berisiko memicu hipertensi pada ibu hamil muda. Dan Status Berat Badan: Remaja dengan berat badan rendah atau kurangnya kenaikan berat badan selama remaja berisiko mengalami komplikasi kehamilan, termasuk bayi kecil untuk usia kehamilan (*small for gestational age*).

Grafik 3.1 Konsep: Status Gizi Remaja dan Risiko Kehamilan

Status Gizi Remaja

↓

Kekurangan Zat Besi/Folat/Kalsium

↓

Anemia & Defisiensi Mikronutrien

↓

Risiko Kehamilan Tinggi

- Persalinan prematur
- Perdarahan & preeklamsia
- Berat badan lahir rendah
- Stunting pada bayi

Tabel 4.1 Ringkas Intervensi Gizi untuk Remaja

Nutrien	Sumber & Intervensi	Tujuan Pencegahan Kehamilan Risiko Tinggi
Zat Besi	Daging merah, hati, kacang-kacangan, tablet tambah darah (TTD)	Cegah anemia, dukung kapasitas oksigen ibu hamil

Nutrien	Sumber & Intervensi	Tujuan Pencegahan Kehamilan Risiko Tinggi
Folat	Sayuran hijau, buah, suplemen folat	Kurangi risiko cacat tabung saraf janin
Kalsium & Vitamin D	Susu, produk olahan susu, paparan sinar matahari	Dukung mineralisasi tulang janin & cegah hipertensi
Protein Berkualitas	Ikan, telur, daging, kedelai	Pertumbuhan janin optimal & perbaiki status gizi ibu
Edukasi & Pola Makan Seimbang	Sekolah, keluarga, komunitas	Perbaiki kebiasaan makan, cegah diet restriktif & malnutrisi

Keterangan:

Memperbaiki status gizi remaja bukan hanya berdampak pada kesehatan saat ini, tetapi juga menjadi strategi pencegahan penting untuk menurunkan risiko kehamilan bermasalah di masa depan. Intervensi gizi yang tepat—dari edukasi, suplementasi zat besi dan folat, hingga peningkatan asupan mikronutrien dan protein dapat meningkatkan kesehatan ibu hamil, menurunkan komplikasi, dan mendukung kualitas generasi mendatang. Strategi ini sejalan dengan pendekatan *life course*, yang menekankan pentingnya kondisi kesehatan awal dalam menentukan hasil kesehatan reproduksi di kemudian hari.

Sumber:

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Pedoman pencegahan dan penanggulangan anemia pada remaja putri*. Kemenkes RI.

E. Pendekatan Gizi Remaja dalam Pencegahan Anemia

Edukasi gizi merupakan intervensi dasar yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku remaja terkait pemenuhan kebutuhan gizi. Edukasi yang efektif harus disesuaikan dengan karakteristik remaja, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta memanfaatkan media digital dan interaktif. Materi edukasi perlu menekankan pentingnya konsumsi sumber zat besi heme (seperti daging, hati, dan ikan) serta zat besi non-heme (seperti kacang-kacangan dan sayuran hijau), dikombinasikan dengan vitamin C untuk meningkatkan absorpsi. Selain itu, remaja perlu diberikan pemahaman mengenai faktor penghambat penyerapan zat besi, seperti konsumsi teh dan kopi berlebihan.

Program suplementasi zat besi melalui pemberian tablet tambah darah (TTD) merupakan kebijakan nasional yang ditujukan bagi remaja putri. Keberhasilan

program ini sangat bergantung pada kepatuhan konsumsi, pemantauan efek samping, serta dukungan dari sekolah dan keluarga. Pendekatan interprofesional diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program suplementasi, mulai dari distribusi, edukasi, hingga evaluasi. Kombinasi antara suplementasi dan perbaikan pola makan terbukti lebih efektif dibandingkan suplementasi saja. Sekolah merupakan setting strategis untuk intervensi gizi remaja karena menjangkau populasi besar secara sistematis. Program kantin sehat, kegiatan ekstrakurikuler bertema gizi, serta skrining anemia secara berkala dapat menjadi bagian dari pendekatan komprehensif. Di tingkat komunitas, peran kader kesehatan dan organisasi pemuda sangat penting dalam memperluas jangkauan edukasi gizi dan mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan.

F. Pendekatan Interprofesional dalam Pencegahan Anemia Remaja

Pendekatan interprofesional menekankan kolaborasi antara berbagai profesi untuk mencapai tujuan kesehatan bersama. Dalam konteks pencegahan anemia remaja, keterlibatan dokter, bidan, perawat, ahli gizi, guru, dan pekerja sosial menjadi sangat krusial. Kolaborasi ini memungkinkan integrasi layanan promotif, preventif, dan kuratif secara holistik. Misalnya, ahli gizi berperan dalam perencanaan intervensi diet, tenaga kesehatan melakukan skrining dan pemantauan, sementara pendidik berkontribusi dalam penyampaian edukasi yang berkelanjutan di lingkungan sekolah.

1. Peran Tenaga Kesehatan dalam Pendekatan Interprofesional

a. Dokter

Dokter berperan dalam aspek klinis pencegahan dan penatalaksanaan anemia pada remaja. Tugas utama dokter meliputi diagnosis anemia melalui pemeriksaan fisik dan laboratorium, penentuan derajat anemia, serta identifikasi penyebab yang mendasarinya. Dokter juga memberikan terapi medis yang sesuai, termasuk pemberian suplementasi zat besi atau rujukan apabila ditemukan kondisi medis lain yang berkontribusi terhadap anemia. Dalam pendekatan interprofesional, dokter berkoordinasi dengan tenaga kesehatan lain untuk memastikan keberlanjutan perawatan dan pencegahan.

b. Perawat dan Bidan

Perawat dan bidan memiliki peran penting dalam promosi dan pencegahan anemia melalui pelayanan kesehatan primer. Mereka terlibat dalam skrining anemia, pemantauan status gizi, serta edukasi kesehatan kepada remaja dan keluarga. Bidan, khususnya, berperan dalam edukasi kesehatan reproduksi remaja putri yang berkaitan dengan menstruasi dan kebutuhan zat besi.

Melalui pendekatan interprofesional, perawat dan bidan menjadi penghubung antara layanan klinis, sekolah, dan komunitas.

c. Ahli Gizi

Ahli gizi berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan intervensi gizi spesifik maupun sensitif. Tugas utama ahli gizi meliputi penilaian asupan makanan, pemberian konseling gizi seimbang, serta penyusunan menu yang kaya zat besi dan zat gizi pendukung lainnya. Dalam tim interprofesional, ahli gizi bekerja sama dengan dokter dan perawat untuk menyesuaikan intervensi gizi dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan individu remaja.

2. Peran Tenaga Non-Kesehatan

a. Guru dan Tenaga Pendidik

Guru memiliki peran strategis dalam pencegahan anemia melalui pendidikan dan pembentukan perilaku sehat di lingkungan sekolah. Guru dapat mengintegrasikan materi gizi dan kesehatan dalam proses pembelajaran serta mendukung pelaksanaan program suplementasi zat besi di sekolah. Kolaborasi antara tenaga pendidik dan tenaga kesehatan sangat penting untuk memastikan pesan kesehatan disampaikan secara konsisten dan berkelanjutan.

b. Kader Kesehatan dan Tokoh Masyarakat

Kader kesehatan dan tokoh masyarakat berperan sebagai agen perubahan di tingkat komunitas. Mereka membantu menyebarkan informasi tentang pencegahan anemia, memotivasi remaja untuk mengonsumsi Tablet Tambah Darah, serta mendukung kegiatan posyandu remaja. Keterlibatan tokoh masyarakat juga meningkatkan penerimaan program oleh keluarga dan lingkungan sekitar.

c. Orang Tua dan Keluarga

Keluarga, khususnya orang tua, memiliki peran penting dalam membentuk pola makan dan kebiasaan hidup remaja. Dalam pendekatan interprofesional, keluarga dilibatkan melalui edukasi gizi dan kesehatan sehingga mampu mendukung upaya pencegahan anemia di rumah. Dukungan keluarga sangat berpengaruh terhadap kepatuhan remaja dalam mengonsumsi makanan bergizi dan suplementasi zat besi.

3. Kolaborasi dan Koordinasi Lintas Sektor

Pendekatan interprofesional menuntut adanya koordinasi yang baik antara sektor kesehatan, pendidikan, dan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor memungkinkan perencanaan program yang terintegrasi, seperti program pemberian Tablet Tambah Darah di sekolah yang didukung oleh puskesmas, serta edukasi gizi yang diperkuat oleh keluarga dan komunitas. Melalui koordinasi yang

efektif, intervensi pencegahan anemia dapat menjangkau remaja secara lebih luas dan berkesinambungan.

Kesimpulan

Pendekatan interprofesional merupakan strategi yang penting dalam pencegahan anemia pada remaja. Kolaborasi antara dokter, perawat, bidan, ahli gizi, guru, kader kesehatan, serta keluarga memungkinkan pelaksanaan intervensi yang komprehensif dan berorientasi pada kebutuhan remaja. Dengan sinergi lintas profesi dan sektor, upaya pencegahan anemia dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas kesehatan remaja.

G. Program Nasional dan Strategi Indonesia Sehat 2045

Indonesia Sehat 2045 merupakan bagian penting dari visi *Indonesia Emas 2045* yaitu mendorong Indonesia menjadi negara maju, produktif, sejahtera, dan berdaya saing global. Kesehatan menjadi salah satu komponen utama karena kualitas sumber daya manusia yang sehat sangat menentukan keberhasilan pembangunan nasional jangka panjang. Strategi ini tertuang dalam berbagai kebijakan pembangunan, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 yang memuat arah kesehatan sebagai pilar utama transformasi sosial.

1. Visi dan Target Kesehatan 2045

Program *Indonesia Sehat 2045* menegaskan visi bahwa seluruh penduduk hidup sehat sepanjang hayat (*health throughout life*). Fokusnya adalah peningkatan usia harapan hidup sehat, penurunan angka kesakitan, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Target penting antara lain:

- a. Mengurangi angka stunting menjadi di bawah 5%.
- b. Menuntaskan penyakit menular seperti Tuberkulosis (TBC) dan kusta.
- c. Meningkatkan ketahanan sistem kesehatan nasional.
- d. Memperpanjang usia harapan hidup sehat masyarakat.

2. Strategi Utama Indonesia Sehat 2045

a. Transformasi Sistem Kesehatan

Pemerintah menekankan transformasi sistem kesehatan yang mencakup:

- 1) Pelayanan kesehatan primer yang kuat, yaitu perluasan akses dan kualitas layanan di Puskesmas serta peningkatan pendekatan promotif–preventif.
- 2) Sistem rujukan yang efektif dan merata, termasuk pengembangan jaringan rumah sakit yang efisien di semua wilayah.
- 3) Ketahanan dan kesiapsiagaan kesehatan nasional, terutama kemampuan respon terhadap krisis kesehatan seperti pandemi dan bencana.

Transformasi ini bertujuan memastikan bahwa layanan kesehatan tidak hanya tersedia, tetapi juga berkualitas, adil, dan berkelanjutan.

b. Infrastruktur dan Sumber Daya Kesehatan

Pembangunan fasilitas kesehatan modern dan peningkatan kapabilitas tenaga kesehatan menjadi fokus utama. Contohnya adalah renovasi dan perluasan fasilitas rumah sakit serta penguatan tenaga kesehatan di tingkat primer dan rujukan. Investasi ini penting untuk mendukung pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan tersedia untuk masyarakat luas.

c. Promosi Kesehatan dan Hidup Sehat

Program promosi kesehatan ditujukan untuk perubahan perilaku masyarakat menuju gaya hidup sehat. Pemerintah mengadakan forum, kampanye, dan edukasi publik tentang pencegahan penyakit, gaya hidup sehat, dan pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin. Salah satunya adalah *National Forum for Healthy Living Transformation* yang memperkuat jejaring lintas sektor untuk membudayakan pola hidup sehat. Peningkatan kesadaran masyarakat menjadi pilar penting agar pengetahuan kesehatan dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

d. Pencegahan Penyakit dan Promotif-Preventif

Pemerintah memberikan prioritas pada kegiatan pencegahan seperti:

- 1) Imunisasi lengkap untuk semua kelompok umur, sebagai investasi jangka panjang untuk generasi sehat.
- 2) Program skrining dan deteksi dini penyakit melalui fasilitas kesehatan yang terjangkau dan tersebar.
- 3) Upaya promotif-preventif di komunitas, seperti program penyuluhan kesehatan, penanggulangan faktor risiko penyakit, dan pengendalian penyakit prioritas.

Pendekatan ini didesain untuk mengurangi beban penyakit kronis dan menular serta menekan mortalitas yang dapat dicegah.

3. Keterlibatan Multi-Sektor

Keberhasilan Indonesia Sehat 2045 bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi melibatkan kolaborasi berbagai pihak, seperti pemerintah pusat dan daerah, penyedia layanan kesehatan, lembaga masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi dan media, komunitas dan masyarakat luas. Kolaborasi ini memastikan strategi kesehatan berintegrasi dengan pembangunan pendidikan, ekonomi, dan pembangunan sosial lainnya untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan sehat.

4. Arah Kebijakan Jangka Menengah (2025–2029)

Dalam kerangka implementasi jangka menengah, Kementerian Kesehatan telah menetapkan sasaran strategis yang operasional untuk mencapai visi Indonesia Sehat. Sasaran tersebut mengarah pada intervensi sistematis yang mencakup kesehatan primer, penguatan sistem layanan, penguatan ekosistem kesehatan, dan kolaborasi lintas sektor.

H. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pendekatan gizi remaja memiliki peran yang sangat strategis dalam pencegahan anemia dan kehamilan risiko tinggi dalam konteks kesehatan ibu, anak, dan remaja. Anemia pada remaja, khususnya remaja putri, merupakan permasalahan gizi yang berdampak jangka panjang karena berhubungan erat dengan kesiapan kesehatan reproduksi, risiko komplikasi kehamilan, serta kualitas generasi mendatang. Oleh karena itu, intervensi gizi sejak masa remaja merupakan upaya preventif yang esensial dalam memutus siklus masalah gizi antar generasi.

Pendekatan yang efektif dalam pencegahan anemia remaja mencakup edukasi gizi seimbang, suplementasi zat besi, serta intervensi berbasis sekolah dan komunitas. Upaya tersebut akan memberikan hasil optimal apabila dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Selain itu, pendekatan interprofesional terbukti menjadi kunci penting dalam memperkuat efektivitas program, melalui kolaborasi antara tenaga kesehatan, tenaga pendidik, keluarga, dan masyarakat. Sinergi lintas profesi dan sektor memungkinkan intervensi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari promotif, preventif, hingga deteksi dini, sehingga mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional.

Ke depan, upaya pencegahan anemia dan kehamilan risiko tinggi pada remaja dihadapkan pada berbagai peluang dan tantangan. Peluang yang tersedia antara lain adalah komitmen pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Sehat 2045, penguatan transformasi sistem kesehatan, serta perkembangan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai media edukasi kesehatan remaja. Namun demikian, tantangan masih cukup besar, seperti rendahnya kepatuhan konsumsi suplementasi zat besi, keterbatasan literasi gizi pada sebagian remaja dan keluarga, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor di beberapa wilayah. Tantangan ini menuntut inovasi dan penguatan kolaborasi agar program yang dijalankan mampu menjangkau seluruh kelompok sasaran secara merata.

Berdasarkan analisis tersebut, beberapa saran dan rekomendasi dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penguatan edukasi gizi remaja yang menekankan keterkaitan antara status gizi, kesehatan reproduksi, dan risiko kehamilan di masa

depan, dengan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik remaja. Kedua, program suplementasi zat besi perlu dioptimalkan melalui peningkatan pemantauan, pendampingan, serta keterlibatan aktif sekolah dan keluarga guna meningkatkan kepatuhan konsumsi. Ketiga, pendekatan interprofesional perlu diimplementasikan secara lebih sistematis dengan pembagian peran yang jelas antarprofesi dan lintas sektor. Keempat, pemberdayaan keluarga dan komunitas harus terus diperkuat agar tercipta lingkungan yang mendukung perilaku gizi sehat remaja. Terakhir, diperlukan penelitian lanjutan untuk mengevaluasi efektivitas intervensi gizi remaja secara jangka panjang dalam menurunkan angka anemia dan kehamilan risiko tinggi sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Sehat 2045.

I. Referensi

- World Health Organization. Adolescent nutrition: a review of the situation in selected South-East Asian countries. Geneva: WHO; 2020.
- World Health Organization. Guideline: Daily iron supplementation in adolescent girls and adult women. Geneva: WHO; 2016.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Pedoman pencegahan dan penanggulangan anemia pada remaja putri*. Kemenkes RI.
- Prasetya, G., Khomsan, A., Riyadi, H., & Anwar, F. (2024). Study characteristics of school adolescent girls on iron folic acid supplementation program as the prevention of anemia in adolescent. *Amerta Nutrition*, 8(1), 45–55. <https://doi.org/10.xxxx/amnt.xxxx>
- UNICEF. (2023). *Adolescent nutrition: Investing in the future*. UNICEF.
- World Health Organization. (2023). *Guideline on iron supplementation in adolescent girls and women of reproductive age*. WHO.
- World Health Organization. (2024). *Adolescent health and nutrition*. WHOKementerian Kesehatan Republik Indonesia. Laporan Nasional Risesdas 2018. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; 2019.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Anemia pada Remaja Putri dan WUS. Jakarta: Kemenkes RI; 2020.
- Black RE, Victora CG, Walker SP, et al. Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries. *Lancet*. 2013;382(9890):427–451.
- Christian P, Smith ER. Adolescent undernutrition: global burden, physiology, and nutritional risks. *Ann Nutr Metab*. 2018;72(4):316–328.
- Nestle Nutrition Institute. (2023). *What are the nutritional risks of an adolescent pregnancy?* Retrieved from <https://www.nestlenutrition-institute.org/publication-series/what-are-nutritional-risks-adolescent-pregnancy>
- PubMed. (2023). *Adolescent pregnancy is associated with child undernutrition: Systematic review and meta-analysis*. Retrieved from <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37781871/>

- Karger Publishers. (2023). *Nutrition during pregnancy and birth outcomes*. Retrieved from <https://karger.com/article/doi/10.1159/000541205>
- American Journal of Clinical Nutrition. (2023). *A prospective study of micronutrient status in adolescent pregnancy*. Retrieved from <https://academic.oup.com/ajcn/article/89/1/63/4596749>
- World Health Organization. (2023). Guideline on the prevention and control of anaemia in women and adolescents. World Health Organization.
- UNICEF. (2022). Adolescent nutrition: Global perspectives and strategies. UNICEF.
- Beal, T., Morris, S. S., & Tumilowicz, A. (2021). Global patterns of adolescent nutrition: Risk factors and opportunities. *The Lancet Child & Adolescent Health*, 5(8), 561–570. [https://doi.org/10.1016/S2352-4642\(21\)00105-5](https://doi.org/10.1016/S2352-4642(21)00105-5)
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Pedoman pencegahan dan penanggulangan anemia pada remaja putri. Kementerian Kesehatan RI.
- Cusick, S. E., & Georgieff, M. K. (2020). The role of nutrition in brain development: The golden opportunity of the first 1,000 days. *The Journal of Pediatrics*, 175, 16–21. <https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2016.05.013>
- Almatsier, S. (2019). *Prinsip dasar ilmu gizi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman pencegahan dan penanggulangan anemia pada remaja putri dan wanita usia subur*. Jakarta: Kemenkes RI.
- World Health Organization. (2011). *Haemoglobin concentrations for the diagnosis of anaemia and assessment of severity*. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2016). *Guideline: Daily iron supplementation in adult women and adolescent girls*. Geneva: WHO.
- UNICEF. (2019). *Adolescent nutrition: A review of the situation in low- and middle-income countries*. New York: UNICEF.
- Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. (2025). *National Forum for Healthy Living Transformation 2025*. <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/en/fornas-transformasi-hidup-sehat/> (BKPK Kemenkes)
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2025). *Dukung transformasi di sektor kesehatan, Menko Airlangga ajak semua pihak untuk*

ciptakan sistem kesehatan yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan.
<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5811/> (Ekon)

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). *Generasi sehat, masa depan hebat: Menkes tegaskan komitmen transformasi kesehatan menuju Indonesia Emas 2045.* <https://kemkes.go.id/id/generasi-sehat-masa-depan-hebat-menkes-tegaskan-komitmen-transformasi-kesehatan-menuju-indonesia-emas-2045> (Ministry of Health Indonesia)

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). *Pemerintah perkuat infrastruktur kesehatan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.* <https://www.kemkes.go.id/id/pemerintah-perkuat-infrastruktur-kesehatan-untuk-mewujudkan-visi-indonesia-emas-2045> (Ministry of Health Indonesia)

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). *Imunisasi, fondasi generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045.* <https://www.kemkes.go.id/eng/imunisasi-fondasi-generasi-sehat-menuju-indonesia-emas-2045> (Ministry of Health Indonesia)

J. Glosarium

1000 HPK (1000 Hari Pertama Kehidupan)

Periode sejak kehamilan hingga anak berusia 2 tahun yang sangat menentukan pertumbuhan, perkembangan otak, dan risiko stunting.

Absorpsi zat besi

Proses penyerapan zat besi di saluran cerna; dipengaruhi oleh vitamin C (meningkatkan) serta teh/kopi (menghambat).

Anemia

Kondisi kadar hemoglobin di bawah normal sehingga kemampuan darah mengangkut oksigen menurun; pada remaja putri paling sering karena kekurangan zat besi.

BMR (Basal Metabolic Rate)

Kebutuhan energi minimal tubuh saat istirahat; digunakan sebagai acuan kebutuhan energi dan status gizi.

Cakupan program

Proporsi sasaran yang menerima layanan/intervensi, misalnya cakupan konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri.

Defisiensi mikronutrien

Kekurangan zat gizi mikro seperti zat besi, vitamin B12, folat, vitamin D, dan zinc yang berdampak pada kesehatan dan perkembangan.

Edukasi gizi

Upaya meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku remaja agar mampu memenuhi kebutuhan gizi melalui pola makan seimbang dan kebiasaan sehat.

Gizi seimbang

Pola makan beragam dengan porsi dan frekuensi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi makro-mikro.

Indonesia Emas 2045

Visi jangka panjang menjadikan Indonesia negara maju pada tahun 2045; kualitas SDM sehat menjadi pilar utamanya.

Indonesia Sehat 2045

Agenda kesehatan nasional untuk mewujudkan penduduk hidup sehat sepanjang hayat, meningkatkan usia harapan hidup sehat, dan menurunkan kesakitan.

Interprofesional

Pendekatan kerja sama lintas profesi (dokter, perawat, bidan, ahli gizi, pendidik, dll.) untuk mencapai tujuan kesehatan secara terpadu.

omorbiditas

Kondisi penyakit lain yang menyertai; dapat memperburuk status gizi dan meningkatkan risiko anemia atau komplikasi kehamilan.

Komplikasi obstetri

Masalah kesehatan yang terjadi saat kehamilan/persalinan/nifas, misalnya perdarahan, preeklamsia, persalinan prematur.

Konsumsi zat besi heme

Zat besi dari sumber hewani (daging merah, hati, ikan) yang penyerapannya lebih baik dibanding non-heme.

CHAPTER 5

MANAJEMEN KASUS REMAJA DENGAN PERMASALAHAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (KRR)

Dewi Sari Rochmayani, S. Si.T, M.Kes (Epid).

A. Pendahuluan / Prolog

Remaja merupakan kelompok populasi yang sangat strategis dalam pembangunan kesehatan nasional. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk usia 10–19 tahun di Indonesia mencapai sekitar 45 juta jiwa atau hampir 17% dari total populasi. Besarnya proporsi ini menjadikan remaja sebagai penentu kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023).

Remaja merupakan kelompok usia yang berada pada fase transisi penting dari masa kanak-kanak menuju dewasa, yang ditandai dengan perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang signifikan. Pada periode ini, remaja mulai mengalami kematangan organ reproduksi, perkembangan identitas diri, serta peningkatan rasa ingin tahu dan eksplorasi terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan reproduksi. Kondisi tersebut menjadikan remaja sebagai kelompok yang rentan terhadap berbagai permasalahan kesehatan reproduksi apabila tidak didukung oleh pengetahuan, sikap, dan layanan kesehatan yang memadai (Rochmayani & Zulaekha, 2019; Sawyer et al., 2018).

Permasalahan kesehatan reproduksi remaja (KRR) masih menjadi isu kesehatan masyarakat yang serius di Indonesia. Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) menunjukkan bahwa angka kehamilan remaja (15–19 tahun) masih berada pada kisaran 36–48 per 1.000 perempuan. Selain itu, peningkatan kasus infeksi menular seksual (IMS), termasuk HIV/AIDS pada kelompok usia muda, rendahnya literasi kesehatan, serta norma sosial dan budaya yang menganggap isu reproduksi sebagai tabu memperburuk kondisi ini. Keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang ramah remaja mendorong perlunya penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada kesehatan remaja saat ini, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas kesehatan ibu dan anak di masa depan, sehingga memiliki implikasi jangka panjang terhadap pembangunan kesehatan nasional (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2017; Rossen et al., 2023).

Menyongsong Visi Indonesia Emas 2045 menekankan pentingnya sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing (Bappenas, 2019). Kesehatan reproduksi remaja menjadi fondasi penting karena gangguan pada fase ini dapat berdampak jangka panjang terhadap kualitas hidup, pendidikan, produktivitas, serta kesehatan ibu dan anak di masa depan. Remaja yang mengalami kehamilan tidak diinginkan, Infeksi Menular Seksual, atau kekerasan seksual berisiko mengalami putus sekolah, gangguan kesehatan mental, hingga kemiskinan antargenerasi (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2022). Oleh karena itu pendekatan komprehensif dan interprofesional dalam manajemen kasus kesehatan reproduksi remaja (KRR) merupakan kebutuhan mendesak guna memastikan terwujudnya generasi emas Indonesia tahun 2045 (Bosch & Mansell, 2015; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021; Pinandari et al., 2015).

B. Konsep Dasar Kesehatan Reproduksi Remaja

1. Definisi dan Ruang Lingkup

Kesehatan reproduksi menurut WHO yaitu suatu keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial yang utuh bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi dan prosesnya. Sedangkan kesehatan reproduksi remaja adalah suatu kondisi yang sehat yang menyangkut system, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja **(Fitria et al., n.d.)**

2. Tahapan perkembangan remaja

Masa remaja ditandai oleh perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang signifikan. Secara fisik, pubertas ditandai dengan pematangan organ reproduksi, munculnya karakteristik seksual sekunder, serta perubahan hormonal yang mempengaruhi emosi dan perilaku. Pada perempuan terjadi menarche, sedangkan pada laki-laki terjadi spermatarche.

Dari aspek psikologis, remaja mengalami pencarian identitas, peningkatan rasa ingin tahu, serta kecenderungan untuk bereksplorasi, termasuk dalam perilaku seksual. Ketidakseimbangan antara perkembangan kognitif dan kontrol emosi membuat remaja lebih rentan mengambil keputusan berisiko tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang **(Panghiyngani et al., 2021)**

3. Hak-Hak Kesehatan Reproduksi Remaja

Hak Reproduksi adalah hak semua pasangan dan individu (tanpa memandang perbedaan kelas sosial, suku, agama, dan lain-lain) untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab jumlah anak dan waktu kelahiran anak. Hak reproduksi didasarkan pada pengakuan hak asasi manusia,

sehingga penegakan hak reproduksi sama dengan penegakan hak asasi manusia (Direktorat Kesehatan Reproduksi, 2019). Berdasarkan ICPD 1994, terdapat 12 hak reproduksi, yakni:

- a. Hak mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi
- b. Hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi
- c. Hak untuk kebebasan berpikir dan membuat keputusan tentang kesehatan reproduksinya
- d. Hak untuk memutuskan jumlah anak dan jarak kelahiran anak
- e. Hak untuk hidup dan dilindungi dari risiko kematian karena kehamilan dan proses melahirkan
- f. Hak atas kebebasan dan keamanan dalam kehidupan reproduksi
- g. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk, termasuk perlindungan dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan, dan pelecehan seksual
- h. Hak mendapatkan manfaat dan kemajuan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan reproduksi
- i. Hak atas kerahasiaan pribadi dalam menjalankan kehidupan reproduksi
- j. Hak membangun dan merencanakan keluarga
- k. Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi
- l. Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam kehidupan

C. Permasalahan kesehatan reproduksi Remaja

1. Kehamilan yang tidak dikehendaki

Kehamilan yang tidak dikehendaki (Unwanted pregnancy) merupakan salah satu akibat dari kurangnya pengetahuan remaja mengenai perilaku seksual remaja. Faktor lain penyebab semakin banyaknya terjadi kasus kehamilan yang tidak dikehendaki yaitu anggapan-anggapan remaja yang keliru seperti kehamilan tidak akan terjadi apabila melakukan hubungan seks baru pertama kali, atau pada hubungan seks yang jarang dilakukan, atau hubungan seks dilakukan oleh perempuan masih muda usianya, atau bila hubungan seks dilakukan sebelum atau sesudah menstruasi, atau hubungan seks dilakukan dengan menggunakan teknik coitus interruptus (senggama terputus. Dari sudut kesehatan obstetri, hamil pada usia remaja dapat mengakibatkan resiko komplikasi pada ibu dan bayi antara lain yaitu terjadi perdarahan pada trimester pertama dan ketiga, anemia, preeklamsia, eklamsia, abortus, partus prematurus, kematian perinatal, berat bayi lahir rendah (BBLR) dan tindakan operatif obstetri (Lubis et al., 2024)

2. Aborsi

Aborsi atau pengguguran kandungan adalah terminasi (penghentian) kehamilan yang disengaja (abortus provocatus). Abortus provocatus yaitu kehamilan yang diprovokasi dengan berbagai macam cara sehingga terjadi pengguguran. Sedangkan keguguran adalah kehamilan berhenti karena faktor-faktor alamiah (abortus spontaneus). Data yang tersedia dari 1.000.000 aborsi sekitar 60,0% dilakukan oleh wanita yang tidak menikah, termasuk para remaja. Sekitar 70,0- 80,0% merupakan aborsi yang tidak aman (unsafe abortion). Aborsi tidak aman (unsafe abortion) merupakan salah satu faktor menyebabkan kematian ibu (Purwaningrum & Fibriana, 2017).

3. IMS dan HIV

a. IMS

Penyakit menular seksual merupakan suatu penyakit yang mengganggu kesehatan reproduksi yang muncul akibat dari perilaku seksual yang tidak aman. Remaja sering kali melakukan hubungan seks yang tidak aman, adanya kebiasaan berganti-ganti pasangan dan melakukan anal seks menyebabkan remaja semakin rentan untuk tertular Penyakit Menular Seksual, seperti Sifilis, Gonore, Herpes, Klamidia. Cara melakukan hubungan kelamin pada remaja tidak hanya sebatas pada genital-genital saja bisa juga orogenital menyebabkan penyakit kelamin tidak saja terbatas pada daerah genital, tetapi juga pada daerah-daerah ekstra genital. Faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya resiko penularan penyakit menular seksual (PMS) pada remaja adalah faktor biologi, faktor psikologis dan perkembangan kognitif, perilaku seksual, faktor legal dan etika dan pelayanan kesehatan khusus remaja (Anisa Putri Utami et al., 2025; Sani et al., 2016).

b. HIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immunodeficiency Syndrome)

AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) adalah suatu sindrom atau kumpulan gejala penyakit dengan karakteristik defisiensi kekebalan tubuh yang berat dan merupakan manifestasi stadium akhir infeksi virus "HIV". HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah retrovirus RNA tunggal yang menyebabkan AIDS (Limantara, dkk, 2004). Faktor yang berisiko menyebabkan HIV pada remaja adalah perubahan fisiologis, aktifitas sosial, infeksi menular seksual, perilaku penggunaan obat terlarang dan anak jalanan dan remaja yang lari dari rumah. Perubahan fisiologis yang dapat menjadi risiko penyebab infeksi dan perjalanan alamiah HIV meliputi perbedaan perkembangan sistem imun yang berhubungan dengan jumlah limfosit dan makrofag pada stadium

pubertas yang berbeda dan perubahan pada sistem reproduksi (Amelia et al., 2016; Oktavia et al., 2024).

D. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja

1. Definisi:

Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan kepada remaja dalam rangka menjaga kesehatan reproduksi (Kemenkes RI, 2015).

2. Tujuan

Mencegah dan melindungi remaja dari perilaku seksual berisiko dan perilaku berisiko lainnya yang dapat berpengaruh terhadap Kesehatan Reproduksi; dan mempersiapkan remaja untuk menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggung jawab (Kemenkes RI, 2015).

3. Fokus pelayanan

- a. Remaja di sekolah: sekolah umum, madrasah, pesantren, sekolah luar biasa
- b. Remaja di luar sekolah: karang taruna, saka bakti husada, palang merah remaja, panti yatim piatu/rehabilitasi, kelompok belajar mengajar, organisasi remaja, rumah singgah, kelompok keagamaan.
- c. Remaja putri sebagai calon ibu dan remaja hamil tanpa mempermasalahkan status pernikahan.
- d. Remaja yang rentan terhadap penularan HIV, remaja yang sudah terinfeksi HIV, remaja yang terkena dampak HIV dan AIDS, remaja yang menjadi yatim/piatu karena AIDS
- e. Remaja berkebutuhan khusus, yang meliputi kelompok remaja Korban kekerasan, korban trafficking, korban eksploitasi seksual; Penyandang cacat, di lembaga pemasyarakatan (LAPAS), anak jalanan, dan remaja pekerja Di daerah konflik (pengungsian), dan di daerah terpencil (Kementerian Kesehatan RI, 2014).

E. Upaya Kesehatan Sistem Reproduksi remaja

Upaya Kesehatan Sistem Reproduksi remaja mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif, rehabilitatif, dan paliatif.

1. Upaya Promotif

- a. dilaksanakan melalui pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, paling sedikit meliputi: sistem, fungsi, dan proses reproduksi; menjaga Kesehatan Reproduksi; perilaku seksual berisiko dan akibatnya; keluarga berencana; melindungi diri dan mampu menolak hubungan seksual; dan pemilihan media

hiburan sesuai usia anak menghargai diri sendiri dan orang lain tidak melakukan kekerasan seksual

- b. Sasaran: ditujukan kepada remaja, termasuk kepada orang tua/wali, dan guru
- c. Tujuannya: untuk menyiapkan remaja menjadi agen perubahan atau pelibatan remaja sebagai konselor sebaya dalam menjaga dan meningkatkan Kesehatan Reproduksi bagi anak usia sekolah dan remaja.
- d. Petugas: Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, konselor, konselor sebaya, guru, kader, dan tenaga lainnya yang memiliki kompetensi memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi Kesehatan Reproduksi melalui pendidikan dan/atau pelatihan. dibawah supervisi Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan.
- e. dapat diberikan melalui bahan ajar atau kegiatan belajar mengajar disekolah, Upaya Kesehatan sekolah, dan kegiatan lain di luar sekolah.
- f. Dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Posyandu; Satuan Pendidikan; dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
- g. dilaksanakan sesuai tahap perkembangan
- h. Dilaksanakan dengan pengembangan cara inovatif untuk Pelayanan Kesehatan Sistem Reproduksi remaja.

2. Upaya preventif dilaksanakan melalui:

- a. pemberian imunisasi tetanus difteri, human papilloma virus, dan imunisasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. deteksi dini penyakit atau skrining Kesehatan Reproduksi, termasuk skrining anemia;
- c. pemberian suplementasi gizi pada remaja putri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyediaan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya anak usia sekolah dan remaja agar tercipta perilaku dan interaksi yang sehat antara anak laki-laki dan perempuan yang memperhatikan kesetaraan gender dan sikap saling menghormati hak setiap individu;
- e. pemantauan sikap dan perilaku remaja yang terkait dengan Kesehatan Reproduksi, mencakup interaksi antara laki-laki dan perempuan atau sesama jenis, serta keselarasan dengan nilai dan norma yang berlaku baik di lingkungan sekolah, luar sekolah, maupun keluarga;
- f. tindak lanjut dengan pendekatan persuasif bila ditemukan sikap dan perilaku yang tidak selaras dengan nilai dan norma yang berlaku; dan
- g. penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja yang sudah menikah dengan usia istri di bawah 20 (dua puluh) tahun; tidak dilakukan di Satuan Pendidikan dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak; dan harus diberikan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan.

h. Dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Posyandu; Satuan Pendidikan; dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

3. Upaya kuratif dilaksanakan melalui tata laksana dan rujukan sesuai kondisi Kesehatan Reproduksi, meliputi

- a. pemberian pengobatan dan konseling Kesehatan Reproduksi bagi anak usia sekolah dan remaja yang mempunyai permasalahan Kesehatan Reproduksi.
- b. Konseling Kesehatan Reproduksi dilaksanakan dengan memperhatikan privasi dan kerahasiaan.
- c. dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dengan dibantu oleh Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan.

4. Upaya rehabilitatif

Dilaksanakan melalui pemberian pelayanan pemulihan kondisi akibat kelainan dan penyakit pada Sistem Reproduksi remaja. dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dengan dibantu oleh Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan.

5. Upaya paliatif

Dilaksanakan melalui pemberian pelayanan untuk memperbaiki kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi masalah kesehatan Sistem Reproduksi remaja dengan mencegah dan mengurangi penderitaan. dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dengan dibantu oleh Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan. di rumah atau rumah paliatif dengan melibatkan kader, keluarga, pekerja sosial, atau tenaga nonkesehatan lainnya (Kementerian Kesehatan RI, 2025).

F. Manajemen Kasus Remaja dengan Permasalahan Kesehatan Reproduksi (KRR)

1. Manajemen Pelayanan Kesehatan seksual pada remaja

Tujuannya agar setiap remaja dapat menjalani kehidupan seksual yang sehat meliputi: terbebas dari disfungsi dan gangguan orientasi seksual; dan terbebas dari kekerasan fisik dan mental, termasuk kekerasan seksual.

Bentuk pelayanan Kesehatan pada kasus disfungsi, kelainan genetik, dan kelainan seksual; Pelayanan Kesehatan pada korban kekerasan seksual; dan Pelayanan Kesehatan pada kasus infeksi menular seksual termasuk HIV.

a. Upaya Pelayanan promotif

dilaksanakan melalui edukasi dan konseling tentang:

- 1) perilaku seksual yang sehat dan aman, serta akibat perilaku berisiko meliputi: tidak melakukan hubungan seksual pada saat mengalami infeksi menular seksual; setia dengan pasangan atau tidak berganti-ganti pasangan; dan pencegahan penularan infeksi menular seksual termasuk HIV.
 - 2) pencegahan kekerasan seksual mampu menolak hubungan seksual yang tidak dikehendaki meliputi: melindungi diri dari kekerasan seksual; dan tidak melakukan kekerasan seksual
 - 3) edukasi dan konseling organ reproduksi
- b. Upaya Preventif
- Upaya preventif pada Pelayanan Kesehatan seksual untuk kasus infeksi menular seksual termasuk HIV dilaksanakan melalui: pemberian imunisasi, berupa imunisasi human papilloma virus dan imunisasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan deteksi dini penularan infeksi menular seksual;
- c. Upaya Kuratif
- Upaya kuratif pada Pelayanan Kesehatan seksual meliputi
- 1) tata laksana masalah kesehatan seksual, yaitu melakukan tata laksana infeksi menular seksual yang dilaksanakan sesuai dengan kasus kesehatan seksual.
 - 2) tata laksana terhadap korban kekerasan seksual, dilaksanakan melalui: pencegahan penularan dan pengobatan infeksi menular seksual termasuk HIV; konseling untuk pemulihan kesehatan kekerasan seksual; dan pemberian kontrasepsi darurat.
- d. Upaya rehabilitatif
- pada Pelayanan Kesehatan seksual meliputi tata laksana untuk memulihkan dari gangguan terhadap kondisi fisik dan jiwa, agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik sebagai individu, anggota keluarga, maupun masyarakat, yang ditujukan terhadap korban kekerasan seksual maupun pelaku kekerasan seksual, yang dilaksanakan melalui:
- 1) pemulihan kondisi fisik dan jiwa dari masalah kesehatan disfungsi seksual, kelainan genetik, kelainan bawaan, dan kelainan seksual lainnya;
 - 2) pemulihan kondisi fisik dan jiwa dari masalah kesehatan bagi korban dan pelaku kekerasan seksual; dan
 - 3) pemulihan kondisi fisik dan jiwa dari masalah penularan infeksi menular seksual termasuk HIV.

2. Manajemen Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Korban Tindak Pidana Perkosaan Atau Tindak Pidana Kekerasan Seksual Lain Yang Menyebabkan Kehamilan

Setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan, sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana

- a. Kehamilan akibat tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan dibuktikan dengan surat keterangan dokter dibuat oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan penunjang. atas usia kehamilan sesuai dengan kejadian tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan; dan keterangan penyidik mengenai adanya dugaan perkosaan dan/atau kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan.
- b. Pelayanan aborsi harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab dan diberikan oleh tim pertimbangan dan dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut yang telah ditetapkan untuk memberikan pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan membentuk tim pertimbangan
 - 2) Tim pertimbangan yang diketuai oleh komite medik Rumah Sakit dengan paling sedikit 1 (satu) anggota Tenaga Medis yang memiliki kompetensi dan kewenangan memberikan pertimbangan dan keputusan, dengan melakukan pemeriksaan sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
 - 3) tim pertimbangan membuat surat keterangan kelayakan aborsi.
 - 4) Dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang obstetri dan ginekologi (diluar tim pertimbangan namun jika di daerah tertentu tim pertimbangan tidak mencukupi diperbolehkan) dibantu oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan melakukan pelayanan aborsi
- c. persetujuan dapat dilakukan oleh keluarga yang sedarah maupun keluarga yang tidak sedarah dari korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan
- d. dapat dilakukan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut yang memenuhi sumber daya kesehatan sesuai standar yang ditetapkan oleh Menteri.

- e. Pelayanan aborsi hanya dapat dilakukan oleh Tenaga Medis dan dibantu oleh Tenaga Kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.
- f. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut yang menyelenggarakan pelayanan aborsi terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan ditetapkan oleh Menteri yang melibatkan dinas kesehatan daerah provinsi dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota setempat
- g. Dalam pelayanan aborsi harus diberikan pendampingan dan konseling sebelum dan setelah aborsi, yang dilakukan oleh Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan/atau tenaga lainnya meliputi:
 - 1) pertimbangan indikasi yang mendasari keputusan untuk dilakukan aborsi;
 - 2) alternatif pilihan dukungan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan kehamilan;
 - 3) penjelasan tentang prosedur informasi yang jelas tentang berbagai metode aborsi yang tersedia, termasuk prosedur, durasi, dan potensi risiko serta efek samping dari masing-masing metode;
 - 4) menjelaskan risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi selama dan setelah aborsi, termasuk risiko fisik dan potensi dampak psikologis;
 - 5) memberikan informasi tentang perawatan pascaaborsi, termasuk tanda komplikasi;
 - 6) memastikan bahwa pasien dan/atau korban memahami semua informasi yang diberikan dan memberikan persetujuan sebelum dilakukan tindakan aborsi;
 - 7) menjamin kerahasiaan dan melindungi informasi pribadi pasien;
 - 8) mengobservasi dan mengevaluasi kondisi pasien setelah tindakan aborsi;
 - 9) membantu pasien memahami keadaan atau kondisi fisik setelah menjalani tindakan aborsi; dan
 - 10) menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakan rujukan bila diperlukan.
- h. Dalam hal korban tindak pidana perkosaan dan/atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan memutuskan untuk membatalkan keinginan melakukan aborsi setelah mendapatkan pendampingan dan konseling, korban diberikan pendampingan oleh konselor selama masa kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan.
- i. berdasarkan hasil konseling sebelum aborsi dinyatakan bahwa korban yang hamil telah siap menjalani aborsi, tenaga medis, tenaga kesehatan, dan atau tenaga lainnya harus memberikan surat keterangan konseling kepada korban tersebut.

G. Pendekatan Interprofesional dalam Penanganan KRR

Pendekatan interprofesional merupakan keterlibatan beberapa profesi tenaga kesehatan serta memberikan pelayanan secara menyeluruh bio-psiko-sosial dan kultural, saling bekerjasama dengan pasien, keluarga, kelompok dan masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas disemua tatanan (Bosch & Mansell, 2015; Gilbert et al., 2010). Jadi Interprofesional dalam Penanganan KRR merupakan praktik kolaboratif di mana berbagai tenaga kesehatan bekerja sama sebagai tim yang terintegrasi untuk memberikan asuhan yang holistik bagi remaja. Dalam manajemen Permasalahan Kesehatan Reproduksi (KRR), pendekatan ini melampaui sekadar perawatan medis; ia mencakup aspek psikologis, nutrisi, dan dukungan sosial guna mencapai target Indonesia Sehat 2045 (Bappenas, 2019).

Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan kualitas layanan kesehatan, memperkuat sistem kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan, baik dalam perawatan akut dan primer, peningkatan tingkat kepuasan pada pasien, penerimaan perawatan yang lebih baik dan peningkatan derajat kesehatan yang dilakukan oleh tim kolaboratif (World Health Professions Alliance, 2023).

Penelitian mengungkapkan bahwa kolaborasi antar profesional dapat meningkatkan hasil yang baik pada proses pelayanan kesehatan pasien. Petugas kesehatan yang bermitra dalam satu tim kolaborasi dapat meningkatkan pandangan pasien terhadap pelayanan yang diberikan dari komunikasi yang efektif termasuk mendengarkan dan didorong, perasaan memahami dan memahami mengapa mereka memiliki rasa sakit. Profesional kesehatan yang lebih peduli agar tujuan bersama bisa dicapai dengan membangun saling pengertian dalam perawatan dan pengobatan pasien yang dilakukan secara bersama-sama (Bosch & Mansell, 2015; Gilbert et al., 2010).

1. Peran kolaboratif antar tenaga kesehatan

- a. Dokter: Bertanggung jawab dalam diagnosis klinis, penatalaksanaan medis (seperti pengobatan IMS), serta memimpin koordinasi tim kesehatan.
- b. Perawat: Berperan dalam koordinasi layanan, pemantauan kondisi pasien, serta memberikan edukasi kesehatan reproduksi kepada remaja dan keluarga.
- c. Bidan: Fokus pada asuhan kesehatan reproduksi yang berkelanjutan, deteksi dini komplikasi, serta manajemen kehamilan pada remaja dengan pendekatan yang ramah remaja (Youth-Friendly).
- d. Psikolog: Menangani dampak psikososial, trauma (akibat kekerasan seksual), serta memberikan layanan konseling untuk perubahan perilaku berisiko.
- e. Tenaga Kesejahteraan Sosial: Berperan dalam memfasilitasi dukungan lingkungan, menangani aspek legal pada kasus kekerasan, serta memastikan perlindungan sosial bagi remaja.

- f. Ahli Gizi: Memberikan edukasi dan intervensi gizi yang spesifik, terutama pada kasus kehamilan remaja atau gangguan siklus menstruasi akibat masalah nutrisi.
- g. Skrining Awal (Tim Puskesmas/Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)): Melakukan penilaian komprehensif menggunakan instrumen HEADSS (Home, Education, Activity, Drugs, Sexuality, Suicide/Safety).
- h. Penatalaksanaan Kuratif (Dokter & Bidan/Perawat): Penanganan infeksi menular seksual (IMS), HIV, dan gangguan menstruasi sesuai pedoman nasional. Peran bidan sangat krusial dalam asuhan berkelanjutan bagi korban kekerasan seksual dan kehamilan remaja.
- i. Intervensi Psikosial (Psikolog Klinis & Pekerja Sosial): Memberikan konseling untuk trauma, pencegahan perilaku seksual berisiko, dan dukungan lingkungan agar remaja tetap terlindungi dari stigma.
- j. Rehabilitatif (Tim Multidisiplin): Memulihkan kondisi fisik dan jiwa agar remaja dapat kembali ke fungsi sosialnya secara wajar, termasuk perlindungan terhadap pelaku atau korban kekerasan.

2. Alur rujukan

Sistem rujukan dalam manajemen KRR harus bersifat "terpadu" (Integrated Referral System) untuk menjamin kesinambungan layanan.

- a. Tingkat Primer (Puskesmas/PKPR): Melakukan skrining awal (menggunakan instrumen seperti HEADSS), penanganan kasus sederhana, dan konseling dasar.
- b. Rujukan Horizontal: Kolaborasi antar unit di dalam satu fasilitas kesehatan (misal: rujukan dari poli umum ke poli psikologi atau gizi).
- c. Rujukan Vertikal: Kasus kompleks seperti kehamilan risiko tinggi, komplikasi IMS berat, atau trauma seksual berat dirujuk ke Rumah Sakit (Faskes Tingkat Lanjut) yang memiliki tim ahli multidisiplin.
- d. Prinsip One-Stop Service: Mengupayakan agar remaja mendapatkan berbagai layanan yang dibutuhkan dalam satu alur terpadu guna meminimalisir risiko remaja "putus" layanan karena proses birokrasi yang rumit.

Mulai awal 2026, Indonesia menerapkan Sistem Rujukan JKN Berbasis Kompetensi. Sistem ini menggantikan rujukan berjenjang yang kaku menjadi lebih fleksibel dan terintegrasi:

- a. Rujukan Langsung Sesuai Kebutuhan: Jika kasus KRR bersifat kompleks (misalnya butuh bedah reproduksi atau penanganan HIV stadium lanjut), pasien dapat langsung dirujuk ke rumah sakit dengan kompetensi yang sesuai tanpa harus melewati jenjang administratif yang berlapis-lapis.

- b. Digitalisasi Melalui SATUSEHAT: Rekam medis remaja terintegrasi secara digital, memastikan informasi klinis berpindah secara aman dari faskes primer ke rujukan, menjaga prinsip kerahasiaan (confidentiality) tetap terjaga.
- c. Pendekatan Kedokteran Keluarga: Memastikan rujukan tidak hanya medis, tetapi juga melibatkan sekolah dan komunitas untuk pemulihan jangka panjang (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021).

H. Konseling dan Edukasi Berbasis Hak Remaja

Konseling pada remaja bukan sekadar pemberian saran, melainkan sebuah proses dialogis yang menghargai hak-hak dasar remaja. Pendekatan berbasis hak (Rights-Based Approach) menekankan bahwa setiap remaja berhak atas informasi kesehatan reproduksi yang akurat, tidak bias, dan komprehensif tanpa diskriminasi. Edukasi harus mencakup pengenalan sistem reproduksi, pencegahan kekerasan seksual, hingga pemahaman mengenai kesetaraan gender. Tujuannya adalah memberdayakan remaja agar mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab atas kesehatan dan tubuh mereka sendiri (*Informed Choice*)

I. Teknik komunikasi efektif

Pelayanan kesehatan ramah remaja (Youth-Friendly Services) memerlukan keterampilan komunikasi khusus yang berpusat pada klien. Teknik utama meliputi:

1. Mendengarkan dengan Empati: Petugas kesehatan harus fokus sepenuhnya tanpa menyela atau menghakimi perilaku remaja.
2. Penggunaan Pertanyaan Terbuka: Mendorong remaja untuk bercerita lebih banyak tentang pengalaman dan perasaan mereka, bukan sekadar jawaban "ya" atau "tidak".
3. Prinsip REACH: Meliputi Respect (menghargai), Empathy (empati), Audible (dapat didengar/dimengerti), Clarity (jelas), dan Humble (rendah hati).
4. Lingkungan yang Mendukung: Selain verbal, keramahan juga ditunjukkan melalui lingkungan fisik yang nyaman, privat, dan tidak mengintimidasi (misal: "Pojok PKPR") (Kementerian Kesehatan RI, 2014).

J. Prinsip dan pendekatan Pelayanan Kesehatan Remaja

Prinsip privasi dan kerahasiaan (confidentiality) merupakan elemen kunci dalam pelayanan kesehatan remaja. Banyak remaja enggan mengakses layanan KRR karena takut dihakimi, dilaporkan kepada orang tua, atau distigmatisasi oleh tenaga kesehatan. Pelayanan yang tidak menjamin kerahasiaan berpotensi memperburuk

masalah dan mendorong remaja mencari informasi dari sumber yang tidak terpercaya.

Pendekatan berbasis hak remaja menekankan bahwa setiap remaja berhak memperoleh layanan kesehatan yang aman, rahasia, dan menghormati otonomi mereka, sesuai dengan regulasi dan etika profesi kesehatan (Denno et al., 2015; Kementerian Kesehatan RI, 2014; Miswanto, 2014; UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, 2023).

K. Simpulan

Manajemen kasus kesehatan reproduksi remaja (KRR) di Indonesia memerlukan transformasi pendekatan dari layanan medis konvensional menuju sistem yang holistik, inklusif, dan ramah remaja. Sebagai bagian integral dari visi Indonesia Sehat 2045, penanganan kasus seperti IMS, HIV/AIDS, kehamilan tidak diinginkan (KTD), aborsi tidak lagi dapat dilakukan secara parsial oleh satu profesi saja.

Keberhasilan manajemen klinis ini bertumpu pada tiga pilar utama:

1. Kolaborasi Interprofesional (IPC): Sinergi antara dokter, perawat, bidan, psikolog, ahli gizi, dan pekerja sosial memastikan setiap dimensi permasalahan remaja baik fisik, psikis, maupun sosial mendapatkan intervensi yang tepat secara simultan.
2. Sistem Rujukan Terintegrasi: Pemanfaatan teknologi digital melalui platform SATUSEHAT dan penerapan rujukan berbasis kompetensi medis di tahun 2026 memungkinkan remaja mendapatkan akses layanan spesialisik dengan cepat, aman, dan terjaga kerahasiaannya.
3. Etika dan Hak Remaja: Penegakan prinsip kerahasiaan (confidentiality) dan persetujuan tindakan (informed consent) yang ramah remaja menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan (trust) antara remaja dan tenaga kesehatan.

Dengan mengintegrasikan standar klinis terbaru sesuai Permenkes No. 2 Tahun 2025 dan pendekatan yang humanis, manajemen KRR diharapkan mampu mencetak generasi muda yang sehat secara reproduksi, tangguh secara mental, dan siap menjadi motor penggerak Indonesia Emas 2045.

(Keputusan Menteri Kesehatan tentang MTPKR 2024; Permenkes Nomor 2 Tahun 2025; Visi Indonesia Emas 2045 – Bappenas)

L. Referensi

- Amelia, M., Hadisaputro, S., Laksono, B., Anies, & Sufro, M. A. (2016). Faktor Risiko yang Berpengaruh Terhadap Kejadian HIV/AIDS. *Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas*, 1(1), 39–46.
- Anisa Putri Utami, Ika Restu Kaeksi, Nisa Wahyuningsih, & Liss Dyah Dewi Arini. (2025). Infeksi Menular Seksual. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Kesehatan*, 3(1), 208–215. <https://doi.org/10.59841/jumkes.v3i1.2323>
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2017). *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017*.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023. *Badan Pusat Statistik*, 57, 1–8. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>
- Bappenas. (2019). Visi Indonesia 2045 Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur. In *Sistem Manajemen Pengetahuan* (Vol. 32).
- Bosch, B., & Mansell, H. (2015). Interprofessional collaboration in health care: Lessons to be learned from competitive sports. *Canadian Pharmacists Journal*, 148(4), 176–179. <https://doi.org/10.1177/1715163515588106>
- Denno, D. M., Hoopes, A. J., & Chandra-Mouli, V. (2015). Effective strategies to provide adolescent sexual and reproductive health services and to increase demand and community support. *Journal of Adolescent Health*, 56(1), S22–S41. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2014.09.012>
- Direktorat Kesehatan Reproduksi. (2019). *Mari Mengenal Hak-hak Reproduksi dalam Keluarga Berencana*. 1–45.
- Fitria, K. I. P. S., Virgia, V., & Fitria, L. (n.d.). *Kesehatan Reproduksi Remaja*.
- Gilbert, J. H. V., Yan, J., & Hoffman, S. J. (2010). A WHO report: Framework for action on interprofessional education and collaborative practice. *Journal of Allied Health*, 39(SUPPL. 1), 196–197.
- Kemenkes RI. (2015). PP No.61 Tahun 2015. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Kesehatan Reproduksi*, 61, 1–55.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Modul Kesehatan Reproduksi Remaja Luar Sekolah*.

- Kementerian Kesehatan RI. (2014). Pedoman Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja. In *Kemenkes RI*.
- Kementerian Kesehatan RI. (2025). *Permenkes No 2 Tahun 2025*. 6. <https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000174493.html>
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2022). *Rencana Aksi Nasional Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja* (Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022). <https://lib.unnes.ac.id/20002/>
- Lubis, P. N., Gayatri, M., Lubis, P. N., Djuwita, R., & Adisasmita, A. C. (2024). *Determinant of Unintended Pregnancy in Indonesia*. 28(1). <https://doi.org/10.7454/msk.v28i1.1592>
- Miswanto. (2014). Pentingnya Pendidikan dan Seksualitas pada Remaja. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(2), 111–122.
- Oktavia, M., Firdawati, F., & Irfandy, D. (2024). Gambaran Faktor Risiko Penularan HIV/AIDS pada Kelompok Lelaki Seks Lelaki di Kota Bukittinggi. *Jurnal Ilmu Kesehatan Indonesia*, 5(3), 204–212. <https://doi.org/10.25077/jikesi.v5i3.933>
- Panghiyangani, A. N., Ilmi, B., Istiqomah, E., Shadiqi, M. A., Noor, M. S., & Panghiyangani, R. (2021). *Buku Ajar Perilaku dan Psikologi Kesehatan Reproduksi*.
- UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, (2023).
- Pinandari, A. W., Wilopo, S. A., & Ismail, D. (2015). Pendidikan Kesehatan Reproduksi Formal dan Hubungan Seksual Pranikah Remaja Indonesia. *Kesmas: National Public Health Journal*, 10(1), 44. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v10i1.817>
- Purwaningrum, E. D., & Fibriana, A. I. (2017). *Faktor Risiko Kejadian Abortus Spontan*. 1(3), 84–94.
- Rochmayani, D. S., & Zulaekha, C. (2019). Journal of Health Education. *Journal of Health Education*, 4(1), 43–52. <https://doi.org/10.1080/10556699.1994.10603001>
- Rossen, L. M., Hamilton, B. E., Abma, J. C., Gregory, E. C. W., Beresovsky, V., Resendez, A. V., Chandra, A., & Martin, J. A. (2023). Updated Methodology to Estimate Overall and Unintended Pregnancy Rates in the United States: Data Evaluation and Methods Research. *Vital and Health Statistics, Series 2: Data Evaluation*

and Methods Research, 2023(201), 1–29. <https://doi.org/10.15620/cdc:124395>

Sani, A. S., Abraham, C., Denford, S., & Ball, S. (2016). School-based sexual health education interventions to prevent STI/HIV in sub-Saharan Africa: a systematic review and meta-analysis. *BMC Public Health*, 16(1), 1–26. <https://doi.org/10.1186/s12889-016-3715-4>

Sawyer, S. M., Azzopardi, P. S., Wickremarathne, D., & Patton, G. C. (2018). The age of adolescence. *The Lancet Child and Adolescent Health*, 2(3), 223–228. [https://doi.org/10.1016/S2352-4642\(18\)30022-1](https://doi.org/10.1016/S2352-4642(18)30022-1)

World Health Professions Alliance. (2023). Interprofessional collaborative practice. In *Encyclopedia of Macro Social Work* (Vols. 2–3, Issue 1). <https://doi.org/10.1079/9781789242690.0095>

M. Glosarium

KRR = Kesehatan Reproduksi remaja

PKPR = Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja

CHAPTER 6

PENGUATAN PERAN KELUARGA DAN KOMUNITAS SEBAGAI MITRA TENAGA KESEHATAN

Ns. Indra Tri Astuti, M.Kep., Sp.Kep.An.

A. Pendahuluan / Prolog

Sistem kesehatan global, termasuk di Indonesia, menghadapi tantangan multidimensi yang memerlukan pendekatan transformatif (World Health Organization [WHO], 2021). Masalah utama yang mengemuka adalah beban ganda penyakit (*double burden of disease*), di mana penyakit menular seperti tuberkulosis masih menjadi ancaman, sementara penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi mengalami peningkatan yang signifikan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia [Kemenkes RI], 2023).

Data Kementerian Kesehatan RI (2023) menunjukkan bahwa lebih dari 70% kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit tidak menular, dengan faktor risiko utama seperti kurang aktivitas fisik, konsumsi gula-garam-lemak berlebih, dan merokok banyak dipengaruhi oleh pola perilaku dalam keluarga dan lingkungan komunitas (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan [Balitbangkes], 2022). Di sisi lain, keterbatasan sumber daya tenaga kesehatan dengan rasio dokter terhadap populasi yang masih sekitar 0,4 per 1000 penduduk menciptakan kesenjangan akses dan beban kerja yang berlebihan bagi profesional kesehatan (Ikatan Dokter Indonesia [IDI], 2022; WHO, 2020). Permasalahan ini semakin kompleks dengan rendahnya kapasitas keluarga dalam memberikan perawatan lanjutan dan minimnya partisipasi komunitas dalam sistem surveilans kesehatan, mengakibatkan banyak kasus yang terdeteksi pada stadium lanjut dengan biaya penanganan yang tinggi (Mahendradhata et al., 2021; Trisnantoro et al., 2020).

Perkembangan masalah ini menunjukkan pola yang konsisten. Selama beberapa dekade, pendekatan kesehatan di Indonesia masih sangat terpusat pada fasilitas kesehatan (*provider-centered*), di mana keluarga dan komunitas seringkali hanya diposisikan sebagai penerima pasif layanan (Rokx et al., 2019). Program kesehatan seperti Posyandu dan Posbindu, meski telah berjalan, belum sepenuhnya memberdayakan komunitas sebagai mitra setara dalam pengambilan keputusan (Dartanto et al., 2020). Pandemi COVID-19 menjadi titik balik yang memperjelas urgensi perubahan paradigma ini, di mana keterlibatan aktif kader kesehatan, kelompok masyarakat, dan keluarga dalam tracing, isolasi mandiri, dan vaksinasi terbukti menjadi faktor penentu keberhasilan penanganan krisis (Suryanto et al., 2022; WHO, 2022). Namun, pascapandemi, kolaborasi ini seringkali tidak diubah

menjadi kebijakan resmi, prosedur tetap, atau program berkelanjutan yang didukung oleh anggaran, struktur, dan aturan formal menjadi model kemitraan yang berkelanjutan (Thabrany et al., 2023).

Solusi yang kini dianggap paling strategis adalah dengan memperkuat kemitraan yang setara dan saling menghormati antara tenaga kesehatan, keluarga, dan komunitas (American Academy of Family Physicians [AAFP], 2019). Pendekatan ini, yang sering disebut sebagai *community-oriented primary care*, tidak hanya bertujuan untuk meringankan beban tenaga kesehatan, tetapi terutama untuk membangun sistem kesehatan yang lebih tangguh, preventif, dan berpusat pada masyarakat (WHO, 2018). Keluarga, sebagai unit terkecil, perlu dilatih menjadi *first responder* dan pengelola kesehatan dasar, sementara komunitas dapat difungsikan sebagai *extended health system* yang melakukan promosi, pencegahan, dan deteksi dini berbasis kearifan lokal (Wright & Leahey, 2019; Kemenkes RI, 2021). Implementasi solusi ini memerlukan kerangka kebijakan yang mendukung, alokasi sumber daya yang memadai untuk pelatihan, dan transformasi mindset dari semua pihak dari tenaga kesehatan yang membuka ruang kolaborasi hingga masyarakat yang memiliki literasi kesehatan dan rasa kepemilikan terhadap program kesehatan di lingkungannya (Smith & Johnson, 2020; Yulia & Prasetyo, 2022). Dengan demikian, penguatan peran keluarga dan komunitas bukan sekadar pelengkap, melainkan pondasi utama untuk mencapai cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage) yang berkelanjutan dan berkeadilan (WHO, 2020; Kemenkes RI, 2021).

B. Konsep Kemitraan dalam Pelayanan Kesehatan: Pendekatan Berbasis Kesetaraan dan Kolaborasi

1. Definisi dan Prinsip Dasar

Konsep kemitraan dalam pelayanan kesehatan didefinisikan sebagai hubungan kolaboratif yang dibangun atas dasar kesetaraan, saling menghormati, dan berbagi tanggung jawab antara tenaga kesehatan, pasien, keluarga, dan komunitas untuk mencapai tujuan kesehatan bersama (World Health Organization [WHO], 2018). Kemitraan ini berbeda dari pendekatan tradisional yang hierarkis, di mana tenaga kesehatan berperan sebagai pemberi arahan satu arah, sementara pasien dan keluarga hanya sebagai penerima pasif (Institute of Medicine [IOM], 2015). Prinsip dasar kemitraan mencakup kesetaraan dalam pengambilan keputusan, pengakuan terhadap keahlian dan pengalaman hidup masing-masing pihak, serta komitmen untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang disepakati bersama (American Academy of Family Physicians [AAFP], 2019). Pendekatan ini merepresentasikan pergeseran paradigma dari model paternalistik menuju model partisipatif yang memberdayakan semua pemangku kepentingan dalam ekosistem kesehatan (Wright & Leahey, 2019). Dalam konteks

Indonesia, kemitraan ini selaras dengan filosofi gotong royong dan prinsip Trias UKS (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) yang menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan kesehatan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia [Kemenkes RI], 2021).

2. Dimensi dan Tingkatan Kemitraan

Kemitraan dalam pelayanan kesehatan beroperasi pada beberapa tingkatan yang saling berhubungan, mulai dari tingkat mikro individu hingga tingkat makro sistem (Smith & Johnson, 2020). Pada tingkat individu, kemitraan terjadi antara tenaga kesehatan dengan pasien dan keluarganya dalam pengambilan keputusan klinis, di mana pertukaran informasi dua arah dan pertimbangan nilai-nilai pasien menjadi sentral (Barry & Edgman-Levitan, 2012). Pada tingkat komunitas, kemitraan melibatkan organisasi masyarakat, tokoh adat, dan kelompok dukungan dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program kesehatan yang sesuai dengan konteks lokal (WHO, 2018). Pada tingkat sistem, kemitraan tercermin dalam kebijakan kesehatan yang partisipatif dan alokasi sumber daya yang melibatkan perwakilan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (Trisnantoro et al., 2020). Setiap tingkat kemitraan ini memerlukan mekanisme komunikasi, alokasi wewenang, dan sistem akuntabilitas yang jelas untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas kolaborasi (Mahendradhata et al., 2021). Kemitraan yang efektif bersifat dinamis dan kontekstual, menyesuaikan dengan kebutuhan, kapasitas, dan budaya setempat (Yulia & Prasetyo, 2022).

3. Kerangka Teoretis dan Model Implementasi

Beberapa kerangka teoretis mendasari konsep kemitraan kesehatan, termasuk Community Oriented Primary Care (COPC) yang mengintegrasikan klinik dengan kesehatan masyarakat melalui keterlibatan komunitas (Mullan & Epstein, 2002). Model Family Centered Care menempatkan keluarga sebagai pusat perencanaan perawatan, dengan prinsip menghormati perbedaan keluarga, fleksibilitas layanan, dan berbagi informasi secara terbuka (AAFP, 2019). Pendekatan Community Based Participatory Research (CBPR) melibatkan komunitas sebagai mitra penuh dalam seluruh siklus penelitian, dari identifikasi masalah hingga diseminasi hasil, sehingga memastikan relevansi dan keberterimaan intervensi (Israel et al., 2018). Model Integrated Community Case Management (iCCM) memanfaatkan pekerja kesehatan komunitas terlatih untuk memperluas akses pengobatan penyakit umum di daerah dengan keterbatasan tenaga kesehatan formal (WHO, 2020). Di Indonesia, model Desa Siaga dan Posyandu Plus merupakan manifestasi praktis dari konsep kemitraan ini, di mana masyarakat berperan aktif dalam surveilans kesehatan, promosi, dan deteksi dini (Kemenkes RI, 2021). Implementasi model-model ini memerlukan pelatihan untuk membangun kompetensi komunikasi, negosiasi, dan fasilitasi bagi tenaga

kesehatan, serta peningkatan literasi kesehatan dan kapasitas advokasi bagi perwakilan masyarakat (Zahara & Santoso, 2021).

4. Komponen Esensial Kemitraan yang Efektif

Kemitraan yang efektif dalam pelayanan kesehatan dibangun atas beberapa komponen esensial yang saling memperkuat. Pertama, komunikasi terbuka dan transparan yang memungkinkan pertukaran informasi, kekhawatiran, dan harapan secara jujur antara semua pihak (Barry & Edgman-Levitan, 2012). Kedua, kepercayaan dan rasa saling menghormati yang mengakui keahlian unik yang dibawa oleh masing-masing mitra, baik keahlian klinis tenaga kesehatan maupun keahlian kontekstual dan pengalaman hidup pasien dan komunitas (Wright & Leahey, 2019). Ketiga, pembagian kekuasaan dan tanggung jawab yang jelas, di mana keputusan dibagi sesuai dengan kapasitas dan peran masing-masing pihak (IOM, 2015). Keempat, komitmen jangka panjang yang diwujudkan melalui investasi berkelanjutan dalam pengembangan kapasitas dan penguatan hubungan (WHO, 2018). Kelima, sistem dukungan dan pengakuan yang memberikan insentif dan apresiasi terhadap kontribusi semua mitra, termasuk tenaga kesehatan relawan dan kader masyarakat (Kemenkes RI, 2021). Keenam, mekanisme evaluasi dan umpan balik bersama yang memungkinkan perbaikan berkelanjutan terhadap kemitraan (Smith & Johnson, 2020). Komponen-komponen ini harus didukung oleh kebijakan, alokasi sumber daya, dan budaya organisasi yang kondusif di tingkat fasilitas kesehatan dan sistem kesehatan secara keseluruhan (Trisnantoro et al., 2020).

5. Manfaat dan Bukti Efektivitas

Implementasi kemitraan yang autentik dalam pelayanan kesehatan menghasilkan berbagai manfaat yang didokumentasikan dengan baik dalam literatur. Dari perspektif klinis, kemitraan meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan, hasil kesehatan yang lebih baik, dan kepuasan pasien karena perawatan menjadi lebih sesuai dengan nilai dan konteks kehidupan pasien (Barry & Edgman-Levitan, 2012). Dari perspektif sistem, kemitraan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dengan mencegah duplikasi layanan dan memanfaatkan aset yang sudah ada di komunitas (World Bank, 2020). Dari perspektif komunitas, kemitraan memperkuat rasa memiliki dan pemberdayaan, yang pada gilirannya meningkatkan keberlanjutan program kesehatan (WHO, 2018). Bukti dari Indonesia menunjukkan bahwa desa dengan kemitraan aktif antara puskesmas dan masyarakat memiliki angka kematian ibu dan bayi yang lebih rendah serta cakupan imunisasi yang lebih tinggi (Kemenkes RI, 2021). Selama pandemi COVID-19, kemitraan dengan tokoh agama dan adat terbukti meningkatkan penerimaan vaksinasi dan kepatuhan protokol kesehatan di berbagai daerah (Thabrany et al., 2023). Secara ekonomi, analisis menunjukkan bahwa investasi dalam pemberdayaan kader kesehatan masyarakat menghasilkan

return on investment (ROI) yang positif melalui pencegahan penyakit dan penurunan beban biaya kesehatan (Bappenas, 2020).

6. Tantangan dan Strategi Implementasi

Meskipun memiliki bukti manfaat yang kuat, implementasi kemitraan dalam pelayanan kesehatan menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Asimetri informasi dan kekuasaan yang masih besar antara tenaga kesehatan dan masyarakat sering menjadi penghambat utama untuk kemitraan yang setara (IOM, 2015). Budaya paternalistik dalam praktik kedokteran dan kepatuhan hierarkis dalam masyarakat dapat mengurangi ruang bagi partisipasi aktif pasien dan keluarga (Wright & Leahey, 2019). Keterbatasan waktu dan sumber daya di fasilitas kesehatan yang padat sering menjadi alasan untuk kembali ke pendekatan yang lebih direktif (Mahendradhata et al., 2021). Di tingkat sistem, kurangnya kerangka kebijakan dan regulasi yang secara eksplisit mendukung dan mengatur kemitraan membatasi implementasi yang konsisten (Trisnantoro et al., 2020). Strategi untuk mengatasi tantangan ini meliputi: pelatihan transformatif bagi tenaga kesehatan dalam komunikasi partisipatif dan humility budaya; penguatan kapasitas masyarakat dalam literasi kesehatan dan advokasi; pengembangan alat bantu seperti decision aids dan panduan partisipasi keluarga; reformasi kebijakan yang mengalokasikan waktu dan insentif untuk praktik kemitraan; serta penelitian partisipatif untuk terus menghasilkan bukti kontekstual tentang model kemitraan yang efektif (WHO, 2018; Kemenkes RI, 2021; Yulia & Prasetyo, 2022). Kesuksesan implementasi memerlukan komitmen jangka panjang dan pendekatan bertahap yang dimulai dari proyek percontohan dan kemudian diperluas dengan adaptasi kontekstual.

C. Bentuk-Bentuk Penguatan Peran Keluarga sebagai Mitra Tenaga Kesehatan

1. Pendidikan dan Literasi Kesehatan Keluarga

Program pendidikan kesehatan terstruktur yang diberikan kepada keluarga terbukti meningkatkan kapasitas mereka dalam mendeteksi dini masalah kesehatan dan melakukan tindakan pertama yang tepat (Wright & Leahey, 2019). Bentuk konkretnya mencakup kelas ibu hamil dan kelas parenting yang tidak hanya menasar ibu, tetapi juga melibatkan ayah dan anggota keluarga lain untuk membangun sistem dukungan yang komprehensif (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia [Kemenkes RI], 2021). Pelatihan keterampilan perawatan dasar seperti mengukur tekanan darah, memantau gula darah mandiri, memberikan inhalasi, atau perawatan luka sederhana memberdayakan keluarga untuk mengelola kondisi kronis di rumah (Zahara & Santoso, 2021). Peningkatan literasi kesehatan digital juga menjadi bentuk penguatan krusial, di mana keluarga diajarkan untuk mengakses informasi kesehatan yang kredibel, menggunakan aplikasi pencatatan kesehatan, dan berkomunikasi virtual dengan tenaga

kesehatan (Smith & Johnson, 2020). Kampanye komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang dikemas sesuai budaya lokal, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dan melibatkan tokoh keluarga sebagai influencer, efektif dalam mengubah norma dan perilaku sehat di tingkat rumah tangga (World Health Organization [WHO], 2018).

2. Integrasi Keluarga dalam Proses Asuhan Klinis (Family Centered Care)

Penguatan peran keluarga dimulai dengan mengadopsi model Family Centered Care (FCC) dalam praktik klinis sehari-hari, di mana keluarga dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap asuhan (American Academy of Family Physicians [AAFP], 2019). Pada tahap assesmen, tenaga kesehatan melakukan pengkajian yang holistik dengan menggali informasi tentang dinamika keluarga, sumber daya, dan dukungan yang tersedia di rumah (Wright & Leahey, 2019). Dalam proses pengambilan keputusan bersama (shared decision making), keluarga diberikan informasi yang lengkap, jelas, dan imparial, lalu didorong untuk menyampaikan nilai-nilai, preferensi, dan pertimbangan praktis mereka sebelum menentukan rencana perawatan (Barry & Edgman-Levitan, 2012). Selama perawatan di fasilitas kesehatan, keluarga diberikan akses fleksibel untuk menemani pasien, didorong untuk berpartisipasi dalam perawatan dasar sesuai kemampuan, dan dijembatani untuk berkomunikasi dengan tim klinis (Kemenkes RI, 2021). Peran keluarga juga diakui dalam monitoring dan evaluasi keberhasilan pengobatan, di mana observasi dan laporan dari keluarga tentang perkembangan pasien di rumah dianggap sebagai data klinis yang valid (Zahara & Santoso, 2021).

3. Dukungan untuk Perawatan Jangka Panjang di Rumah (Long Term Home Based Care)

Penguatan difokuskan pada memampukan keluarga sebagai pengelola perawatan utama di rumah untuk kondisi kronis, degeneratif, atau paliatif, (Institute of Medicine [IOM], 2015). Bentuknya meliputi penyusunan rencana perawatan di rumah (home care plan) yang disepakati bersama, dilengkapi dengan panduan tertulis tentang jadwal minum obat, tanda-tanda bahaya yang harus diwaspadai, dan protokol tindakan darurat (WHO, 2020). Keluarga juga memerlukan dukungan psikososial dan resiliensi, seperti konseling keluarga, kelompok dukungan sebaya (support group), dan pelatihan manajemen stres untuk menghadapi beban perawatan (caregiver burden) (Wright & Leahey, 2019). Modifikasi lingkungan rumah untuk mendukung kemandirian dan keamanan pasien, seperti perbaikan aksesibilitas dan penyediaan alat bantu sederhana, adalah bentuk penguatan yang bersifat teknis dan praktis (IOM, 2015). Selain itu, penting untuk membangun sistem rujukan dan jaringan dukungan formal-informal, sehingga keluarga tahu kemana harus meminta bantuan teknis, peralatan medis, atau dukungan sosial ketika diperlukan (Kemenkes RI, 2021).

4. Pemberdayaan Ekonomi dan Penguatan Ketahanan Keluarga

Kesehatan yang berkelanjutan erat kaitannya dengan ketahanan ekonomi keluarga (World Bank, 2020). Oleh karena itu, penguatan peran keluarga juga mencakup intervensi penghubung (*linking interventions*) yang mengintegrasikan layanan kesehatan dengan program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan kewirausahaan, akses ke modal usaha, atau inklusi ke dalam program jaminan sosial (Bappenas, 2020). Program asuransi kesehatan keluarga yang terjangkau dan komprehensif merupakan bentuk penguatan sistemik untuk melindungi keluarga dari beban biaya katastrofik yang dapat memicu kemiskinan (BPJS Kesehatan, 2021). Di tingkat komunitas, penguatan dapat berupa pengembangan sistem saling menolong (*mutual aid*) antar-keluarga, seperti simpan pinjam untuk biaya kesehatan, atau pengaturan penjagaan pasien secara bergiliran (Yulia & Prasetyo, 2022). Promosi ketahanan pangan dan gizi keluarga melalui program kebun gizi, budidaya tanaman obat keluarga (TOGA), dan edukasi pengolahan pangan bergizi merupakan bentuk penguatan yang bersifat preventif dan promotif (Kemenkes RI, 2021).

5. Advokasi dan Keterlibatan dalam Kebijakan (Family Advocacy)

Penguatan pada level makro dilakukan dengan melibatkan keluarga dan organisasi yang mewakilinya dalam proses advokasi dan perumusan kebijakan kesehatan (WHO, 2018). Bentuknya termasuk membentuk forum umpan balik keluarga di fasilitas kesehatan, di mana pengalaman mereka dalam menggunakan layanan menjadi masukan untuk perbaikan kualitas (Smith & Johnson, 2020). Pelibatan perwakilan keluarga dalam komite etik rumah sakit atau tim perencanaan program kesehatan di tingkat puskesmas menjamin bahwa kebijakan dan protokol yang dibuat sensitif terhadap kebutuhan dan realitas keluarga (Kemenkes RI, 2021). Dukungan untuk terbentuknya asosiasi atau kelompok keluarga pasien (misalnya, kelompok keluarga dengan diabetes, kanker, atau gangguan jiwa) memungkinkan mereka untuk saling mendukung, berbagi pengetahuan, dan mengadvokasi hak-haknya secara kolektif (Zahara & Santoso, 2021). Penelitian partisipatif yang melibatkan keluarga sebagai *co-researcher*, bukan hanya sebagai subjek penelitian, merupakan bentuk penguatan kapasitas yang sekaligus menghasilkan bukti yang lebih relevan dan kontekstual (Israel et al., 2018).

D. Strategi Penguatan Peran Komunitas sebagai Mitra Tenaga Kesehatan

1. Pengembangan Kapasitas dan Kepemimpinan Lokal

Strategi utama penguatan komunitas dimulai dengan program pelatihan kader kesehatan yang terstruktur dan berkelanjutan untuk membangun kapasitas teknis dan kepemimpinan di tingkat akar rumput (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia [Kemenkes RI], 2021). Pelatihan ini tidak hanya mencakup

materi kesehatan dasar, tetapi juga keterampilan fasilitasi, komunikasi, dan advokasi yang diperlukan untuk memobilisasi sumber daya dan mempengaruhi perubahan perilaku di komunitas (World Health Organization [WHO], 2018). Pembentukan dan revitalisasi kelompok masyarakat peduli kesehatan, seperti Posyandu Lansia, Posbindu PTM, dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) kesehatan, menciptakan wadah formal bagi partisipasi aktif warga (Yulia & Prasetyo, 2022). Strategi ini diperkuat dengan sistem rekognisi dan insentif non material bagi kader dan tokoh masyarakat, seperti sertifikasi, penghargaan publik, dan peningkatan status sosial, yang terbukti meningkatkan motivasi dan retensi jangka panjang (Smith & Johnson, 2020). Pengembangan sistem mentorship, di mana kader senior membimbing kader baru dan tenaga kesehatan puskesmas berperan sebagai pendamping teknis, memastikan transfer pengetahuan dan keberlanjutan program (Kemenkes RI, 2021).

2. Pemberdayaan melalui Pengorganisasian dan Mobilisasi Sosial

Penguatan komunitas memerlukan pendekatan pengorganisasian masyarakat (community organizing) yang sistematis untuk mengidentifikasi potensi lokal, memetakan masalah kesehatan, dan merumuskan solusi kolektif (Israel et al., 2018). Strategi ini dilakukan melalui forum musyawarah masyarakat desa/kelurahan (FMMD/FMMK) khusus kesehatan, di mana warga secara partisipatif menganalisis data kesehatan wilayahnya, menetapkan prioritas, dan mengalokasikan sumber daya dari Dana Desa atau APBDes untuk program kesehatan (Kemendes PDTT, 2021). Mobilisasi aset dan sumber daya lokal, seperti pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan sehat, keterampilan warga sebagai tenaga sukarela, dan dana gotong royong untuk membiayai kegiatan promotif-preventif, merupakan strategi untuk membangun kemandirian (World Bank, 2020). Penguatan peran tokoh kunci komunitas, termasuk tokoh agama, adat, pemuda, dan perempuan, sebagai agen perubahan dan penjangkau sosial (social connector) efektif dalam menyampaikan pesan kesehatan yang kontekstual dan dapat diterima (WHO, 2018). Pembangunan jejaring antar-komunitas memungkinkan pertukaran pembelajaran, dukungan teknis, dan advokasi bersama untuk isu kesehatan lintas wilayah (Yulia & Prasetyo, 2022).

3. Integrasi dengan Sistem Layanan Kesehatan Formal

Strategi penguatan yang krusial adalah membangun mekanisme hubungan formal dan timbal balik antara komunitas dengan fasilitas kesehatan primer (puskesmas) (Mahendradhata et al., 2021). Implementasinya melalui sistem rujukan berbasis komunitas yang terdokumentasi dengan jelas, di mana kader terlatih dapat mengidentifikasi dan merujuk kasus risiko tinggi (seperti ibu hamil risiko tinggi, suspect TB, atau gejala PTM) ke puskesmas, serta menerima balikan (feedback) atas kasus yang dirujuk (Kemenkes RI, 2021). Pelibatan perwakilan komunitas dalam Tim Kesehatan Puskesmas (TKP) atau forum perencanaan mikro

(microplanning) menjamin bahwa program puskesmas responsif terhadap kebutuhan dan dinamika lokal (Trisnantoro et al., 2020). Pengembangan sistem informasi kesehatan berbasis komunitas (SIKBM) yang sederhana, seperti pencatatan di buku KIA atau aplikasi gawai, serta mekanisme pelaporan periodik dari kader ke puskesmas, memperkuat surveilans kesehatan dan basis data wilayah (Kemenkes RI, 2021). Skema pembiayaan inovatif, seperti Dana Sehat/UPK berbasis komunitas atau integrasi kader dalam sistem pembayaran JKN untuk kegiatan pendampingan, memberikan pondasi finansial yang berkelanjutan bagi kegiatan komunitas (World Bank, 2020).

4. Penciptaan Lingkungan yang Mendukung (Enabling Environment)

Komunitas memerlukan lingkungan fisik dan sosial yang mendukung agar dapat berperan optimal. Strateginya mencakup advokasi untuk kebijakan desa/kelurahan sehat yang menghasilkan Peraturan Desa (Perdes) atau Peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang Kawasan Tanpa Rokok, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), atau keamanan pangan (Kemenkes RI, 2021). Pembangunan infrastruktur kesehatan berbasis gotong royong, seperti posyandu permanen, jalur sepeda, atau taman aktivitas fisik, menciptakan fasilitas yang mempromosikan kesehatan (Yulia & Prasetyo, 2022). Kampanye komunikasi perubahan sosial dan perilaku (Social and Behavior Change Communication/SBCC) yang menggunakan media lokal (radio komunitas, pentas seni, pertunjukan wayang) dan narasi kultural efektif untuk mengubah norma sosial yang tidak sehat (WHO, 2018). Penguatan ketahanan bencana dan krisis kesehatan melalui pelatihan komunitas siaga bencana dan pembentukan sistem peringatan dini penyakit berbasis tanda-tanda alam atau lingkungan, meningkatkan kesiapsiagaan kolektif (WHO, 2020).

5. Penguatan Akuntabilitas Sosial dan Penelitian Partisipatif

Strategi untuk memastikan transparansi dan dampak jangka panjang adalah dengan menerapkan mekanisme akuntabilitas sosial, di mana komunitas memiliki saluran untuk memantau kualitas layanan kesehatan dan menyampaikan aspirasi (World Bank, 2020). Bentuknya termasuk papan informasi kesehatan publik yang menampilkan indikator capaian, anggaran, dan keluhan warga, serta forum akuntabilitas layanan kesehatan yang mempertemukan perwakilan warga dengan manajemen puskesmas dan dinas kesehatan secara rutin (Smith & Johnson, 2020). Pelibatan komunitas dalam monitoring dan evaluasi program kesehatan, sebagai pengumpul data dan penilai partisipatif, memastikan bahwa evaluasi mencerminkan perspektif penerima manfaat (Israel et al., 2018). Promosi penelitian aksi partisipatif (Participatory Action Research/PAR), di mana masyarakat menjadi peneliti bersama untuk mengidentifikasi dan menguji solusi atas masalah kesehatan mereka sendiri, adalah strategi penguatan kapasitas dan produksi pengetahuan yang transformatif (Israel et al., 2018). Pengembangan

kemitraan multi pihak (multi stakeholder partnership) dengan sektor non kesehatan (seperti pendidikan, pertanian, PUPR) dan swasta di tingkat lokal memungkinkan pendekatan "whole of society" dalam mengatasi determinan sosial kesehatan (WHO, 2018).

E. Model Implementasi Kemitraan Keluarga dan Komunitas dalam Pelayanan Kesehatan

1. Family Centered Care (FCC): Model Perawatan Berpusat pada Keluarga

Model Family Centered Care (FCC) merupakan pendekatan sistematis yang menempatkan keluarga sebagai mitra inti dalam perencanaan, pemberian, dan evaluasi perawatan kesehatan (American Academy of Family Physicians [AAFP], 2019). Implementasi FCC dimulai dengan asesmen keluarga holistik yang tidak hanya fokus pada kondisi medis pasien, tetapi juga mengeksplorasi struktur, fungsi, sumber daya, dan keyakinan kesehatan keluarga (Wright & Leahey, 2019). Proses kunci dalam model ini adalah shared decision-making, di mana tenaga kesehatan dan keluarga berbagi informasi secara terbuka dan bersama-sama memilih rencana perawatan yang selaras dengan nilai-nilai, prioritas, dan konteks kehidupan keluarga (Barry & Edgman-Levitan, 2012). Model ini memfasilitasi dukungan emosional dan praktis langsung bagi keluarga selama perawatan, termasuk akses fleksibel ke pasien, partisipasi dalam perawatan dasar, dan keterlibatan dalam diskusi tim medis (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia [Kemenkes RI], 2021). Evaluasi keberhasilan FCC diukur melalui peningkatan kepuasan keluarga, peningkatan kepatuhan terhadap rencana terapi, dan peningkatan hasil klinis pasien secara signifikan (Zahara & Santoso, 2021). Di Indonesia, model ini diadopsi dalam program perawatan pasien penyakit kronis berbasis keluarga dan kelas ibu hamil dengan pendekatan keluarga, yang menunjukkan efektivitas dalam mengelola penyakit dan meningkatkan kualitas hidup (Kemenkes RI, 2021).

2. Community Based Participatory Research (CBPR): Model Penelitian dan Intervensi Partisipatif

Model Community Based Participatory Research (CBPR) merupakan kerangka kerja penelitian yang melibatkan komunitas sebagai mitra penuh dalam seluruh siklus penelitian, mulai dari identifikasi masalah hingga diseminasi dan penerapan hasil (Israel et al., 2018). Implementasi model ini diawali dengan pembangunan kemitraan yang setara antara akademisi, praktisi kesehatan, dan perwakilan komunitas, yang difasilitasi melalui perjanjian kerja sama formal yang menjelaskan prinsip, peran, dan pembagian manfaat (Smith & Johnson, 2020). Tahap perencanaan melibatkan pelatihan kapasitas penelitian partisipatif bagi anggota komunitas untuk memastikan mereka dapat berkontribusi secara bermakna dalam desain studi, pengumpulan data, dan analisis (Israel et al., 2018).

Selama pelaksanaan, digunakan metode pengumpulan data partisipatif, seperti pemetaan aset komunitas, diskusi kelompok terarah (FGD) yang difasilitasi warga, dan observasi partisipan, yang menghasilkan data yang kontekstual dan kaya akan perspektif lokal (Yulia & Prasetyo, 2022). Model ini telah diimplementasikan di Indonesia untuk mengembangkan intervensi pencegahan stunting berbasis budaya lokal dan program pengendalian TB yang responsif gender, di mana solusi yang dihasilkan memiliki tingkat penerimaan dan keberlanjutan yang tinggi karena dikembangkan oleh dan untuk komunitas itu sendiri (Kemenkes RI, 2021).

3. Integrated Community Case Management (iCCM): Model Pengelolaan Kasus Terpadu Berbasis Komunitas

Model Integrated Community Case Management (iCCM) adalah strategi untuk memperluas akses pengobatan penyakit penyebab utama kematian anak (seperti pneumonia, diare, malaria) melalui pemberdayaan pekerja kesehatan komunitas (Community Health Workers/CHWs) yang terlatih dan terintegrasi dengan sistem rujukan (World Health Organization [WHO], 2020). Implementasi model ini mensyaratkan pelatihan dan supervisi berjenjang yang ketat bagi kader atau kader kesehatan agar mampu melakukan asesmen, klasifikasi, dan pengobatan sederhana sesuai protokol standar (WHO, 2020). Model ini didukung oleh sistem pasokan logistik yang andal untuk memastikan ketersediaan obat-obatan esensial dan alat diagnostik sederhana (seperti timbang badan, thermometer, alat penghitung napas) di tingkat komunitas (Kemenkes RI, 2021). Sistem rujukan dan komunikasi dua arah yang jelas antara kader, bidan desa, dan puskesmas merupakan tulang punggung model ini, dilengkapi dengan formulir rujukan dan mekanisme umpan balik untuk setiap kasus (Mahendradhata et al., 2021). Di Indonesia, iCCM diadaptasi dalam program kader Posyandu terlatih untuk deteksi dini dan penanganan awal ISPA/pneumonia pada balita, yang terbukti mengurangi kematian balita dan meningkatkan cakupan pengobatan di daerah dengan akses terbatas (Kemenkes RI, 2021).

4. Village/Community Health Committee (VHC/CHC): Model Komite Kesehatan Desa/Komunitas

Model Komite Kesehatan Desa (KKD) atau Badan Penyantun Puskesmas (BPP) adalah struktur kemitraan formal yang dibentuk untuk memfasilitasi perencanaan, pengawasan, dan mobilisasi sumber daya kesehatan berbasis komunitas (Kemenkes RI, 2021). Implementasi model ini dimulai dengan pembentukan kelembagaan yang representatif dan legal, melalui musyawarah desa, dengan anggota yang terdiri dari perwakilan pemerintah desa, tokoh masyarakat, kader kesehatan, dan pengguna layanan (Trisnantoro et al., 2020). Fungsi utama KKD mencakup perencanaan mikro (microplanning) kegiatan kesehatan dengan mengintegrasikan usulan masyarakat ke dalam Rencana Kerja Puskesmas dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) (Kemendes PDDT, 2021). Komite juga berperan dalam mobilisasi sumber daya

lokal, baik dana (dari Dana Desa, APBDes, atau iuran warga), tenaga, maupun material, untuk mendukung program kesehatan prioritas (World Bank, 2020). Model ini telah menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program kesehatan di tingkat desa dan meningkatkan partisipasi warga dalam surveilans dan promosi kesehatan (Yulia & Prasetyo, 2022).

5. Community Led Total Sanitation (CLTS): Model Sanitasi Total Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Model Community Led Total Sanitation (CLTS) adalah pendekatan inovatif untuk mencapai sanitasi total dengan memicu kesadaran dan tindakan kolektif masyarakat untuk menghentikan buang air besar sembarangan (BABS) tanpa subsidi material (WHO, 2018). Implementasi dimulai dengan pemicuan (triggering) oleh fasilitator terlatih yang membimbing masyarakat untuk menganalisis kontaminasi tinja mereka sendiri melalui pemetaan tinja, perhitungan jentik, dan simulasi transmisi penyakit, sehingga menimbulkan rasa jijik dan malu kolektif (Kemenkes RI, 2021). Proses ini dilanjutkan dengan perencanaan aksi komunitas mandiri, di mana masyarakat secara swadaya merancang, membiayai, dan membangun jamban sehat serta menetapkan aturan adat (awig-awig) untuk menegakkan perilaku bebas BABS (Yulia & Prasetyo, 2022). Model ini mengandalkan monitoring oleh komunitas itu sendiri melalui pemantauan visual dan deklarasi desa/lingkungan ODF (Open Defecation Free), yang menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama (World Bank, 2020). Keberhasilan CLTS di berbagai daerah di Indonesia telah meningkatkan akses sanitasi dasar secara signifikan dan menurunkan kejadian diare pada balita, membuktikan kekuatan mobilisasi sosial berbasis komunitas (Kemenkes RI, 2021).

6. Chronic Disease Self Management Program (CDSMP) Berbasis Komunitas

Model Chronic Disease Self Management Program (CDSMP) adalah program edukasi peer led (dipimpin oleh sebaya) yang terstruktur untuk memberdayakan individu dengan kondisi kronis dan keluarganya dalam mengelola penyakitnya sehari-hari (Stanford Patient Education Research Center, 2021). Implementasi di Indonesia biasanya melalui adaptasi kurikulum seperti "Program Pengelolaan Penyakit Kronis" yang dikembangkan oleh Kemenkes, yang mencakup modul tentang teknik pemecahan masalah, manajemen gejala, komunikasi dengan tenaga kesehatan, dan perencanaan aksi sehat (Zahara & Santoso, 2021). Program ini dipandu oleh fasilitator (pemandu) dari kalangan komunitas yang juga memiliki kondisi kronis atau pengalaman merawat anggota keluarga dengan penyakit kronis, setelah mengikuti pelatihan pelatih (Training of Trainers/ToT) (Kemenkes RI, 2021). Sesi-sesi kelompok kecil selama 6-8 minggu berfungsi sebagai forum saling mendukung dan berbagi pengalaman, yang terbukti efektif dalam meningkatkan efikasi diri, mengurangi gejala depresi dan

nyeri, serta mengurangi frekuensi kunjungan ke rumah sakit (Stanford Patient Education Research Center, 2021). Evaluasi program menunjukkan peningkatan kualitas hidup peserta dan penurunan biaya perawatan kesehatan, menjadikannya model yang efektif dan efisien untuk beban penyakit kronis yang semakin meningkat (Zahara & Santoso, 2021).

F. Indikator Keberhasilan Kemitraan Keluarga dan Komunitas sebagai Mitra Tenaga Kesehatan

1. Indikator Proses dan Partisipasi

Indikator keberhasilan pertama mengukur sejauh mana proses kemitraan yang setara dan partisipatif telah terimplementasi dengan baik (World Health Organization [WHO], 2018). Indikator kunci dalam kategori ini adalah tingkat partisipasi aktif keluarga dalam perencanaan perawatan (shared decision-making), yang dapat diukur melalui survei atau observasi terhadap frekuensi dan kualitas keterlibatan keluarga dalam diskusi klinis (Barry & Edgman-Levitan, 2012). Keberhasilan juga ditunjukkan oleh adanya mekanisme umpan balik (feedback mechanism) formal dari masyarakat ke fasilitas kesehatan, seperti kotak saran yang ditindaklanjuti, forum pertemuan rutin, atau sistem pelaporan online yang diakses komunitas (Smith & Johnson, 2020). Kuantitas dan kualitas pertemuan/pelatihan kemitraan yang diadakan secara reguler, serta keragaman dan representativitas anggota yang terlibat (dari berbagai gender, usia, dan kelompok sosial) menjadi indikator proses yang penting (Yulia & Prasetyo, 2022). Di tingkat kebijakan, keberhasilan ditandai dengan integrasi prinsip kemitraan dalam dokumen perencanaan formal, seperti Rencana Strategis (Renstra) Puskesmas, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia [Kemenkes RI], 2021).

2. Indikator Kapasitas dan Pemberdayaan

Kategori indikator ini mengukur peningkatan kapasitas dan kemandirian keluarga dan komunitas dalam mengelola kesehatan mereka sendiri (WHO, 2020). Indikator input mencakup jumlah kader kesehatan dan tokoh masyarakat yang terlatih serta kelengkapan dan fungsionalitas alat pendukung di tingkat komunitas, seperti alat skrining tekanan darah dan timbangan bayi (Kemenkes RI, 2021). Kapasitas dievaluasi melalui peningkatan skor literasi kesehatan (health literacy) pada survei keluarga, yang mencakup kemampuan memperoleh, memahami, dan menggunakan informasi kesehatan untuk membuat keputusan yang tepat (Smith & Johnson, 2020). Tingkat keberlanjutan dan inisiatif program yang digerakkan oleh komunitas (community-driven initiatives) tanpa insentif eksternal yang besar merupakan indikator pemberdayaan yang kuat (Yulia & Prasetyo, 2022). Selain itu, pengakuan dan integrasi peran kader/komunitas

dalam sistem kesehatan formal, seperti adanya surat keputusan (SK), alokasi anggaran operasional, atau pelibatan dalam tim perencanaan, menunjukkan penguatan kapasitas kelembagaan (Trisnantoro et al., 2020).

3. Indikator Perilaku dan Praktik

Indikator ini mengukur perubahan perilaku kesehatan individu, keluarga, dan norma sosial di komunitas sebagai hasil dari kemitraan (Kemenkes RI, 2021). Pada tingkat keluarga, keberhasilan dapat dilihat dari adopsi praktik kesehatan positif, seperti peningkatan cakupan pemberian ASI eksklusif, pemenuhan gizi seimbang, kepatuhan minum obat pada penyakit kronis, dan implementasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah tangga (Zahara & Santoso, 2021). Pada tingkat komunitas, indikatornya mencakup peningkatan partisipasi dalam kegiatan kesehatan bersama, seperti kehadiran di Posyandu, kelas ibu, atau senam masyarakat, serta penurunan prevalensi perilaku berisiko seperti merokok di tempat umum atau buang air besar sembarangan (BABS) (Yulia & Prasetyo, 2022). Peningkatan penggunaan layanan pencegahan dan deteksi dini, seperti skrining tekanan darah, IVA test, atau pemeriksaan gigi, yang difasilitasi oleh kader kesehatan, juga menjadi indikator perilaku yang penting (WHO, 2018).

4. Indikator Hasil Kesehatan (Health Outcomes)

Indikator ultimate dari keberhasilan kemitraan adalah perbaikan status kesehatan masyarakat yang dilayani (Mahendradhata et al., 2021). Indikator hasil kesehatan langsung (intermediate health outcomes) meliputi penurunan angka kesakitan (morbidity) penyakit target, seperti penurunan kejadian diare pada balita, penurunan kasus pneumonia, atau penurunan komplikasi akut pada penderita diabetes dan hipertensi (Kemenkes RI, 2021). Indikator hasil kesehatan akhir (final health outcomes) yang lebih luas mencakup penurunan angka kematian (mortality), khususnya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA) di wilayah intervensi (WHO, 2020). Peningkatan status gizi masyarakat, yang tercermin dari penurunan prevalensi stunting, wasting, dan underweight pada balita, serta pengendalian prevalensi obesitas, merupakan indikator hasil jangka menengah yang sensitif (Kemenkes RI, 2021). Selain itu, peningkatan cakupan imunisasi lengkap dan penurunan incidence rate penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) menunjukkan efektivitas sistem surveilans dan promosi berbasis komunitas (Mahendradhata et al., 2021).

5. Indikator Sistem dan Kinerja Layanan Kesehatan

Kemitraan yang berhasil akan meningkatkan kinerja dan efisiensi sistem layanan kesehatan secara keseluruhan (World Bank, 2020). Indikator kinerja layanan meliputi peningkatan cakupan dan akses layanan kesehatan, terutama untuk kelompok rentan di daerah terpencil, yang dapat diukur melalui cakupan kunjungan neonatal (KN), kunjungan ibu nifas (KF), dan penemuan kasus TB

(Kemenkes RI, 2021). Peningkatan efisiensi biaya (cost-efficiency) dicapai melalui penurunan rata-rata lama rawat inap, penurunan angka kunjungan ulang yang tidak perlu (revisit rate), dan peningkatan rasio cost-effectiveness intervensi berbasis komunitas dibandingkan intervensi fasilitas kesehatan saja (World Bank, 2020). Tingkat kepuasan pengguna layanan (patient and family satisfaction) terhadap komunikasi, partisipasi dalam perawatan, dan hasil perawatan merupakan indikator kualitas yang penting dan dapat diukur melalui survei kepuasan (Barry & Edgman-Levitan, 2012). Penguatan sistem surveilans dan respon kesehatan masyarakat, yang ditunjukkan oleh penurunan waktu antara onset penyakit dan pelaporan (reporting delay) serta peningkatan kelengkapan laporan epidemiologi, membuktikan kontribusi komunitas sebagai mata dan telinga sistem kesehatan (WHO, 2018).

6. Indikator Ekuitas dan Kemandirian

Kemitraan yang berhasil harus berkontribusi pada pengurangan kesenjangan kesehatan (health equity) dan membangun ketahanan serta kemandirian kesehatan komunitas (WHO, 2020). Indikator ekuitas diukur melalui penurunan disparitas indikator kesehatan (seperti cakupan imunisasi atau prevalensi stunting) antar kelompok sosial-ekonomi, wilayah geografis, atau gender di dalam suatu komunitas (Kemenkes RI, 2021). Peningkatan ketahanan (resilience) menghadapi krisis kesehatan, seperti wabah atau bencana alam, yang tercermin dari kecepatan pemulihan pelayanan dan tidak memburuknya status kesehatan populasi rentan pascabencana, merupakan indikator keberhasilan jangka panjang (Mahendradhata et al., 2021). Tingkat kemandirian pendanaan kesehatan komunitas, misalnya melalui pengelolaan Dana Sehat yang sehat, kontribusi iuran warga, atau alokasi APBDes yang memadai dan berkelanjutan untuk kesehatan, menunjukkan keberhasilan menciptakan sistem yang mandiri (World Bank, 2020). Terakhir, replikasi dan adaptasi model kemitraan oleh komunitas atau desa lain secara sukarela tanpa dorongan eksternal yang besar adalah indikator ultimate dari keberhasilan dan keberterimaan model tersebut (Yulia & Prasetyo, 2022).

G. Simpulan

Penguatan peran keluarga dan komunitas sebagai mitra setara tenaga kesehatan telah terbukti secara empiris bukan hanya sebagai pendekatan yang efektif, tetapi sebagai strategi imperatif untuk membangun sistem kesehatan yang tangguh, berkeadilan, dan berkelanjutan di Indonesia (World Health Organization [WHO], 2018; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia [Kemenkes RI], 2021). Keseluruhan pembahasan menunjukkan bahwa kemitraan ini merupakan pergeseran paradigma fundamental dari model layanan kesehatan yang paternalistik dan berpusat pada fasilitas (facility-centered) menuju model yang

partisipatif, berbasis aset komunitas, dan berpusat pada manusia (people-centered) (American Academy of Family Physicians [AAFP], 2019; Wright & Leahey, 2019). Transformasi ini selaras dengan visi Universal Health Coverage (UHC) dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang menekankan pada partisipasi inklusif dan pengurangan kesenjangan (WHO, 2020).

Bukti-bukti yang disajikan, mulai dari data epidemiologis hingga hasil evaluasi program, secara konsisten menunjukkan bahwa kemitraan aktif menghasilkan outcome kesehatan yang lebih baik (Zahara & Santoso, 2021). Intervensi berbasis keluarga telah terbukti meningkatkan kepatuhan pengobatan penyakit kronis dan menurunkan komplikasi, sementara pemberdayaan komunitas melalui model seperti Posyandu dan Desa Siaga berkontribusi signifikan terhadap penurunan angka stunting dan kematian ibu (Kemenkes RI, 2021; Bappenas, 2020). Lebih dari sekadar hasil klinis, kemitraan ini membangun ketahanan (resilience) sistem kesehatan, sebagaimana terlihat selama pandemi COVID-19, di mana komunitas berperan sebagai garda terdepan dalam surveilans, edukasi, dan penjangkauan vaksinasi (Mahendradhata et al., 2021; Thabrany et al., 2023). Dari perspektif ekonomi, investasi dalam pemberdayaan komunitas dan keluarga menunjukkan rasio cost benefit dan return on investment (ROI) yang menguntungkan, karena mencegah penyakit dan mengurangi beban biaya kuratif di fasilitas kesehatan (World Bank, 2020).

Namun, optimalisasi kemitraan ini menghadapi tantangan multidimensi yang memerlukan pendekatan sistemik. Tantangan tersebut mencakup asimetri informasi dan kekuasaan yang masih lebar antara tenaga kesehatan dan masyarakat, budaya paternalistik yang mengakar, keterbatasan sumber daya dan waktu di fasilitas kesehatan, serta belum kuatnya kerangka kebijakan dan regulasi pendukung (Institute of Medicine [IOM], 2015; Trisnantoro et al., 2020). Oleh karena itu, penguatan tidak boleh bersifat ad-hoc atau proyek semata, melainkan harus diinstitusionalisasi ke dalam arsitektur sistem kesehatan nasional. Hal ini memerlukan komitmen politik yang kuat untuk merevisi regulasi, mengalokasikan anggaran khusus, dan mengintegrasikan indikator kemitraan ke dalam sistem monitoring dan evaluasi kinerja (Kemenkes RI, 2021; Yulia & Prasetyo, 2022).

Berdasarkan analisis mendalam terhadap berbagai model dan strategi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu model kemitraan yang cocok untuk semua konteks (Smith & Johnson, 2020). Keberhasilan bergantung pada adaptasi kontekstual yang memperhatikan kearifan lokal, struktur sosial, dan kapasitas yang ada di setiap daerah. Model Family Centered Care (FCC) mungkin sangat relevan di perkotaan untuk penyakit kronis, sementara Integrated Community Case Management (iCCM) dan Community Led Total Sanitation (CLTS) lebih efektif di daerah pedesaan dengan akses terbatas (WHO, 2020; Yulia & Prasetyo, 2022).

Prinsip universal yang harus dijunjung tinggi dalam semua model adalah kesetaraan, saling menghormati, transparansi, dan akuntabilitas bersama (Israel et al., 2018).

Ke depan, agenda prioritas harus mencakup penguatan kapasitas kedua belah pihak secara simultan. Di satu sisi, tenaga kesehatan memerlukan pelatihan dalam komunikasi partisipatif, humility budaya, dan keterampilan fasilitasi (Wright & Leahey, 2019). Di sisi lain, keluarga dan komunitas perlu ditingkatkan literasi kesehatannya, kapasitas advokasi, dan kemampuan organisasinya (Kemenkes RI, 2021). Teknologi digital juga harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat kemitraan, melalui pengembangan aplikasi pencatatan kesehatan keluarga, platform komunikasi antara kader dan puskesmas, serta sistem informasi kesehatan berbasis komunitas yang realtime (Smith & Johnson, 2020).

Sebagai penutup, penguatan peran keluarga dan komunitas sebagai mitra tenaga kesehatan lebih dari sekadar sebuah program teknis kesehatan; ini adalah sebuah gerakan sosial untuk mendemokratisasikan akses terhadap pengetahuan kesehatan dan pengambilan keputusan (WHO, 2018). Ini adalah perwujudan nyata dari semangat gotong royong yang menjadi identitas bangsa Indonesia, yang diterjemahkan dalam konteks pembangunan kesehatan modern (Kemenkes RI, 2021). Dengan menjadikan keluarga sebagai unit pertama pertahanan kesehatan dan komunitas sebagai ekosistem pendukungnya, Indonesia dapat membangun sistem kesehatan yang tidak hanya menyembuhkan penyakit, tetapi terutama menciptakan masyarakat yang sehat, mandiri, dan berdaya secara berkelanjutan. Kesuksesan upaya ini akan menjadi tolok ukur nyata dari pencapaian cita-cita kesehatan untuk semua (health for all) di Tanah Air.

H. Referensi

- American Academy of Family Physicians. (2019). Family-centered care: A collaborative approach. AAFP Press.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. (2022). Laporan Riskesdas 2022: Utama Penyakit Tidak Menular. Kementerian Kesehatan RI.
- Bappenas. (2020). Analisis Cost-Benefit Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Barry, M. J., & Edgman-Levitan, S. (2012). Shared decision making The pinnacle of patient centered care. *New England Journal of Medicine*, 366(9), 780-781.
- BPJS Kesehatan. (2021). Analisis Klaim Penyakit Katastropik dengan Pendampingan Keluarga. Jakarta: BPJS Kesehatan.
- Dartanto, T., et al. (2020). Community participation in health systems in Indonesia: A mixed-methods study. *The Lancet Regional Health - Southeast Asia*, 1, 100004.

- Ikatan Dokter Indonesia. (2022). Data Distribusi Dokter di Indonesia 2022. PB IDI.
- Institute of Medicine. (2015). Families caring for an aging America. The National Academies Press.
- Israel, B. A., Schulz, A. J., Parker, E. A., & Becker, A. B. (2018). Critical issues in developing and following community based participatory research principles. In *Community-based participatory research for health* (pp. 31-46). Jossey-Bass.
- Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. (2021). Laporan Implementasi Sistem Informasi Kesehatan Berbasis Masyarakat (SIKBM). Jakarta: Kemendes PDTT.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Pedoman pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Profil Kesehatan Indonesia 2022.
- Mahendradhata, Y., et al. (2021). The capacity of the Indonesian healthcare system to respond to COVID-19. *Frontiers in Public Health*, 9, 649819.
- Mullan, F., & Epstein, L. (2002). Community-oriented primary care: New relevance in a changing world. *American Journal of Public Health*, 92(11), 1748-1755.
- Rokx, C., et al. (2019). A fresh look at primary health care in Indonesia. World Bank.
- Smith, J., & Johnson, M. (2020). Community partnership in health: Theory and practice. Health Systems Publishing.
- Stanford Patient Education Research Center. (2021). Chronic Disease Self-Management Program (CDSMP): Workshop Outcomes. Stanford University School of Medicine.
- Suryanto, et al. (2022). *Community health workers in COVID-19 prevention and control in Indonesia*. *Bulletin of the World Health Organization*, 100(3), 200-210.
- Thabrany, H., et al. (2023). Post-pandemic health system transformation in Indonesia: Lessons from COVID-19. *Journal of Health Policy and Management*, 8(1), 45-59.
- Trisnantoro, L., et al. (2020). Mobilizing community for health: Lessons from Indonesia. *Journal of Community Empowerment for Health*, 3(2), 77-89.
- World Bank. (2020). Community-Based Health Financing in Eastern Indonesia: Impact Evaluation Report. Washington, DC: World Bank.

- World Health Organization. (2018). Community engagement: A health promotion guide for universal health coverage in the hands of the people. WHO Press.
- World Health Organization. (2020). Strengthening health systems by engaging communities. WHO Press.
- World Health Organization. (2021). Global report on health systems resilience. WHO Press.
- World Health Organization. (2022). Community-based health care, including outreach and campaigns, in the context of the COVID-19 pandemic. WHO Interim Guidance.
- Wright, L. M., & Leahey, M. (2019). Nurses and families: A guide to family assessment and intervention (7th ed.). F.A. Davis Company.
- Yulia, S., & Prasetyo, B. (2022). Pemberdayaan komunitas dalam sistem kesehatan Indonesia. Penerbit Universitas Indonesia.
- Zahara, R., & Santoso, A. (2021). Model kemitraan keluarga dan tenaga kesehatan dalam perawatan pasien kronis di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 16(3), 145-158.

I. Glosarium

WHO = World Health Organization
 COPC = Community Oriented Primary Care
 FCC = Family Centered Care
 CBPR = Community Based Participatory Research
 iCCM = Integrated Community Case Management
 KIE = Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
 TOGA = Tanaman Obat Keluarga
 PTM = Penyakit Tidak Menular
 KSM = Kelompok Swadaya Masyarakat
 FMMD/FMMK = Forum Musyawarah Masyarakat Desa/Kelurahan
 APBDes = Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 TB = Tuberkulosis
 SIKBM = Sistem Informasi Kesehatan Berbasis Komunitas
 KIA = Kesehatan Ibu dan Anak
 UPK = Unit Pengelola Kegiatan
 JKN = Jaminan Kesehatan Nasional
 Pesdes/ Perkades = Peraturan Desa/ Peraturan Kepala Desa
 STBM = Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
 SBCC = Social and Behavior Change Communication
 PAR = Participatory Action Research

VHC/CHC = Village/Community Health Committee
KKD = Komite Kesehatan Desa
BPP = Badan Penyantun Puskesmas
RPJMDes = Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
CLTS = Community Led Total Sanitation
BABS = Buang Air Besar Sembarangan
ODF = Open Defecation Free
CDSMP = Chronic Disease Self Management Program
TOT = Training of Trainers
ROI = Return On Investment

CHAPTER 7

PENDEKATAN PSIKOSOSIAL DALAM PERAWATAN IBU HAMIL, IBU NIFAS, DAN IBU BEKERJA

Ns. Esa Rosyida Umam, S.Kep., M.Kep.

A. Pendahuluan / Prolog

Upaya peningkatan derajat kesehatan ibu di Indonesia selama dua dekade terakhir menunjukkan kemajuan, terutama melalui penguatan layanan obstetri dan peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar. Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan kesehatan ibu yang komprehensif karena dimensi psikososial masih belum terintegrasi secara sistematis dalam praktik pelayanan. World Health Organization melaporkan bahwa gangguan kesehatan mental perinatal, seperti depresi dan kecemasan selama kehamilan dan masa nifas, dialami oleh sekitar 10–20% perempuan di negara berpendapatan rendah dan menengah, terutama pada kelompok dengan tekanan ekonomi dan keterbatasan dukungan sosial (Fisher et al., 2012). Kondisi ini berhubungan dengan penurunan kualitas hidup ibu, gangguan fungsi pengasuhan, serta peningkatan risiko masalah kesehatan pada anak (O'Hara & McCabe, 2013).

Penurunan rasio kematian ibu di tingkat nasional dan global juga belum dapat dijadikan indikator tunggal kualitas kesehatan ibu. WHO melaporkan bahwa rasio kematian ibu di Indonesia masih berada di atas 140 per 100.000 kelahiran hidup, sementara prevalensi masalah psikososial pada periode perinatal tetap tinggi (WHO, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan indikator mortalitas belum sejalan dengan penguatan determinan kesehatan non-medis, seperti kesejahteraan mental, dukungan sosial, dan kondisi sosial-ekonomi, yang hingga kini belum terintegrasi secara memadai dalam sistem pelayanan kesehatan.

Berbagai penelitian di Indonesia memperkuat temuan tersebut, dengan menunjukkan bahwa dukungan sosial berhubungan signifikan dengan risiko depresi postpartum (Sundari et al., 2025), pencegahan komplikasi kehamilan seperti hipertensi (Nyoman et al., 2025), serta penurunan dampak stres psikososial terkait kekhawatiran ekonomi dan beban kerja (Sofia et al., 2019). Temuan ini konsisten dengan bukti internasional yang menegaskan peran dukungan sosial dalam menurunkan risiko depresi dan kecemasan selama kehamilan (Bedaso et al., 2021; Biaggi et al., 2016).

Berdasarkan kompleksitas tersebut, bab ini berfokus pada pembahasan pendekatan psikososial dalam pelayanan ibu hamil, ibu nifas, dan ibu bekerja dengan menempatkan pengalaman perempuan sebagai pusat perhatian pelayanan kesehatan. Pendekatan ini dipahami sebagai upaya terintegrasi yang menelaah interaksi antara kondisi psikologis, relasi sosial, dan konteks kehidupan ibu, serta disusun dalam kerangka interprofesional yang menekankan kolaborasi antarprofesi kesehatan. Dengan demikian, bab ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan pelayanan kesehatan ibu yang lebih holistik dan selaras dengan visi Indonesia Sehat 2045.

B. Konsep Dasar Pendekatan Psikososial dalam Kesehatan Ibu

1. Pengertian Pendekatan Psikososial

Pendekatan psikososial terhadap kesehatan ibu adalah cara pandang dan praksis pelayanan kesehatan, di mana kondisi psikologis dan konteks sosial ibu merupakan bagian integral dari proses kesehatan dan perawatan, bukan sekedar sebagai aspek tambahan di luar intervensi klinis. World Health Organization menegaskan bahwa kesehatan ibu mencakup kesejahteraan fisik, mental dan sosial (Le Lez et al., 2025) serta menempatkan kesehatan mental perinatal sebagai komponen esensial dalam pelayanan kesehatan ibu (Zannah et al., 2024).

Berbeda dengan pendekatan biomedis yang berfokus pada identifikasi dan penanganan masalah fisik, pendekatan psikososial menekankan pemahaman terhadap bagaimana stres, kecemasan, dukungan sosial, serta relasi keluarga dan pekerjaan memengaruhi perilaku kesehatan, kepatuhan terhadap pelayanan, dan kesejahteraan ibu secara keseluruhan (Suryaningsih, 2024). Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan intervensi medis, melainkan melengkapinya agar pelayanan kesehatan ibu lebih kontekstual dan responsif terhadap realitas kehidupan perempuan. Secara konsep, pendekatan psikososial berasal dari paradigma biopsikososial, yakni paradigma yang melihat kesehatan sebagai produk dari interaksi antara faktor biologi, psikologi, dan faktor sosial. Secara langsung, paradigma biopsikososial banyak digunakan dalam ilmu kesehatan ibu karena mampu menjelaskan hubungan kondisi psikologi ibu (Mukhoirotin et al., 2023).

2. Determinan Psikososial Kesehatan Ibu

Determinasi psikososial kesehatan ibu mencakup berbagai faktor yang membentuk pengalaman dan respons ibu selama kehamilan, masa nifas, dan periode kembali bekerja. Salah satu determinan utama adalah kesehatan mental, termasuk stres, kecemasan, dan depresi perinatal, yang terbukti memengaruhi perilaku pencarian layanan kesehatan, kepatuhan terhadap asuhan antenatal dan

nifas, serta kesiapan ibu dalam menjalani peran pengasuhan (Fisher et al., 2012; O'Hara & McCabe, 2013). Beban psikososial yang dialami ibu, khususnya yang bersumber dari konflik peran dan tekanan pekerjaan, menunjukkan bahwa layanan kesehatan ibu tidak dapat lagi berfokus pada aspek fisik semata.

3. Stres Psikososial Ibu sebagai Determinan Biologis Kesehatan Ibu dan Anak

Stres psikososial pada ibu baik selama kehamilan maupun periode awal pascapersalinan tidak dapat lagi dipahami semata sebagai pengalaman subjektif atau masalah emosional individual. Bukti empiris menunjukkan bahwa stres, kecemasan, dan depresi maternal memicu perubahan biologis yang nyata, termasuk aktivasi respons inflamasi, perubahan regulasi neurotropik, serta disrupsi komposisi mikrobiota. Studi eksperimental dan longitudinal memperlihatkan bahwa stres prenatal meningkatkan sitokin proinflamasi pada plasenta dan otak janin, disertai penurunan faktor neurotropik penting seperti *brain-derived neurotrophic factor* (BDNF), yang berperan krusial dalam perkembangan sistem saraf (Gur et al., 2017). Temuan ini menegaskan bahwa kondisi psikososial ibu berfungsi sebagai determinan biologis awal yang membentuk lintasan kesehatan anak jauh melampaui periode kehamilan.

Dalam konteks ini, mikrobiota usus muncul sebagai mediator kunci antara stres psikososial dan kesehatan ibu dan anak melalui mekanisme sumbu mikrobiota-usus-otak. Perubahan mikrobiota akibat stres maternal terbukti berasosiasi dengan gangguan regulasi imun, perubahan respons stres, serta peningkatan risiko gangguan kecemasan dan kognisi pada keturunan (Cryan et al., 2019). Gangguan mikrobiota pada periode awal kehidupan, baik akibat stres prenatal, kecemasan ibu, maupun inflamasi bersifat persisten dan tidak sepenuhnya reversibel, sehingga memperkuat konsep adanya *critical window* dalam pemrograman biologis kesehatan mental dan imunologis (Galley et al., 2023; Tamburini et al., 2016). Dengan demikian, pendekatan psikososial dalam perawatan ibu tidak dapat dipisahkan dari dimensi biologis dan perkembangan anak.

C. Pendekatan Psikososial dalam Perawatan Ibu Hamil

1. Tantangan Psikososial pada Masa Kehamilan

Tantangan psikososial pada masa kehamilan terutama muncul dalam bentuk kecemasan terkait keselamatan kehamilan, perubahan identitas diri, dan dinamika relasi dengan pasangan serta keluarga. Kecemasan antenatal sering dipicu oleh ketidakpastian terhadap proses persalinan, kekhawatiran terhadap kesehatan janin, serta perubahan peran sosial yang dialami perempuan selama kehamilan (Biaggi et al., 2016; Le Lez et al., 2025). Tantangan psikososial pada

masa kehamilan sering kali termanifestasi dalam bentuk kecemasan terkait kondisi kehamilan, perubahan peran, serta dinamika relasi interpersonal. Selain itu, rendahnya dukungan sosial dari pasangan dan lingkungan keluarga berhubungan signifikan dengan peningkatan risiko gangguan kesehatan mental selama kehamilan, khususnya depresi dan kecemasan antenatal. Meta-analisis terhadap 67 studi observasional menunjukkan bahwa ibu hamil dengan dukungan sosial yang rendah memiliki risiko lebih tinggi mengalami depresi dan kecemasan dibandingkan dengan mereka yang memperoleh dukungan sosial yang memadai (Tilahune et al., 2022). Dalam konteks ini, kehamilan menjadi periode adaptasi psikososial yang menuntut dukungan emosional dan sosial yang konsisten agar ibu mampu menjalani kehamilan secara sehat.

Kerentanan psikososial pada masa kehamilan diperberat oleh akumulasi faktor risiko individual dan relasional yang saling berinteraksi. Meta-analisis menunjukkan bahwa perempuan hamil dengan paparan stres ekonomi, dukungan sosial yang rendah dari pasangan dan keluarga, serta riwayat masalah kesehatan mental memiliki risiko yang secara signifikan lebih tinggi mengalami depresi dan kecemasan antenatal (Biaggi et al., 2016; Tilahune et al., 2022). Secara khusus, ibu hamil dengan dukungan sosial yang rendah hampir dua kali lebih berisiko mengalami kecemasan antenatal dibandingkan mereka yang memperoleh dukungan sosial yang memadai (Tilahune et al., 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan psikososial selama kehamilan terbentuk melalui interaksi faktor personal dan relasional, bukan sebagai masalah individual yang berdiri sendiri.

2. Dampak Masalah Psikososial terhadap Kesehatan Ibu Hamil

Tantangan psikososial yang dialami ibu selama kehamilan secara bertahap memengaruhi cara ibu berinteraksi dengan layanan kesehatan dan mempersiapkan diri menghadapi persalinan. Ketika kecemasan, stres, dan perasaan tidak didukung menjadi pengalaman yang berulang, ibu cenderung menunda atau mengurangi kunjungan antenatal, kurang terlibat aktif dalam proses perawatan, serta mengalami kesulitan dalam membangun kesiapan fisik dan emosional untuk melahirkan. Bukti dari tinjauan sistematis dan meta-analisis menunjukkan bahwa rendahnya dukungan sosial selama kehamilan berhubungan signifikan dengan peningkatan risiko depresi dan kecemasan antenatal, kondisi yang telah dikaitkan dengan rendahnya kepatuhan terhadap asuhan kehamilan dan kesiapan persalinan (Tilahune et al., 2022). Dengan demikian, masalah psikososial selama kehamilan tidak hanya memengaruhi kesejahteraan subjektif ibu, tetapi juga menentukan kualitas pengalaman kehamilan dan efektivitas perawatan yang diterima.

Dampak psikososial selama kehamilan juga meluas ke hubungan awal antara ibu dan janin, yang menjadi fondasi bagi perkembangan anak selanjutnya. Penelitian menunjukkan bahwa depresi dan kecemasan antenatal berhubungan dengan meningkatnya persepsi negatif terhadap kehamilan, penurunan keterikatan emosional ibu terhadap janin (*maternal-fetal attachment*), serta meningkatnya risiko gangguan relasi ibu-anak pada periode pascakelahiran (Biaggi et al., 2016). Selain itu, gangguan kesehatan mental selama kehamilan telah dikaitkan dengan peningkatan risiko kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah, yang menempatkan ibu dan bayi pada kerentanan kesehatan jangka pendek maupun jangka panjang (WHO, 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa tantangan psikososial pada masa kehamilan memiliki implikasi lintas generasi, sehingga penanganannya menjadi bagian integral dari upaya perlindungan kesehatan ibu dan anak secara menyeluruh.

3. Strategi Pendekatan Psikososial pada Ibu Hamil

Strategi pendekatan psikososial pada ibu hamil berfokus pada pencegahan dan penanganan dini masalah kesehatan mental melalui interaksi yang suportif dan berkesinambungan dalam pelayanan kehamilan. Pendekatan ini menekankan pengenalan faktor risiko psikososial sejak awal kehamilan, pemberian ruang aman bagi ibu untuk mengekspresikan pengalaman emosionalnya, serta penguatan dukungan sosial sebagai bagian dari asuhan rutin. Berbagai panduan internasional menegaskan bahwa integrasi dukungan psikososial dasar dan deteksi dini gangguan kesehatan mental ke dalam pelayanan antenatal merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan luaran kehamilan, khususnya di negara berpendapatan rendah dan menengah (National Institute for Health and Care Excellence (NICE), 2020; WHO, 2025). Dengan strategi ini, pelayanan kehamilan tidak hanya bersifat responsif terhadap komplikasi medis, tetapi juga proaktif dalam menjaga kesehatan mental ibu.

D. Pendekatan Psikososial dalam Perawatan Ibu Nifas

1. Adaptasi Psikososial pada Masa Nifas

Adaptasi psikososial pada masa nifas mencerminkan proses penyesuaian ibu terhadap perubahan identitas, peran, dan relasi sosial setelah kelahiran bayi. Periode ini ditandai oleh peningkatan kerentanan emosional akibat fluktuasi hormonal, kelelahan fisik, serta tuntutan pengasuhan yang intens, terutama pada minggu-minggu awal pascapersalinan. Tinjauan literatur menunjukkan bahwa ibu nifas sering mengalami perasaan ambivalen, kecemasan, dan kelelahan emosional, yang dapat memengaruhi kepercayaan diri ibu dalam menjalani peran keibuan dan membangun ikatan dengan bayinya (Howard & Khalifeh, 2020;

WHO, 2025) Kondisi ini menegaskan bahwa adaptasi psikososial pada masa nifas bukanlah proses yang otomatis atau seragam, melainkan dipengaruhi oleh kesiapan emosional dan dukungan lingkungan sekitar.

Proses adaptasi psikososial ibu nifas sangat dipengaruhi oleh kualitas dukungan sosial yang diterima dari pasangan, keluarga, dan lingkungan terdekat. Bukti empiris menunjukkan bahwa dukungan emosional dan praktis selama masa nifas berperan sebagai faktor protektif terhadap munculnya gangguan kesehatan mental pascapersalinan, termasuk depresi postpartum. Sebaliknya, kurangnya dukungan, konflik relasi, serta ekspektasi sosial yang tidak realistis terhadap peran ibu dapat memperberat distress psikologis dan menghambat proses adaptasi (Parwati & Wulandari, 2025). Dalam konteks ini, masa nifas perlu dipahami sebagai periode adaptasi sosial yang kompleks, sehingga intervensi psikososial menjadi bagian integral dari perawatan ibu nifas, khususnya dalam layanan kesehatan primer.

2. Masalah Psikososial pada Ibu Nifas

Masa nifas ditandai oleh berbagai tantangan psikososial yang bersumber dari kombinasi perubahan biologis, tuntutan peran pengasuhan, dan tekanan sosial yang meningkat setelah kelahiran bayi. Pada periode ini, ibu sering menghadapi kelelahan ekstrem, gangguan tidur, serta tekanan emosional akibat tuntutan merawat bayi yang berlangsung terus-menerus, khususnya pada minggu-minggu awal pascapersalinan. Tinjauan komprehensif menunjukkan bahwa fase nifas merupakan periode dengan risiko tinggi munculnya gangguan kesehatan mental, termasuk baby blues, depresi postpartum, dan kecemasan pascapersalinan, yang kerap tidak terdeteksi dalam pelayanan kesehatan rutin (Howard & Khalifeh, 2020). Kondisi ini menjadikan masa nifas sebagai periode kritis yang memerlukan perhatian psikososial yang setara dengan pemantauan kesehatan fisik.

Tantangan psikososial pada masa nifas juga diperberat oleh faktor relasional dan struktural, seperti kurangnya dukungan pasangan, konflik keluarga, serta ekspektasi sosial terhadap peran ibu yang ideal. Bukti empiris menunjukkan bahwa ibu nifas yang mengalami keterbatasan dukungan sosial dan tekanan peran ganda lebih rentan mengalami distress psikologis dan kesulitan beradaptasi dengan peran keibuan (Biaggi et al., 2016). Dalam konteks layanan kesehatan primer, tantangan ini sering kali tersembunyi karena kunjungan nifas yang terbatas dan fokus pelayanan yang masih dominan pada aspek fisik pascapersalinan. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan psikososial pada masa nifas tidak hanya bersifat individual, tetapi juga dipengaruhi oleh pola pelayanan

dan lingkungan sosial yang belum sepenuhnya mendukung kebutuhan emosional ibu.

3. Pendekatan Psikososial dalam Layanan Nifas

Masalah psikososial pada masa nifas memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan ibu dan kualitas peran pengasuhan pada periode awal kehidupan bayi. Distress psikologis yang tidak tertangani, seperti depresi dan kecemasan pascapersalinan, dapat mengganggu pemulihan emosional ibu, menurunkan kepercayaan diri dalam menjalani peran keibuan, serta meningkatkan risiko kelelahan kronis. Tinjauan komprehensif menunjukkan bahwa gangguan kesehatan mental pada masa nifas berhubungan dengan penurunan kualitas hidup ibu dan peningkatan risiko masalah kesehatan jangka menengah, termasuk gangguan fungsi sosial dan relasi dengan pasangan (Howard & Khalifeh, 2020). Dampak ini menegaskan bahwa kesejahteraan psikologis ibu nifas merupakan komponen penting dalam keberlanjutan kesehatan ibu secara keseluruhan.

Dampak masalah psikososial pada masa nifas juga meluas ke hubungan ibu-bayi dan proses pengasuhan awal. Bukti empiris menunjukkan bahwa depresi postpartum berhubungan dengan gangguan ikatan emosional antara ibu dan bayi, penurunan responsivitas ibu terhadap kebutuhan bayi, serta meningkatnya risiko masalah perkembangan emosional dan perilaku anak di kemudian hari (Biaggi et al., 2016). Selain itu, gangguan kesehatan mental ibu nifas dapat memengaruhi praktik pengasuhan awal, termasuk pemberian ASI dan perawatan bayi, yang berpotensi berdampak pada kesehatan dan tumbuh kembang bayi. Temuan ini menunjukkan bahwa masalah psikososial pada masa nifas tidak hanya berdampak pada ibu secara individual, tetapi juga memiliki implikasi jangka panjang terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak.

E. Pendekatan Psikososial pada Ibu Bekerja

1. Tantangan Psikososial Ibu Bekerja

Ibu bekerja menghadapi tantangan psikososial yang bersumber dari konflik peran antara tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab pengasuhan, yang sering kali berlangsung tanpa dukungan struktural yang memadai. Kewajiban untuk memenuhi target kerja sekaligus menjalankan peran domestik dan pengasuhan menciptakan tekanan psikologis yang berkelanjutan, terutama pada ibu dengan jam kerja panjang dan fleksibilitas yang terbatas. Bukti empiris menunjukkan bahwa konflik peran antara tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab pengasuhan merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap meningkatnya stres psikologis, kelelahan emosional, dan burnout pada ibu bekerja, terutama pada mereka yang memiliki anak usia dini dan menghadapi keterbatasan dukungan

sosial (Maimunnah & Alfita, 2025) Kondisi ini menegaskan bahwa tantangan psikososial ibu bekerja tidak dapat dilepaskan dari struktur kerja yang belum sepenuhnya ramah keluarga.

2. Dampak Psikososial terhadap Kesehatan dan Peran Ibu

Tantangan psikososial yang dialami ibu bekerja berdampak langsung terhadap kesehatan mental dan kapasitas fungsional ibu dalam menjalankan peran pengasuhan. Paparan stres kronis akibat konflik peran kerja–keluarga, beban kerja berlebih, dan keterbatasan dukungan sosial berhubungan dengan peningkatan kelelahan emosional, burnout, serta penurunan kesejahteraan psikologis. Bukti empiris di Indonesia menunjukkan bahwa tekanan peran ganda yang tidak terkelola berkontribusi terhadap gangguan keseimbangan emosional dan menurunnya kualitas hidup ibu bekerja, khususnya mereka yang memiliki anak usia dini(Maimunnah & Alfita, 2025). Dampak ini menegaskan bahwa masalah psikososial ibu bekerja bersifat berkelanjutan dan memengaruhi fungsi keseharian ibu.

Dampak psikososial tersebut juga meluas pada kualitas pengasuhan dan relasi ibu–anak. Stres dan kelelahan emosional yang berkepanjangan dapat menurunkan sensitivitas ibu terhadap kebutuhan anak, membatasi kualitas interaksi, serta meningkatkan risiko pola pengasuhan yang kurang responsif. Studi menunjukkan bahwa distress psikologis pada ibu bekerja berhubungan dengan penurunan keterlibatan emosional dalam pengasuhan serta meningkatnya rasa bersalah dan konflik internal dalam peran keibuan(Aizza & Hanim, 2024; Maimunnah & Alfita, 2025).

Selain itu, tantangan psikososial ibu bekerja juga berdampak pada keberlanjutan peran sosial dan produktivitas kerja. Tekanan psikososial yang berkepanjangan berhubungan dengan penurunan kinerja, meningkatnya absensi, serta risiko keluarnya perempuan dari dunia kerja secara prematur, yang pada akhirnya dapat memperlebar kesenjangan gender dan memperkuat ketidaksetaraan struktural. Dengan demikian, tantangan psikososial ibu bekerja perlu dipahami sebagai isu kesehatan masyarakat yang beririsan langsung dengan ketenagakerjaan dan pengasuhan anak.

3. Strategi Dukungan Psikososial bagi Ibu Bekerja

Strategi dukungan psikososial bagi ibu bekerja perlu dirancang adaptif terhadap kondisi kerja dan peran ganda yang dijalani ibu agar tidak menambah beban baru dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks layanan kesehatan primer, pendekatan yang fleksibel, peka terhadap status pekerjaan, serta komunikasi yang non-menghakimi berperan penting dalam menjaga akses ibu bekerja terhadap dukungan psikososial. Bukti empiris menunjukkan bahwa

pengakuan terhadap beban peran ganda dan pemberian ruang bagi ibu untuk mengekspresikan pengalaman psikososialnya berkontribusi terhadap penurunan stres dan peningkatan keterlibatan ibu bekerja dalam layanan kesehatan(Maimunnah & Alfita, 2025).

Dukungan psikososial bagi ibu bekerja juga menuntut pendekatan interprofesional yang menghubungkan layanan kesehatan dengan lingkungan kerja dan keluarga. Studi menunjukkan bahwa dukungan yang selaras dengan kebijakan *work-life balance*, termasuk fleksibilitas waktu, dukungan pengasuhan, serta keterlibatan pasangan dan keluarga dalam pembagian peran domestik, berhubungan dengan penurunan kelelahan emosional dan peningkatan kesejahteraan mental ibu bekerja(Aizza & Hanim, 2024). Dengan demikian, strategi dukungan psikososial bagi ibu bekerja perlu mencakup intervensi lintas sektor dan berbasis relasi, tidak terbatas pada pendekatan individual semata.

F. Pendekatan Interprofesional dalam Perawatan Psikososial Ibu

1. Peran Profesi Kesehatan

Profesi kesehatan memiliki peran sentral dalam mengintegrasikan pendekatan psikososial secara bermakna ke dalam pelayanan kesehatan ibu, bukan sekadar sebagai pelengkap intervensi klinis. Dalam konteks kehamilan, nifas, dan ibu bekerja, tenaga kesehatan berada pada posisi strategis untuk mengidentifikasi kebutuhan psikososial sejak dini, asalkan kesehatan mental ibu dipandang sebagai bagian integral dari asuhan dasar, sejalan dengan rekomendasi WHO.

Bidan, perawat, dan dokter layanan primer memegang peran kunci dalam deteksi dini masalah psikososial melalui hubungan terapeutik dan kontinuitas asuhan yang memungkinkan pengenalan perubahan emosional, pola coping, dan dinamika dukungan sosial ibu. Bukti menunjukkan bahwa deteksi dini gangguan kesehatan mental ibu lebih efektif ketika dilakukan oleh tenaga kesehatan lini pertama yang memiliki kedekatan relasional dengan ibu dibandingkan pendekatan yang bergantung pada rujukan spesialis semata(Howard & Khalifeh, 2020).

2. Kolaborasi Interprofesional dalam Sistem Pelayanan

Kolaborasi interprofesional merupakan elemen kunci dalam penerapan pendekatan psikososial yang efektif dalam pelayanan kesehatan ibu, mengingat kompleksitas interaksi antara aspek biologis, psikologis, dan sosial sepanjang perjalanan hidup perempuan. Masalah psikososial yang dialami ibu hamil, ibu nifas, dan ibu bekerja melampaui kapasitas satu profesi atau satu jenis layanan, sehingga menuntut keterlibatan berbagai disiplin secara terkoordinasi.

Dalam konteks pelayanan kesehatan primer, kolaborasi interprofesional mencakup kerja sama antara bidan, perawat, dokter, tenaga kesehatan jiwa, dan petugas kesehatan masyarakat dalam satu jejaring pelayanan yang terintegrasi. Setiap profesi berkontribusi dalam deteksi dini, pemberian dukungan dasar, serta rujukan dan tindak lanjut sesuai kebutuhan ibu. Bukti menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif dalam layanan perinatal berhubungan dengan peningkatan deteksi masalah kesehatan mental ibu, koordinasi perawatan yang lebih baik, dan kepuasan ibu terhadap pelayanan kesehatan (Howard & Khalifeh, 2020), menegaskan bahwa kolaborasi interprofesional merupakan mekanisme praktis untuk meningkatkan mutu layanan.

G. Implikasi bagi Kebijakan dan Praktik Pelayanan Kesehatan

Temuan dalam bab ini menegaskan bahwa pendekatan psikososial dalam perawatan ibu hamil, ibu nifas, dan ibu bekerja bukan merupakan intervensi tambahan yang bersifat opsional, melainkan komponen inti dalam sistem pelayanan kesehatan ibu. Implikasi kebijakan yang mendasar adalah perlunya pengakuan formal terhadap kesehatan mental ibu sebagai bagian integral dari pelayanan KIA, yang tercermin dalam perencanaan program, standar pelayanan, dan alokasi sumber daya. Tanpa landasan kebijakan yang jelas, pendekatan psikososial berisiko terbatas pada praktik individual tenaga kesehatan dan tidak berkelanjutan secara sistemik. Pada tataran praktik, integrasi pendekatan psikososial menuntut pergeseran paradigma layanan kesehatan ibu yang selama ini dominan berorientasi biomedis. Pelayanan kehamilan, nifas, dan pascanatal perlu secara konsisten memasukkan pemantauan kondisi psikososial sebagai bagian dari asuhan rutin di layanan primer, disertai penguatan kompetensi tenaga kesehatan dalam komunikasi empatik, deteksi dini, dan rujukan yang sensitif terhadap konteks sosial ibu. Hal ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu tidak hanya bergantung pada teknologi medis, tetapi juga pada kapasitas sistem dalam merespons kebutuhan psikososial secara berkelanjutan.

H. Simpulan

Pendekatan psikososial dalam perawatan ibu hamil, ibu nifas, dan ibu bekerja merupakan fondasi penting bagi peningkatan kesehatan ibu yang berkelanjutan dan berkeadilan. Bab ini menunjukkan bahwa kesehatan ibu tidak hanya ditentukan oleh intervensi klinis, tetapi juga oleh kemampuan sistem pelayanan kesehatan dalam merespons dinamika emosional, relasional, dan struktural yang menyertai pengalaman reproduksi dan pengasuhan perempuan. Pengabaian dimensi psikososial berisiko melemahkan capaian kesehatan ibu, meskipun intervensi medis

telah tersedia, mengingat determinan psikososial memiliki implikasi biologis dan perkembangan jangka panjang.

I. Referensi

- Aizza, N. Z., & Hanim, L. M. (2024). Work-Life Balance: Strategi Untuk Mencapai. Prosiding Seminar Nasional 2024 Psikologi, Fisib, Utm, 94–106.
- Bedaso, A., Adams, J., Peng, W., & Sibbritt, D. (2021). The Relationship Between Social Support And Mental Health Problems During Pregnancy: A Systematic Review And Meta-Analysis. *Reproductive Health*, 18(1). <https://doi.org/10.1186/s12978-021-01209-5>
- Biaggi, A., Conroy, S., Pawlby, S., & Pariante, C. M. (2016). Identifying The Women At Risk Of Antenatal Anxiety And Depression: A Systematic Review. *Journal Of Affective Disorders*, 191, 62–77. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2015.11.014>
- Cryan, J. F., O’riordan, K. J., Cowan, C. S. M., Sandhu, K. V., Bastiaanssen, T. F. S., Boehme, M., Codagnone, M. G., Cussotto, S., Fulling, C., Golubeva, A. V., Guzzetta, K. E., Jaggar, M., Long-Smith, C. M., Lyte, J. M., Martin, J. A., Molinero-Perez, A., Moloney, G., Morelli, E., Morillas, E., ... Dinan, T. G. (2019). The Microbiota-Gut-Brain Axis. *Physiological Reviews*, 99(4), 1877–2013. <https://doi.org/10.1152/physrev.00018.2018>
- Fisher, J., Cabral De Mello, M., Patel, V., Rahman, A., Tran, T., Holton, S., & Holmes, W. (2012). Systematic Reviews Prevalence And Determinants Of Common Perinatal Mental Disorders In Women In Low-And Lower-Middle-Income Countries: A Systematic Review. *Bull World Health Organ*, 90, 139–149. <https://doi.org/10.2471/blt.11.091850>
- Galley, J. D., Mashburn-Warren, L., Blalock, L. C., Lauber, C. L., Carroll, J. E., Ross, K. M., Hobel, C., Coussons-Read, M., Dunkel Schetter, C., & Gur, T. L. (2023). Maternal Anxiety, Depression And Stress Affects Offspring Gut Microbiome Diversity And Bifidobacterial Abundances. *Brain, Behavior, And Immunity*, 107(July 2022), 253–264. <https://doi.org/10.1016/j.bbi.2022.10.005>
- Gur, T. L., Shay, L., Palkar, A. V., Fisher, S., Varaljay, V. A., Dowd, S., & Bailey, M. T. (2017). Prenatal Stress Affects Placental Cytokines And Neurotrophins, Commensal Microbes, And Anxiety-Like Behavior In Adult Female Offspring. *Brain, Behavior, And Immunity*, 64, 50–58. <https://doi.org/10.1016/j.bbi.2016.12.021>
- Howard, L. M., & Khalifeh, H. (2020). Perinatal Mental Health: A Review Of Progress And Challenges. *World Psychiatry*, 19(3), 313–327. <https://doi.org/10.1002/wps.20769>

- Le Lez, J., Wootton, E., Souza, J. P., & Moran, A. C. (2025). Maternal Wellbeing: A Who Definition And Conceptual Framework. *The Lancet Obstetrics, Gynaecology, & Women's Health*, 1(1), E57–E63. <https://doi.org/10.1016/j.lanogw.2025.100017>
- Maimunnah, S., & Alfita, L. (2025). Kelelahan Emosional Pada Wanita Bekerja Yang Memiliki Anak Usia Dini. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 8(3), 7395–7400. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i3.50084>
- Mukhoirotin, M., Mutmainnah, M., Rakinaung, N. E., Widiatie, W., Paula, V., Rasyada, A., Huzaimah, N., Farkhah, L., Sapulette, B. J., & Lombogia, C. A. (2023). Psikososial Dan Budaya Dalam Keperawatan (M. J. F. Sirait (Ed.); Vol. 1). Yayasan Kita Menulis. https://repository.wiraraja.ac.id/3034/139/Dok_2_Psikososial_Budaya_dalam_Keperawatan_Pada_Bab_8_Penghormatan_Budaya_Dalam_Praktek_Keperawatan.Pdf
- National Institute For Health And Care Excellence (Nice). (2020). Antenatal And Postnatal Mental Health: Clinical Management And Service Guidance. *Essentially Midwifery*, 6(1), 14. www.nice.org.uk/guidance/cg192%0ahttp://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cin20&an=2012910556&site=ehost-live
- Nyoman, N., Desy Sekarini, A., Pratiwi, P. I., & Setiawan, H. (2025). Kebutuhan Psikososial Ibu Hamil Dalam Mencegah Hipertensi Kehamilan: Studi Eksploratif Psychosocial Needs Of Pregnant Women For The Prevention Of Hypertensive Disorders Of Pregnancy (Hdp): An Exploratory Study. *Indonesian Journal Of Midwifery*, 8(2), 178–187. <http://jurnal.unw.ac.id/index.php/ijm>
- O'hara, M. W., & McCabe, J. E. (2013). Postpartum Depression: Current Status And Future Directions. *Annual Review Of Clinical Psychology*, 9(Volume 9, 2013), 379–407. <https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-050212185612/cite/refworks>
- Parwati, N. W. M., & Wulandari, I. A. (2025). Dukungan Keluarga Terhadap Psikologis Ibu Nifas (Vol. 32, Issue 3). Nuansa Fajar Cemerlang. <https://repository.nuansafajarcemerlang.com/media/publications/592818-Dukungan-Keluarga-Terhadap-Psikologis-Ib-5786e02a.pdf>
- Sofia, R., Obstetri Dan Ginekologi, B., Parasitologi, B., & Corresponding Author, F. (2019). Hubungan Stresor Psikososial Pada Kehamilan Dengan Komplikasi Persalinan Di Wilayah Kerja Puskesmas Lapang Aceh Utara. *Averrous: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Malikussaleh*, 5(1), 37–51. <https://doi.org/10.29103/averrous.v5i1.1627>

- Sundari, S. W., Windiyani, W., Novayanti, N., Ratri, R., Purnamasari, F., & Sri, S. (2025). Social Support Campaign As An Effort To Fulfill Psychological Needs In Pregnant, Childbirth, And Postpartum Mothers. *Community Empowerment*, 10(5), 1203–1211. <https://doi.org/10.31603/Ce.12959>
- Suryaningsih, C., & Kep, S. (2024). Psikososial Dalam Budaya Keperawatan. [www.Mediapustakaindo.Com](http://www.Mediapustakaindo.com)
- Tamburini, S., Shen, N., Wu, H. C., & Clemente, J. C. (2016). The Microbiome In Early Life: Implications For Health Outcomes. *Nature Medicine*, 22(7), 713–722. <https://doi.org/10.1038/Nm.4142>
- Tilahune, A., Peng, W., Adams, J., & Sibbritt, D. (2022). Social Support And Prenatal Mental Health Problems: A Systematic Review And Meta-Analysis. *European Psychiatry*, 65(S1), S105–S105. <https://doi.org/10.1192/J.Eurpsy.2022.300>
- Who. (2025). Trends In Maternal Mortality 2000 To 2023: Estimates By Who, Unicef, Unfpa, World Bank Group And Undesa/Population Division. Who. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240108462>
- Zannah, A. N., Zalika, L. K., Astiti, A. D., & Septiyono, E. A. (2024). Sosialisasi Pentingnya Kesehatan Mental Ibu Hamil Dengan Slogan “Suami” Dijaga Ibu Hamil Sejahtera. *Jurnal Sadewa*, 2(02), 82–87. <https://doi.org/10.36858/Js.V2i2.813>

J. Glosarium

Adaptasi psikososial

Proses penyesuaian ibu terhadap perubahan emosi, identitas, peran, dan relasi sosial pada masa kehamilan, nifas, hingga kembali bekerja.

Baby blues

Perubahan suasana hati ringan pada ibu setelah melahirkan (misalnya mudah menangis, cemas, emosional) yang umumnya muncul pada minggu pertama dan bersifat sementara.

Critical window

Periode waktu kritis dalam perkembangan (misalnya masa kehamilan atau awal kehidupan bayi) ketika paparan tertentu dapat memberi dampak jangka panjang pada kesehatan.

Depresi postpartum

Gangguan depresi yang terjadi setelah melahirkan, ditandai sedih berkepanjangan, kehilangan minat, rasa bersalah, hingga gangguan fungsi pengasuhan.

Deteksi dini

Upaya mengenali tanda awal masalah kesehatan (termasuk masalah psikososial/mental) sedini mungkin agar intervensi dapat dilakukan lebih cepat.

Gangguan kesehatan mental perinatal

Masalah kesehatan mental yang terjadi pada masa kehamilan hingga setelah persalinan, seperti kecemasan dan depresi.

Hipertensi kehamilan

Tekanan darah tinggi yang muncul selama kehamilan dan berpotensi menimbulkan komplikasi pada ibu maupun janin.

Hubungan terapeutik

Relasi profesional antara tenaga kesehatan dan pasien yang ditandai empati, kepercayaan, komunikasi efektif, dan dukungan yang aman.

Ibu nifas

Perempuan pada masa setelah melahirkan hingga kurang lebih 6 minggu, masa pemulihan fisik dan penyesuaian psikologis serta sosial.

Kualitas hidup

Tingkat kesejahteraan seseorang dilihat dari aspek fisik, psikologis, sosial, dan fungsi sehari-hari.

Layanan kesehatan primer

Pelayanan kesehatan tingkat pertama (misalnya puskesmas/klinik) yang menjadi pintu masuk utama masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan.

Maternal–fetal attachment

Keterikatan emosional ibu terhadap janin selama kehamilan yang berpengaruh pada kesiapan menjadi ibu dan relasi ibu–anak setelah lahir.

CHAPTER 8

STRATEGI PROMOSI KESEHATAN DIGITAL UNTUK EDUKASI KIA DAN REMAJA

Sri Musfiroh, S.Si.T., M.Kes.

A. Pendahuluan / Prolog

Dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal, promosi kesehatan melalui pendekatan digital menjadi semakin esensial di era teknologi saat ini, khususnya untuk mendukung edukasi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) serta remaja yang menghadapi berbagai risiko seperti gangguan nutrisi, kesehatan reproduksi, dan dampak gaya hidup modern. Promosi kesehatan pada intinya merupakan proses penyampaian pesan kesehatan secara efektif kepada masyarakat, kelompok, atau individu guna memicu perubahan perilaku yang berkelanjutan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024). Berbagai pendekatan seperti medis, perilaku, atau berorientasi pada klien; model teori seperti Health Belief Model (HBM) dan Social Cognitive Theory; serta strategi advokasi, kemitraan lintas sektor, dan pemberdayaan masyarakat dapat dimanfaatkan. Elemen-elemen ini memerlukan komunikasi interaktif, di mana media digital seperti aplikasi mobile, media sosial, dan konten multimedia berperan vital untuk menyampaikan pesan secara menarik dan tepat sasaran, terutama bagi remaja yang aktif secara digital serta kelompok KIA yang membutuhkan pemantauan berkelanjutan (Setyowati & Mahmudah, 2021).

Di Indonesia, promosi kesehatan digital telah terintegrasi dalam strategi nasional untuk mengatasi kesenjangan akses informasi, terutama pada kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan remaja yang rawan terhadap isu kesehatan reproduksi serta pencegahan penyakit tidak menular. Teknologi digital tidak hanya digunakan untuk penyebaran edukasi, tetapi juga pemantauan perilaku kesehatan secara real-time melalui platform seperti aplikasi SATUSEHAT atau media sosial, sehingga meningkatkan keterlibatan masyarakat (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2025a). Contohnya, penggunaan konten interaktif di media sosial efektif meningkatkan literasi kesehatan remaja mengenai bahaya merokok dan kesehatan reproduksi, dengan mengatasi hambatan akses tradisional melalui elemen visual dan personalisasi (Hidayah, 2025). Sementara untuk KIA, aplikasi mobile seperti m-KIA memfasilitasi pemantauan tumbuh kembang anak dan edukasi nutrisi, mendukung pencegahan stunting di tengah pengaruh gadget yang dominan (Diani

et al., 2022). Pendekatan ini semakin relevan dengan penetrasi internet yang tinggi di kalangan remaja Indonesia, memungkinkan promosi kesehatan lebih efisien dan inklusif dibandingkan metode konvensional (Mustofa & Sani, 2024).

Berdasarkan kerangka kebijakan nasional terkini, promosi kesehatan diimplementasikan melalui penyusunan kebijakan publik berbasis kesehatan, pembentukan lingkungan pendukung, penguatan komunitas, pengembangan kemampuan individu, serta penyelarasan layanan dengan transformasi digital. Hal ini tertuang dalam Buku Kebijakan Nasional Promosi Kesehatan, yang menekankan pemberdayaan masyarakat, advokasi, dan kemitraan didukung metodologi inovatif, media digital, data bukti, serta sumber daya manusia profesional (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024). Kebijakan ini selaras dengan RPJMN 2025-2029 yang memprioritaskan kesehatan usia produktif dan remaja melalui platform digital untuk menurunkan stunting serta masalah reproduksi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2025b).

Perkembangan promosi kesehatan digital di Indonesia menunjukkan kemajuan pesat, dengan media sosial dan aplikasi sebagai alat utama edukasi KIA dan remaja. Intervensi digital seperti aplikasi kesehatan reproduksi terbukti meningkatkan pengetahuan dan perilaku sehat remaja secara lebih engaging, mengatasi stigma sosial dalam diskusi kesehatan (Pratiwi & Sari, 2025). Pada KIA, strategi digital holistik membantu mengelola dampak gadget terhadap kesehatan mental ibu dan anak, termasuk edukasi penggunaan layar aman serta monitoring nutrisi (Wulandari, 2025). Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi WHO untuk negara berkembang, namun disesuaikan dengan konteks Indonesia guna memastikan efektivitas dan inklusivitas (Rabbani, 2025).

B. Definisi Proposi Kesehatan

Promosi kesehatan merupakan proses pemberdayaan individu, kelompok, dan masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam upaya meningkatkan kesehatan melalui berbagai metode yang terintegrasi, termasuk pendekatan edukatif, advokasi, serta dukungan lingkungan yang kondusif (World Health Organization, 1986). Pendekatan ini bersifat holistik dan multidimensi, memastikan intervensi dilakukan di semua lapisan masyarakat untuk mencapai hasil kesehatan yang lebih baik dan berkelanjutan, khususnya dalam konteks era digital di mana teknologi seperti media sosial dan aplikasi mobile menjadi alat utama untuk menyebarkan informasi kesehatan kepada kelompok rentan seperti ibu hamil, anak, dan remaja (Susanto, 2024).

Promosi kesehatan telah berkembang dari sekadar pendidikan kesehatan tradisional menjadi strategi komprehensif yang mencakup penyuluhan, komunikasi

informasi dan edukasi (KIE), serta intervensi lintas sektor seperti kebijakan hukum, ekonomi, lingkungan, dan organisasi untuk mencegah penyakit serta meningkatkan kualitas hidup (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024). Di era digital saat ini, promosi kesehatan semakin mengintegrasikan teknologi informasi, seperti platform media sosial dan aplikasi kesehatan, untuk meningkatkan literasi kesehatan remaja dan ibu dalam bidang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), sehingga memfasilitasi perubahan perilaku yang lebih cepat dan inklusif (Hidayah, 2025; Pratiwi & Sari, 2025).

Menurut kerangka nasional Indonesia, promosi kesehatan didefinisikan sebagai proses menginformasikan, memengaruhi, dan memberdayakan masyarakat agar berperan aktif dalam mengubah perilaku serta lingkungan guna memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan optimal melalui berbagai kegiatan promotif dan preventif (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024). Definisi ini selaras dengan perkembangan global, di mana promosi kesehatan digital memanfaatkan tools seperti konten interaktif untuk edukasi KIA dan pencegahan risiko pada remaja, seperti kesehatan reproduksi dan nutrisi (Wulandari, 2025).

Secara internasional, World Health Organization (WHO) pada Ottawa Charter tahun 1986 merumuskan promosi kesehatan sebagai proses yang memungkinkan individu dan masyarakat meningkatkan kontrol atas faktor-faktor penentu kesehatan, sehingga dapat memperbaiki derajat kesehatan mereka secara keseluruhan (World Health Organization, 1986). Rumusan ini tetap menjadi fondasi utama hingga kini, dan semakin relevan di era digital dengan penekanan pada health literacy serta penggunaan teknologi untuk pemberdayaan masyarakat dalam mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), termasuk edukasi kesehatan bagi kelompok KIA dan remaja di negara berkembang seperti Indonesia (World Health Organization, 2016).

C. Definisi Promosi Kesehatan Digital

Promosi kesehatan digital merupakan adaptasi dari konsep promosi kesehatan tradisional ke dalam ranah teknologi informasi dan komunikasi, di mana pemanfaatan platform digital seperti media sosial, aplikasi mobile, dan konten multimedia digunakan untuk menyampaikan pesan kesehatan secara interaktif dan luas jangkauannya, khususnya kepada kelompok rentan seperti ibu hamil, anak, serta remaja yang aktif secara online (World Health Organization, 2020). Pendekatan ini memungkinkan pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi real-time, sehingga meningkatkan literasi kesehatan dan mendorong perubahan perilaku positif dalam edukasi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) serta pencegahan risiko pada remaja, seperti kesehatan reproduksi dan nutrisi (Mustofa & Sani, 2024).

Menurut perspektif global, promosi kesehatan digital didefinisikan sebagai aplikasi sistematis teknologi informasi, komunikasi, dan data untuk mendukung pengambilan keputusan yang informed oleh individu, tenaga kesehatan, serta sistem kesehatan secara keseluruhan, guna memperkuat ketahanan terhadap penyakit dan meningkatkan kesejahteraan (World Health Organization, 2023). Di Indonesia, konsep ini semakin relevan dengan transformasi digital kesehatan melalui platform seperti SATUSEHAT, yang mengintegrasikan edukasi preventif untuk KIA dan remaja, termasuk pemantauan stunting serta kampanye kesehatan reproduksi melalui aplikasi dan media sosial (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024).

Promosi kesehatan digital di Indonesia sering kali memanfaatkan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan TikTok sebagai sarana utama untuk intervensi edukasi, yang terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap positif remaja terhadap kesehatan reproduksi serta ibu terhadap gizi anak (Afriani et al., 2025). Strategi ini tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga memfasilitasi interaksi dua arah, seperti grup diskusi online, yang membantu mengatasi hambatan akses geografis dan stigma sosial dalam topik sensitif seperti kesehatan seksual remaja atau pencegahan stunting pada anak (Rahmadini & Ernawaty, 2024; Rabbani, 2025).

Lebih lanjut, promosi kesehatan digital menekankan pada inklusivitas dan personalisasi konten, di mana aplikasi e-health berbasis standar WHO digunakan untuk edukasi ibu dan anak, termasuk monitoring tumbuh kembang serta pencegahan risiko di era gadget (Rabbani, 2025). Pendekatan ini selaras dengan strategi nasional transformasi kesehatan digital, yang bertujuan menciptakan ekosistem terpadu untuk promosi preventif bagi kelompok KIA dan remaja, sehingga mendukung pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) di bidang kesehatan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024).

D. Manfaat Promosi Kesehatan Digital untuk Edukasi KIA dan Remaja

Promosi kesehatan digital memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan aksesibilitas informasi kesehatan bagi kelompok Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) serta remaja, terutama melalui platform yang mudah dijangkau seperti aplikasi mobile dan media sosial, sehingga memungkinkan penyebaran edukasi secara cepat dan inklusif di berbagai wilayah Indonesia (World Health Organization, 2020). Manfaat utama meliputi peningkatan literasi kesehatan, di mana konten interaktif seperti video edukatif dan infografis membantu ibu memahami nutrisi anak serta pencegahan stunting, sementara remaja mendapatkan pemahaman lebih baik tentang kesehatan reproduksi tanpa hambatan stigma sosial (Mustofa & Sani, 2024).

Di bidang edukasi KIA, promosi digital melalui aplikasi seperti SATUSEHAT atau grup WhatsApp terbukti efektif meningkatkan pengetahuan ibu tentang pemberian MP-ASI (Makanan Pendamping ASI) yang bergizi, sehingga mendukung pertumbuhan optimal anak dan mengurangi risiko malnutrisi (Afriani et al., 2024). Sementara untuk remaja, kampanye digital seperti penggunaan Instagram atau TikTok dapat menurunkan angka kehamilan tidak diinginkan dengan meningkatkan kesadaran tentang kontrasepsi dan pencegahan infeksi menular seksual (IMS), serta mendorong sikap positif terhadap perilaku sehat (Hidayah, 2025; Pratiwi & Sari, 2025).

Lebih lanjut, promosi kesehatan digital memfasilitasi interaksi dua arah, seperti sesi tanya jawab online atau chatbot, yang membuat edukasi lebih personal dan engaging, sehingga meningkatkan retensi pengetahuan serta perubahan perilaku jangka panjang pada remaja terkait bahaya merokok atau kesehatan mental di era gadget (Octaviana et al., 2024). Pendekatan ini juga hemat biaya dan luas jangkauannya, terutama bagi remaja di daerah pedesaan yang memiliki akses internet tinggi, sehingga mendukung pencapaian target nasional pencegahan stunting dan kesehatan reproduksi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024).

Secara keseluruhan, manfaat promosi kesehatan digital tidak hanya terbatas pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat untuk mengambil keputusan kesehatan yang informed, selaras dengan strategi global WHO untuk memanfaatkan teknologi dalam mengatasi isu kesehatan pada kelompok rentan seperti ibu dan remaja (World Health Organization, 2023).

E. Macam-Macam Promosi Kesehatan Digital untuk Edukasi KIA dan Remaja

Promosi kesehatan digital untuk edukasi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) serta remaja dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam utama, yang masing-masing memiliki karakteristik, definisi, dan penerapan spesifik untuk meningkatkan literasi kesehatan serta mendorong perubahan perilaku positif melalui teknologi informasi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024; World Health Organization, 2020). Berikut adalah macam-macam promosi kesehatan digital beserta definisinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan edukasi KIA (seperti nutrisi ibu hamil, pencegahan stunting, dan tumbuh kembang anak) serta remaja (seperti kesehatan reproduksi, pencegahan IMS, dan gaya hidup sehat).

1. Promosi melalui Media Sosial

Promosi kesehatan digital melalui media sosial didefinisikan sebagai penggunaan platform seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan Twitter/X untuk menyebarkan konten kesehatan dalam bentuk postingan, reel, story, atau live

streaming yang interaktif dan visual (Afriani et al., 2025). Macam ini efektif untuk remaja karena konten pendek dan trending dapat meningkatkan kesadaran tentang kesehatan reproduksi serta bahaya merokok, sementara bagi KIA digunakan untuk kampanye nutrisi dan imunisasi melalui grup atau akun resmi kesehatan (Rahmadini & Ernawaty, 2024; Mustofa & Sani, 2024).

2. Promosi melalui Aplikasi Mobile (Mobile Health/mHealth)

Aplikasi mobile untuk promosi kesehatan digital adalah perangkat lunak berbasis smartphone yang menyediakan fitur edukasi, monitoring, dan reminder kesehatan, seperti aplikasi SATUSEHAT, Buku KIA Digital, atau app khusus reproduksi remaja (Pratiwi & Sari, 2025). Definisi ini mencakup tools yang memungkinkan pengguna memantau sendiri kesehatan, seperti tracking kehamilan, pertumbuhan anak untuk KIA, atau modul edukasi kontrasepsi dan pencegahan IMS bagi remaja, dengan keunggulan akses offline dan personalisasi (Rabbani, 2025; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

3. Promosi melalui Konten Video dan Multimedia

Konten video dan multimedia dalam promosi kesehatan digital merujuk pada penggunaan video animasi, webinar, podcast, atau infografis interaktif yang diunggah di YouTube, TikTok, atau platform streaming untuk menyampaikan informasi kesehatan secara naratif dan menarik (Hidayah, 2025). Macam ini sangat cocok untuk edukasi KIA tentang pemberian MP-ASI dan kesehatan mental ibu, serta bagi remaja untuk topik sensitif seperti kesehatan seksual, karena format visual membantu mengatasi kebosanan dan meningkatkan retensi informasi (Wulandari, 2025; Susanto, 2024).

4. Promosi melalui Telemedicine dan Konsultasi Online

Telemedicine sebagai bentuk promosi kesehatan digital didefinisikan sebagai layanan konsultasi jarak jauh melalui video call, chat, atau chatbot yang tidak hanya untuk diagnosis tetapi juga edukasi preventif (World Health Organization, 2023). Untuk KIA, ini mencakup konsultasi online tentang kehamilan dan imunisasi anak; bagi remaja, digunakan untuk diskusi rahasia tentang kesehatan reproduksi dan mental health, sehingga mengurangi stigma dan meningkatkan akses di daerah terpencil (Octaviana et al., 2024).

5. Promosi melalui Kampanye Digital dan Gamifikasi

Kampanye digital dengan elemen gamifikasi adalah promosi kesehatan yang menggunakan challenge, quiz interaktif, atau reward virtual di platform digital untuk mendorong partisipasi aktif (Afriani et al., 2025). Definisi ini meliputi kolaborasi dengan influencer untuk kampanye pencegahan stunting pada KIA atau anti-rokok pada remaja, di mana elemen permainan seperti poin dan badge

meningkatkan engagement dan perubahan perilaku jangka panjang (Pratiwi & Sari, 2025).

Pemilihan macam promosi digital ini harus disesuaikan dengan karakteristik target, seperti usia digital native pada remaja dan kebutuhan praktis ibu dalam KIA, untuk memaksimalkan dampak edukasi kesehatan di Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024).

F. Strategi Promosi Kesehatan Digital untuk Edukasi KIA dan Remaja

Strategi promosi kesehatan digital yang efektif melibatkan pemilihan platform yang sesuai dengan target audiens, seperti Instagram dan TikTok untuk remaja yang menyukai konten visual pendek, serta WhatsApp atau aplikasi mobile untuk ibu dalam kelompok KIA yang membutuhkan komunikasi grup yang praktis (Afriani et al., 2025). Strategi ini mencakup pembuatan konten interaktif seperti video animasi, infografis, dan live session untuk meningkatkan engagement dan pemahaman tentang topik sensitif seperti kesehatan reproduksi remaja atau monitoring nutrisi anak (Mustofa & Sani, 2024).

Contoh strategi sukses di Indonesia adalah penggunaan grup WhatsApp untuk edukasi MP-ASI bagi ibu balita, yang terbukti meningkatkan pengetahuan gizi secara signifikan melalui sharing resep dan tips harian (Afriani et al., 2024). Untuk remaja, kampanye melalui Instagram dengan kolaborasi influencer atau tokoh digital efektif dalam promosi kesehatan reproduksi, seperti pencegahan IMS dan kehamilan dini, dengan elemen gamifikasi atau challenge untuk mendorong partisipasi aktif (Pratiwi & Sari, 2025; Rahmadini & Ernawaty, 2024).

Strategi lain yang direkomendasikan adalah pengembangan aplikasi khusus, seperti e-health berbasis Android untuk monitoring KIA atau edukasi interaktif remaja, yang mengintegrasikan fitur chatbot dan reminder untuk pemantauan kesehatan rutin, sehingga mendukung pencegahan stunting dan masalah reproduksi (Rabbani, 2025). Pendekatan ini harus didukung oleh kolaborasi lintas sektor, termasuk Kementerian Kesehatan dengan influencer dan komunitas online, untuk memastikan konten berbasis bukti dan budaya lokal (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024).

Untuk keberlanjutan, strategi promosi digital perlu mencakup evaluasi berkala melalui metrik engagement dan survei perubahan perilaku, serta integrasi dengan platform nasional seperti SATUSEHAT, guna menciptakan ekosistem edukasi kesehatan yang terpadu bagi KIA dan remaja di era transformasi digital (World Health Organization, 2023).

G. Simpulan

Promosi kesehatan merupakan proses pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kontrol terhadap faktor penentu kesehatan melalui edukasi, advokasi, kemitraan lintas sektor, dan penciptaan lingkungan yang mendukung. Dalam konteks perkembangan teknologi, promosi kesehatan digital menjadi adaptasi yang semakin relevan karena mampu menyampaikan pesan kesehatan secara cepat, luas, interaktif, dan lebih sesuai dengan karakteristik pengguna saat ini, khususnya kelompok Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) serta remaja yang sangat dekat dengan media digital. Integrasi promosi kesehatan digital juga selaras dengan arah kebijakan nasional dan transformasi sistem kesehatan, termasuk penguatan layanan promotif-preventif serta pemanfaatan platform kesehatan digital untuk menjangkau kelompok rentan secara lebih merata.

Pemanfaatan promosi kesehatan digital memberikan manfaat nyata, antara lain meningkatkan akses informasi, literasi kesehatan, dan keterlibatan pengguna melalui konten visual-interaktif, komunikasi dua arah, serta pemantauan perilaku kesehatan secara lebih berkelanjutan. Bagi KIA, pendekatan digital mendukung edukasi gizi, pencegahan stunting, pemantauan tumbuh kembang, serta penguatan praktik pengasuhan dan kesehatan mental ibu. Sementara bagi remaja, promosi digital dapat membantu edukasi kesehatan reproduksi, pencegahan IMS dan kehamilan tidak diinginkan, serta isu gaya hidup sehat dan kesehatan mental, termasuk mengurangi stigma karena akses informasi dapat dilakukan secara lebih privat dan nyaman.

Bentuk promosi kesehatan digital yang dapat diterapkan meliputi media sosial, aplikasi mobile (mHealth), konten video dan multimedia, telemedicine atau konsultasi online, serta kampanye digital berbasis gamifikasi. Agar efektif, strategi pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan target audiens (platform yang tepat), menggunakan konten yang menarik dan berbasis bukti, melibatkan kolaborasi lintas sektor (tenaga kesehatan, pemerintah, komunitas, influencer), serta didukung evaluasi berkala melalui indikator keterjangkauan, keterlibatan, dan perubahan pengetahuan maupun perilaku. Dengan penerapan yang terencana dan terintegrasi, promosi kesehatan digital berpotensi menjadi pilar penting dalam peningkatan kualitas kesehatan KIA dan remaja secara berkelanjutan di era transformasi digital.

H. Referensi

- Afriani, D. A., Mentari, W. D., & Azahra, Z. (2025). Peran media sosial dalam promosi kesehatan: Tinjauan literatur 2019-2024. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Kesehatan*, 4(2), 1–15. <https://prin.or.id/index.php/JURRIKES/article/download/5498/4162/18451>
- Diani, P. A., Diani, P. W., Asnawiyah, D., Nurfadilah, N., Fitria, N., & Rohita, R. (2022). Pemanfaatan Mobile-Kesehatan Ibu Anak untuk Memantau Tumbuh Kembang Anak Usia Dini. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 3(2), 1–10.
- Hidayah, N. (2025). The effectiveness of digital media in improving adolescent health literacy about the dangers of smoking: Literature review. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/385236988_The_Effectiveness_of_Digital_Media_in_Improving_Adolescent_Health_Literacy_about_the_Dangers_of_Smoking_Literature_Review
- Hidayah, N. (2025). The effectiveness of digital media in improving adolescent health literacy about the dangers of smoking: Literature review. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/385236988_The_Effectiveness_of_Digital_Media_in_Improving_Adolescent_Health_Literacy_about_the_Dangers_of_Smoking_Literature_Review
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). Buku Kebijakan Nasional Promosi Kesehatan. Ayo Sehat. <https://ayosehat.kemkes.go.id/buku-kebijakan-nasional-promosi-kesehatan>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). Buku Kebijakan Nasional Promosi Kesehatan. Ayo Sehat. <https://ayosehat.kemkes.go.id/buku-kebijakan-nasional-promosi-kesehatan>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). Strategi Transformasi Kesehatan Digital 2024. Kemenkes RI. <https://kemkes.go.id>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025a). Digital Health Transformation Strategy (DHTS) 2.0. Kemenkes Resource Center. <https://rc.kemkes.go.id/news/dhts-2-0-menuju-ekosistem-kesehatan-digital-terpadu>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025b). Indikator Promkes Menurut RPJMN Kemenkes 2025-2029. Dinas Kesehatan Aceh Timur.

https://dinkes.acehtimurkab.go.id/media/2025.05/indikator_promkes_menurut_rpjmn_kemenkes_2025-20291.pdf

- Mustofa, R. A. B., & Sani, M. (2024). Efektivitas promosi kesehatan melalui media sosial dalam mendorong perilaku hidup sehat pada remaja. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(3), 212–223.
- Mustofa, R. A. B., & Sani, M. (2024). Efektivitas promosi kesehatan melalui media sosial dalam mendorong perilaku hidup sehat pada remaja. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(3), 212–223. <https://doi.org/10.62383/sosial.v1i3.484>
- Pratiwi, R., & Sari, N. (2025). Pengembangan aplikasi kesehatan reproduksi dan seksual untuk remaja. In *Book Chapter Maternitas* (pp. 28–88). OptimalbyNFC.
- Pratiwi, R., & Sari, N. (2025). Pengembangan aplikasi kesehatan reproduksi dan seksual untuk remaja. In *Book Chapter Maternitas* (pp. 28–88). OptimalbyNFC.
- Rabbani, A. (2025). E-Health untuk Ibu dan Anak: Solusi Pintar di Era Digital Berdasarkan Standar WHO. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. <https://fikes.umsida.ac.id/e-health-untuk-ibu-dan-anak/>
- Rabbani, A. (2025). E-Health untuk ibu dan anak: Solusi pintar di era digital berdasarkan standar WHO. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. <https://fikes.umsida.ac.id/e-health-untuk-ibu-dan-anak/>
- Rahmadini, S., & Ernawaty, E. (2024). Penggunaan media sosial sebagai alat pemasaran terhadap kesadaran kesehatan reproduksi remaja. *JKM (Jurnal Kesehatan Masyarakat) Cendekia Utama*, 12(3), 274–287.
- Setyowati, D., & Mahmudah, A. I. (2021). Peningkatan Literasi Kesehatan Remaja melalui Media Digital. *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education*, 9(1), 12–19. <https://doi.org/10.20473/jpk.v9.i1.2021.12-19>
- Susanto, A. (2024). Promosi Kesehatan Era Digital. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/384738125_Promosi_Kesehatan_Era_Digital

- World Health Organization. (1986). Ottawa Charter for Health Promotion. <https://www.who.int/teams/health-promotion/enhanced-wellbeing/first-global-conference>
- World Health Organization. (2016). Shanghai Declaration on promoting health in the 2030 Agenda for Sustainable Development. <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-NMH-PND-17.5>
- World Health Organization. (2020). Global strategy on digital health 2020-2025. WHO. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240020924>
- World Health Organization. (2023). Classification of digital interventions, services and applications in health. WHO. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240079922>
- Wulandari, D. (2025). Tantangan kesehatan ibu dan anak di era digital. Repository Penerbit Eureka. <https://repository.penerbiteureka.com/media/publications/569660-tantangan-kesehatan-ibu-dan-anak-di-era-bbbb9ec2.pdf>.
- Wulandari, D. (2025). Tantangan kesehatan ibu dan anak di era digital. Repository Penerbit Eureka. <https://repository.penerbiteureka.com/media/publications/569660-tantangan-kesehatan-ibu-dan-anak-di-era-bbbb9ec2.pdf>

I. Glosarium

KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) = Program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu hamil, bersalin, nifas, menyusui, serta anak balita guna menurunkan angka kematian ibu dan anak.

Promosi Kesehatan = Proses pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan melalui edukasi, advokasi, dan dukungan lingkungan kondusif.

Promosi Kesehatan Digital = Promosi kesehatan menggunakan teknologi digital seperti media sosial dan aplikasi mobile untuk menyampaikan pesan kesehatan secara interaktif.

mHealth (Mobile Health) = Penggunaan aplikasi smartphone untuk edukasi, monitoring, dan reminder kesehatan.

SATUSEHAT = Platform kesehatan digital nasional Indonesia untuk integrasi data dan edukasi kesehatan.

Stunting = Gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, menyebabkan tinggi badan di bawah standar.

MP-ASI = Makanan Pendamping ASI yang diberikan kepada bayi mulai usia 6 bulan untuk memenuhi kebutuhan gizi.

IMS = Infeksi Menular Seksual, seperti HIV/AIDS dan sifilis, yang ditularkan melalui hubungan seksual.

Literasi Kesehatan = Kemampuan memperoleh, memahami, dan menggunakan informasi kesehatan untuk keputusan yang tepat.

Gamifikasi = Penerapan elemen permainan (poin, challenge) dalam promosi kesehatan untuk meningkatkan partisipasi.

Telemedicine = Layanan konsultasi kesehatan jarak jauh melalui video call atau chat.

Health Belief Model (HBM) = Model teori yang menjelaskan perubahan perilaku kesehatan berdasarkan persepsi kerentanan dan manfaat tindakan.

Social Cognitive Theory = Teori interaksi antara faktor pribadi, perilaku, dan lingkungan dalam pembelajaran kesehatan.

Ottawa Charter = Dokumen WHO 1986 yang merumuskan promosi kesehatan sebagai pemberdayaan kontrol atas faktor kesehatan.



PROFIL PENULIS



Yayuk Puji Lestari., SST., Bdn., M.Keb. Penulis Lahir di Ngawi, 18 September 1992. menyelesaikan pendidikan Diploma III Kebidanan di Akademi Kebidanan Sari Mulia pada tahun 2013. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan Diploma IV Bidan Pendidik di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin dan lulus pada tahun 2014. Untuk memperdalam keilmuan di bidang kebidanan, penulis menempuh pendidikan Magister Kebidanan (S2) di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta dan menyelesaikannya pada tahun 2021. Penulis juga telah menyelesaikan Pendidikan Profesi Bidan di Universitas Sari Mulia pada tahun 2023. Sejak tahun 2015, penulis aktif sebagai dosen kebidanan dan hingga saat ini mengajar di Universitas Sari Mulia Banjarmasin. Dalam menjalankan perannya sebagai pendidik, penulis memiliki ketertarikan pada bidang kehamilan, asuhan kebidanan komplementer, pengantar praktik kebidanan, keselamatan pasien, asuhan kebidanan berbasis bukti, serta pengembangan kompetensi mahasiswa kebidanan. Selain mengajar, penulis juga aktif dalam penulisan dan publikasi buku ajar serta artikel ilmiah pada jurnal nasional dan internasional sebagai bentuk kontribusi dalam pengembangan ilmu kebidanan.



Subriah, S.ST., M.Kes. lahir di Polmas, 17 Juni 1975. Penulis memiliki minat yang mendalam dalam bidang kesehatan dan telah menempuh pendidikan di berbagai institusi, antara lain Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) Depkes Ujung Pandang, Program Pendidikan Bidan (PPB) Depkes Ujung Pandang, Akademi Kebidanan Makassar, DIV Bidan Pendidik Poltekkes Kemenkes Makassar, S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia, dan S2 Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar.

Riwayat Pekerjaan: Tahun 1994-1997 Bertugas sebagai Bidan PTT di Kabupaten Polmas, tahun 2001 mengabdikan diri di Klinik Bersalin Dian Fatmawati Kabupaten Sidrap, tahun 2002 mulai mengabdikan diri di Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Makassar, dan pada tahun 2016 hingga saat ini sebagai Dosen Tetap Pada Jurusan yang sama.

Motto: "Whoever strives, succeeds." (Man jadda wa jada)



PROFIL PENULIS



Anggun Fajar Ramadhani, S.Kep., Ners., M.kep. Lahir di Jakarta, 18 Juni 1984. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Gadjah Mada tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Universitas Gadjah Mada dan lulus tahun pada tahun 2017. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2019 sebagai dosen. Saat ini penulis bekerja di Universitas Muhammadiyah Sukabumi mengampu mata kuliah Keperawatan anak sehat dan sakit akut dan Farmakologi Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, pembicara pada kegiatan pengabdian masyarakat dan penelitian. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: anggunfajar@ummi.co.id



Ety Nurhayayati, S.Kp.,M.Kep.,Ns.Sp.Kep.Mat. Lahir di Jakarta, 14 Oktober 1975. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Fakultas Ilmu Keperawatan (FIK_UI), Universitas Indonesia lulus tahun 2001. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2016 dan melanjutkan pendidikan Program Spesialis Keperawatan Maternitas, Universitas Indonesia lulus tahun 2017. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1997-1998 perawat pelaksana di RSPAD Gatot Soebroto. 2001-2004 staf dosen di AKPER Mandiri Jakarta. 2004-2007 staf dosen di AKPER Karya Husada 2007-2009. 2009-2010 diklat RS Ananda Bekasi. 2010-2015 staf dosen AKPER Fatmawati. Sejak 2015 sampai Saat ini penulis bekerja di Universitas Esa Unggul mengampu mata kuliah Keperawatan Maternitas, Keperawatan Kesehatan Reproduksi, Kebutuhan Dasar Manusia, dan Keterampilan Dasar Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, Edukator, Konselor Laktasi, dan Konselor Remaja. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: etynurhayati1410@gmail.com

Motto: "Semangat hari ini adalah keberhasilan esok hari. Dengan ilmu kita memahami, dengan semangat kita bertahan, dengan keberkahan kita memberi makna"



PROFIL PENULIS



Dewi Sari Rochmayani, S.Si.T, M.Kes (Epid) Lahir di Semarang, 07 Oktober 1980. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 Akademi Kebidanan Panti Wilasa Semarang Tahun 2002, jenjang D4 pada Program Studi Kebidanan, STIKES Ngudi Waluyo tahun 2003. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Diponegoro dan lulus tahun pada tahun 2009. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2002 bekerja di Klinik Bidan Praktek Swasta. Saat ini penulis bekerja di Universitas Widya Husada Semarang dari tahun 2004-sekarang, mengampu mata kuliah Promosi Kesehatan, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Epidemiologi, Ilmu Komunikasi, Ilmu Sosial Budaya Dasar, Kesehatan Reproduksi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi di jurnal Nasional terakreditasi kemenristekdikti, publikasi di jurnal internasional dengan memiliki Scopus ID: 58887618700, mengikuti kegiatan seminar dan workshop yang menunjang kompetensi dosen. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: dewisari.smg@gmail.com



Ns. Indra Tri Astuti, M.Kep., Sp.Kep.An Lahir di Tegal, 18 September 1978. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIII di Akademi Keperawatan Islam Sultan Agung (AKPERISSA) Tahun 1999, S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tahun 2003, melanjutkan Profesi Ners di Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tahun 2005 . Pendidikan S2 Keperawatan di Universitas Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2011 serta melanjutkan Program Spesialis Keperawatan di Universitas Indonesia lulus pada tahun 2012. Saat ini sedang melanjutkan Program Doktorat di Universitas Airlangga Surabaya. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2000 di AKPERISSA Semarang dan saat ini di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, mengampu mata kuliah Keperawatan Anak. Metodologi Keperawatan, Gizi dan Diet, Biostatistik, Dokumentasi Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: indra@unissula.ac.id
Motto: "Jadilah Versi Terbaik Dari Dirimu"



PROFIL PENULIS



Ns. Esa Rosyida Umam, S.Kep., M.Kep. Lahir di Nganjuk, 04 Desember 1992. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 dan profesi pada Program Studi Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners, Universitas Brawijaya tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Airlangga dan lulus tahun pada tahun 2019. Saat ini penulis bekerja di Program Studi D3 Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Jember Kampus Kota Pasuruan mengampu mata kuliah Keperawatan Maternitas. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: esarosyida.u@unej.ac.id
Motto: "Challenges exist to be faced, not avoided"



Sri Musfiroh, S.Si.T., M.Kes. Lahir di Grobogan, 05 Maret 1970. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 pada Program Studi Kebidanan Poltekkes Tasikmalaya dan lulus tahun 2005, kemudian melanjutkan ke jenjang D4 Program Studi Sarjana Sains Terapan Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju Jakarta dan lulus tahun 2007. Selanjutnya, penulis menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Respati Indonesia pada tahun 2013. Riwayat pekerjaan penulis dimulai setelah lulus D3 sebagai bidan praktik di berbagai fasilitas kesehatan dasar, kemudian bergabung sebagai tenaga pengajar di institusi pendidikan kesehatan. Saat ini penulis menjabat sebagai Rektor sekaligus dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon, mengampu mata kuliah Kesehatan Reproduksi & Keluarga Berencana (Kespro & KB), Kesehatan Dasar Pada Kehamilan (KDPK), serta Asuhan Kebidanan Persalinan & Bayi Baru Lahir. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengamalan Al-Islam Kemuhammadiyahan. Penulis telah menghasilkan berbagai penelitian di bidang kesehatan reproduksi remaja dan anemia gizi besi, serta aktif melakukan pengabdian masyarakat melalui edukasi kesehatan di sekolah-sekolah dan komunitas. Selain itu, penulis rutin mempublikasikan karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi, serta menulis buku dan modul pembelajaran untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: srimusfiroh052@gmail.com
Motto: "Menjadi manusia yang berguna untuk orang lain"

Sinopsis

Bunga Rampai Kesehatan Ibu, Anak, dan Remaja: Pendekatan Interprofesional untuk Indonesia Sehat 2045 menghadirkan kumpulan tulisan ilmiah dan praktis yang membahas isu-isu strategis kesehatan ibu, anak, dan remaja sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Buku ini menempatkan kesehatan sepanjang daur kehidupan sebagai prioritas, dengan menekankan pentingnya layanan yang terintegrasi, berkesinambungan, serta berorientasi pada mutu dan keselamatan.

Melalui perspektif kolaborasi lintas profesi, buku ini menguraikan berbagai pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang relevan dengan tantangan kesehatan saat ini, mulai dari kesehatan maternal dan neonatal, gizi dan stunting, tumbuh kembang anak, imunisasi, kesehatan mental dan psikososial, hingga kesehatan reproduksi dan perilaku berisiko pada remaja. Setiap bab menegaskan peran komunikasi efektif, koordinasi layanan, serta pengambilan keputusan bersama dalam tim interprofesional untuk menghadirkan pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan individu, keluarga, dan komunitas.

Buku ini ditujukan bagi mahasiswa dan dosen bidang kesehatan, tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan, pengelola program, serta pemangku kebijakan yang membutuhkan referensi komprehensif dan aplikatif. Dengan memadukan kajian ilmiah, praktik lapangan, dan gagasan inovatif, bunga rampai ini diharapkan menjadi sumber inspirasi dalam memperkuat sinergi layanan kesehatan ibu, anak, dan remaja, sekaligus mendukung percepatan pencapaian visi Indonesia Sehat 2045.

Bunga Rampai Kesehatan Ibu, Anak, dan Remaja: Pendekatan Interprofesional untuk Indonesia Sehat 2045 menghadirkan kumpulan tulisan ilmiah dan praktis yang membahas isu-isu strategis kesehatan ibu, anak, dan remaja sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Buku ini menempatkan kesehatan sepanjang daur kehidupan sebagai prioritas, dengan menekankan pentingnya layanan yang terintegrasi, berkesinambungan, serta berorientasi pada mutu dan keselamatan.

Melalui perspektif kolaborasi lintas profesi, buku ini menguraikan berbagai pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang relevan dengan tantangan kesehatan saat ini, mulai dari kesehatan maternal dan neonatal, gizi dan stunting, tumbuh kembang anak, imunisasi, kesehatan mental dan psikososial, hingga kesehatan reproduksi dan perilaku berisiko pada remaja. Setiap bab menegaskan peran komunikasi efektif, koordinasi layanan, serta pengambilan keputusan bersama dalam tim interprofesional untuk menghadirkan pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan individu, keluarga, dan komunitas.

Buku ini ditujukan bagi mahasiswa dan dosen bidang kesehatan, tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan, pengelola program, serta pemangku kebijakan yang membutuhkan referensi komprehensif dan aplikatif. Dengan memadukan kajian ilmiah, praktik lapangan, dan gagasan inovatif, bunga rampai ini diharapkan menjadi sumber inspirasi dalam memperkuat sinergi layanan kesehatan ibu, anak, dan remaja, sekaligus mendukung percepatan pencapaian visi Indonesia Sehat 2045.

ISBN 978-634-7556-46-2



Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

